Gjennomgang av organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen

Rapport

11. mars 2023

Innhold

Rapport 1
1 Innledning 5
1.1 Prosjektmandat 5
1.2 Avgrensninger og avhengigheter 6
1.3 Prosess og organisering av arbeidet 7
1.4 Leserveiledning 8
2 Bakgrunn 10
2.1 Dagens organisering 10
2.2 Etatenes ulike roller 14
2.3 Logikk for organisering 15
2.4 Kunnskapsproduksjon og forskning i forvaltningen 16
2.5 Vurderingskriterier 16
3 Endret organisering av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 19
3.1 Dagens ansvars- og oppgavefordeling 19
3.2 Bakgrunn for å vurdere organisasjonsendringer 20
3.3 Forslag til ny organisering 21
3.4 Vurdering 25
3.5 Konklusjon 26
4 Statens legemiddelverk som utgangspunkt for et direktorat for medisinske produkter 27
4.1 Dagens ansvars- og oppgavefordeling 27
4.2 Behov for navneendring 27
4.3 Bakgrunn for å vurdere organisasjonsendringer 28
4.4 Forslag til ny organisering 29
4.5 Konklusjon 35
5 Organisering av myndighetsoppgavene innen digitaliseringsområdet 36
5.1 Dagens ansvars- og oppgavefordeling 36
5.2 Bakgrunn for å vurdere organisasjonsendringer 36
5.3 Egen etat eller integrert i myndighetsorgan med ansvar for tjenesteutvikling 39
5.4 Konklusjon 41
6 Mer samlet forvaltning av helseregistrene 43
6.1 Dagens ansvars- og oppgavefordeling 43
6.2 Bakgrunn for å vurdere organisasjonsendringer 44
6.3 Alternativer for organisatorisk forankring 46
6.4 Konklusjon 48

7 Kunnskapsstøtte til og kompetansesentre for kommunal sektor 50
7.1 Dagens organisering av kompetansesentrene.....50
7.2 Bakgrunn.....51
7.3 Mulige løsninger for en mer samlet organisering 51
7.4 Konklusjon 55
8 Overføre oppgaver fra helseforvaltningen til de regionale helseforetakene.....57
8.1 Dagens ansvars- og oppgavefordeling 57
8.2 Bakgrunn for å vurdere organisasjonsendringer 57
8.3 Forslag til ny organisering 57
8.4 Konklusjon 58
9 Samordning av beredskapsansvar 60
9.1 Dagens ansvars- og oppgavefordeling 60
9.2 Bakgrunn for å vurdere organisasjonsendringer 60
9.3 Bedre samordning av helseberedskapen 62
9.4 Konklusjon 63
10 Videreutvikle departementets styring.....64
11 Andre problemstillinger som anbefales fulgt opp 65
11.1 Forskning i forvaltningen 65
11.2 Laboratorievirksomhet.....65
11.3 Statsforvalters rolle.....66
11.4 Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE).....67
11.5 Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO).....68
11.6 Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).....69
11.7 Felles tjenestesenter for helseforvaltningen (konsernmodellen) 69
11.8 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 70
11.9 Forum for faglig normering 71
12 Helhetlige modeller.....72
13 Gjennomføring av eventuelle organisasjonsendringer 77
13.1 Ansvar for videre oppfølging.....77
13.2 Kommunikasjon.....77
13.3 Økonomiske og administrative konsekvenser.....77
13.4 Endringer i lov- og forskrifter 78
13.5 Særskilt om arbeidsrettslige forhold og vurderinger.....78
13.6 Særskilt om lokalisering 80
Vedlegg 1. Utredninger og informasjonsgrunnlag 81

Vedlegg 2. Internasjonal sammenligning 84
Vedlegg 3. Sammenligning av den sentrale helseforvaltningen i Danmark og Norge" 85
Vedlegg 4. Tabell med oppgaver i Hdir og FHI 86

1 Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) besluttet 26.8.22 å etablere et prosjekt som skulle utføre en gjennomgang av deler av den sentrale helseforvaltningen. Prosjektet legger med dette frem forslag til fremtidig organisering. Anbefalingene er utarbeidet gjennom utredningsarbeidet til prosjektet og diskusjoner og beslutninger i styringsgruppen.

1.1 Prosjektmandat

Prosjektet fikk følgende mandat fastsatt av departementsråden 26. august 2022:

1. *Det etableres et prosjekt for gjennomgang av organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen. Hovedmålet er å bidra til effektiv ressursbruk og avklaring av roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen.*
2. *Arbeidet omfatter en kartlegging av nåværende arbeidsfordeling mellom etatene og mellom etatene og Helse- og omsorgsdepartementet. En slik kartlegging skal avdekke og redegjøre for delt ansvar eller uklare ansvarsforhold, ulik rolleforståelse og organisatoriske forhold som kan bidra til at ressursene ikke benyttes effektivt, herunder dublering av funksjoner, kompetanse og fora/utvalg. Arbeidet skal avgrenses til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. I tillegg skal grenseflater til kommunene, statsforvalterne, de regionale helseforetakene (RHFene) med underliggende foretak og Norsk helsenett SF beskrives der dette er relevant.*
3. *Prosjektet skal på bakgrunn av kartleggingen vurdere behovet for endringer i organisering, roller og ansvar hvor særlig digitaliseringsarbeid (herunder registre) og beredskapsrelaterte oppgaver (herunder smittevernarbeid og atomberedskap) skal vurderes. Videre skal prosjektet vurdere behov for avklaringer og endringer knyttet til etatenes øvrige oppgaveportefølje.*
4. *Ved behov gis det oppdrag til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om å bidra med informasjon, kompetanse og ressurser inn i arbeidet. I tillegg kan RHFene og Norsk helsenett SF konsulteres. Det samme gjelder kommuner og statsforvaltere.*
5. *Prosjektet skal utarbeide en rapport med forslag til organisatoriske tiltak som i størst mulig grad skal bidra til å eliminere dobbeltarbeid og avklare roller og ansvar, med mål om en hensiktsmessig og kostnadseffektiv organisering og arbeidsdeling mellom de nevnte underliggende virksomhetene og mellom virksomhetene og Helse- og omsorgsdepartementet. Behov for regelverksendringer, endringer i lov eller forskrift som følge av forslag om organisatoriske tiltak skal beskrives. Det bes om at prosjektet fremmer forslag om følgende;*
   - *Organisering, roller og ansvarsfordeling mellom etatene og mellom departementet og etatene med spesiell oppmerksomhet på digitaliseringsarbeid (herunder registre) og beredskapsrelaterte oppgaver (herunder smittevernarbeid og atomberedskap). Dette skal leveres i en første delrapport og legge grunnlag for andre prosjektarbeider i departementet.*
   - *Organisering, roller og ansvarsfordeling mellom etatene og mellom departementet og etatene knyttet til øvrig ansvars- og oppgavefordeling mellom etatene og*

mellom etatene og departementet hvor mulige endringsbehov er avdekket gjennom prosjektarbeidet. Dette skal beskrives i endelig rapport

6. *Prosjektet skal legge til grunn at foreslåtte endringer kan gjennomføres innenfor en uendret samlet budsjettramme.*
7. *Prosjektet skal se hen til ulike evalueringer av beredskapsarbeid i helsesektoren, herunder interne dokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet og rapporter fra Koronakommisjonen.*
8. *Prosjektledelsen skal løpende ha dialog med ledelsen i berørte etater og virksomheter i arbeidet.*
9. *Prosjektet har grenseflater mot andre prosjekter i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, herunder prosjekt som arbeider med stortingsmelding om helseberedskap. Prosjektleder skal delta i felles rapporteringsmøter med andre sentrale prosjekter i departementet for å sørge for koordinering med disse. Det skal rapporteres jevnlig fra arbeidet i prosjektet til en styringsgruppe som ledes av departementsråden.*
10. *Prosjektet vil bemannes med interne ressurser fra Helse- og omsorgsdepartementet i tillegg til en ekstern innleid prosjektleder og prosjektkoordinator. Videre vil det etableres et prosjektsekretariat. Det avholdes jevnlig møter med prosjektgruppen som består av én representant fra alle avdelinger i departementet.*
11. *Prosjektet skal innen medio september utarbeide en milepælsplan og kartlegge avhengigheter og grenseflater til andre sentrale prosjekter i Helse- og omsorgsdepartementet.*

Prosjektet skal levere en første og foreløpig rapport til departementsråden i Helse- og omsorgsdepartementet senest 31.12.2022. Endelig rapport skal leveres innen 15.02.2023.

Senere har prosjektet fått utsatt frist for leveranse av rapport fra arbeidet til primo mars 2023.

1.2 Avgrensninger og avhengigheter

En rekke virksomheter er ikke inkludert i gjennomgangen, inkludert: Bioteknologirådet, Eldreombudet, Mattilsynet, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), Norsk pasientskadeerstatning (NPE), Statens helsetilsyn (Htil) og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM).

Prosjektet må sees i sammenheng med erfaringer fra pandemihåndteringen og departementets pågående arbeid med flere stortingsmeldinger, inkludert Helseberedskapsmeldingen, Folkehelsemeldingen, Nasjonal helse- og samhandlingsplan, og med prosjektet for lovgjennomgang innen smittevern, folkehelse og helseberedskap. Rapporten viser til disse prosjektene og annet pågående arbeid der det er aktuelt.

Prosjektet for gjennomgang av sentral helseforvaltning konkluderer når rapporten legges frem for styringsgruppen og ved formell godkjennelse av departementsråden. På grunnlag av rapporten utarbeider departementet et politisk beslutningsnotat. Oppfølging og gjennomføring av beslutninger om eventuelle endringer og tiltak vil håndteres av et eget gjennomføringsprosjekt og følge de ordinære ansvarslinjene i HOD (se også kapittel 13).

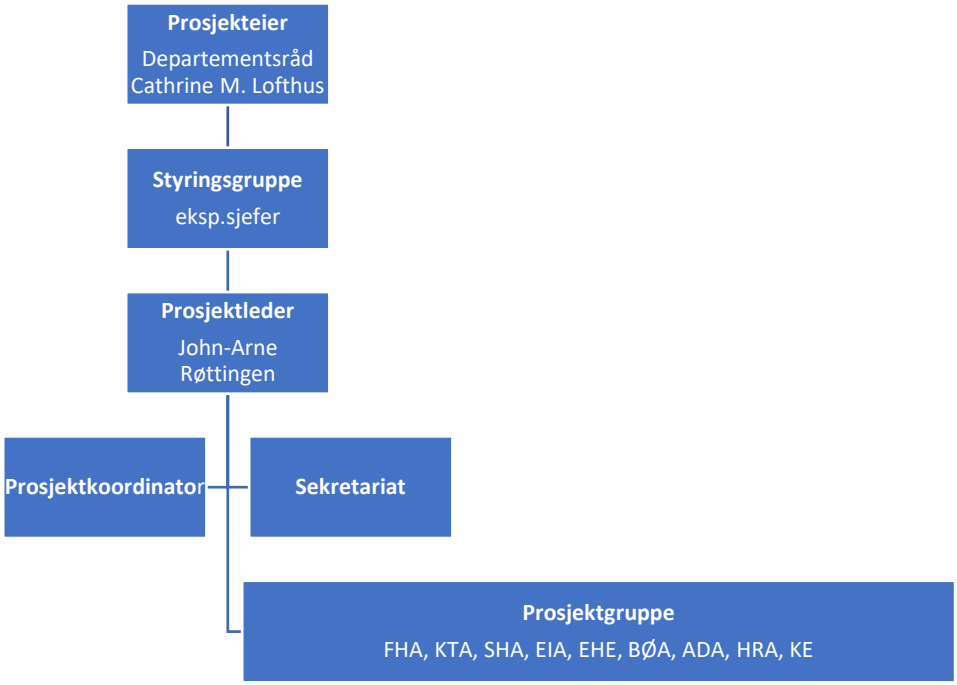
1.3 Prosess og organisering av arbeidet

Prosjektet er bemannet med interne ressurser fra HOD i tillegg til en ekstern innleid prosjektleder[1] og prosjektkoordinator. Sekretariatsfunksjonen ligger i Administrasjonsavdelingen i HOD og er bemannet med syv medlemmer fra ulike avdelinger i departementet.

Det har vært gjennomført løpende møter i sekretariatet og ukentlige møter i prosjektgruppen i prosjektperioden (september 2022 - mars 2023). Prosjektgruppen har bestått av representanter fra Folkehelseavdelingen (FHA), Kommunetjenesteavdelingen (KTA), Spesialisthelsetjenesteavdelingen (SHA), Eieravdelingen (EIA), E-helseavdelingen (EHE), Administrasjonsavdelingen (ADA), Budsjett- og økonomiavdelingen (BØA), Helserettsavdelingen (HRA) og Kommunikasjonsenheten (KE) i HOD. Prosjektleder har rapportert til styringsgruppen annenhver uke i prosjektperioden. Styringsgruppen består av ekspedisjonssjefene i departementet, i tillegg til kommunikasjonssjef, og ledes av departementsråden (prosjekteier). I tillegg til prosjektleders faste rapportering til prosjektgruppen, er det gjennomført åtte møter med prosjekteier og styringsgruppen for å drøfte bl.a. sentrale veivalg og alternative modeller.

Prosjektledelsen har hatt løpende dialog med ledelsen i berørte etater og virksomheter, både gjennom møter, intervjuer og oppdrag (se neste seksjon).

Figur 1.1: Prosjektorganisering.



[1] Departementet ble i slutten av januar kjent med at prosjektleder John-Arne Røttingen hadde permisjon fra en 20 % stilling ved FHI. Selv om ansvaret for å vurdere habilitet ligger på den enkelte, jf. fvl. § 8, foretok departementet en vurdering av om dette skulle få betydning for arbeidet med å ferdigstille rapporten. Rapporten skulle som utgangspunkt være ferdig den 15. februar. Etter en nærmere vurdering kom departementet til at det var hensiktsmessig å la prosjektet sluttføre rapporten, men at det skulle gjøres oppmerksom på dette forholdet i rapporten. Departementet har lagt vekt på at rapportens vurderinger skal godkjennes av en styringsgruppe som ledes av departementsråden og består av ekspedisjonssjefene i departementet og at denne bare skal inngå som en del av det beslutningsgrunnlaget som ligger til grunn for departementets videre interne saksbehandling av prosjektet. Videre er det lagt vekt på at de endelige beslutninger i saken skal fattes av regjeringen.

Informasjonsgrunnlag

Som informasjonsgrunnlag for prosjektets utredninger og anbefalinger er det innhentet (se vedlegg 1 for full oversikt):

- Skriftlige innspill (avdelingene i departementet, berørte etater, tilgrensende etater og virksomheter, pasientorganisasjoner og fagorganisasjoner).
- Dialogmøter og informasjonsmøter (berørte etater og tilgrensende etater og virksomheter, tillitsvalgte i de berørte etatene, andre departementer)
- Intervjuer (ledelsen i de berørte etatene og tilgrensende virksomheter, andre sentrale aktører)
- Møter med internasjonale aktører
- Utredning og gjennomgang av ulike evalueringer av beredskapsarbeid i helsesektoren, herunder interne dokumenter fra HOD, rapporter fra Koronakommisjonen og skriftlige innspill til arbeidet med Helseberedskapsmeldingen.
- Utredninger og gjennomgang av eksisterende saksgrunnlag, bl.a. rapporter fra tidligere forvaltningsgjennomganger.

Analyser og vurderinger som ligger til grunn for prosjektets endelige rapport er beskrevet i tre forrapporter, fem delrapporter og referat fra møter med styringsgruppen (se vedlegg 1).

Roller og ansvar: beslutningsprosesser

I prosjektperioden har prosjektleder og sekretariat vært ansvarlige for den daglige fremdriften i prosjektet i dialog med prosjektgruppen gjennom ukentlige møter. Dette har inkludert ansvar for å innhente informasjon, identifisere sentrale problemstillinger og utrede disse. Beslutningsgrunnlag, inkludert sentrale veivalg og alternative modeller, har blitt presentert for styringsgruppen.

Prosjekteier og styringsgruppen har tatt beslutninger om prosjektets omfang og retning, herunder hvilke organisasjonsmodeller som skal videreutvikles eller forkastes. Endelige anbefalinger i rapporten er besluttet av styringsgruppen.

I rapporten omtales «prosjektet» som en samlebetegnelse for prosjekteier, styringsgruppen, prosjektleder, prosjektgruppen og sekretariatet.

Rapporten er en endelig rapport og skal danne grunnlag for politisk beslutning. Rapporten har vært på en begrenset avdelingsforeleggelse og innspill fra foreleggelsen er søkt innarbeidet. I tillegg vil innspillene følge som et eget dokument. Rapporten og øvrig beslutningsgrunnlag er i utgangspunktet unntatt offentlighet.

1.4 Leserveiledning

Kapittel 2 inneholder en beskrivelse av dagens organisering og tidligere reformer av den sentrale helseforvaltningen. Prosjektets veiledende vurderingskriterier beskrives også her.

En rekker organisatoriske endringer har blitt vurdert av prosjektet og drøftes i **kapittel 3-10**. Kapitlene inkluder beskrivelse av dagens ansvar- oppgavefordeling, bakgrunn for å vurdere organisasjonsendringer og konklusjoner med prosjektet anbefalinger.

En rekke problemstillinger er identifisert som enten ligger utenfor prosjektets mandat eller av andre grunner bør bli håndtert utenfor prosjektet eller som del av et gjennomføringsprosjekt. Disse omtales i **kapittel 11**.

I **kapittel 12** drøftes helhetlig modeller og anbefalinger som skal sikre at departementets totale behov blir ivaretatt ved en eventuell organisasjonsendring. Alternativer som legges frem i kapittel 3 (Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet), kapittel 5 (myndighetsoppgaver innen digitaliseringsområdet) og kapittel 6 (samlet forvaltning av helseregistrene) blir vurdert i lys av dette.

Prosjektets forslag til videre oppfølging og gjennomføring av eventuelle organisasjons-endringer beskrives kortfattet i **kapittel 13**.

2 Bakgrunn

2.1 Dagens organisering

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for å sikre befolkningen fra helsetrusler, fremme folkehelse og at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.[2] De fem etatene som er direkte berørt av prosjektet utgjør den største delen av den sentrale helseforvaltningen og består samlet av nærmere 3000 årsverk.

Internasjonalt er det mest naturlig å sammenlikne organiseringen av forvaltningen med de Nordiske landene. Se vedlegg 2 for internasjonal sammenlikning av organisering i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Storbritannia, Nederland, Frankrike og Tyskland. De skandinaviske landene har alle større fagdirektorater, mens Finland har en modell med et samlet folkehelse- og helsetjenesteinstitutt med gjennomføringsansvar. De andre landene har i stor grad direktoratsoppgavene lagt til departementene. Alle landene har egne smitteverninstitutter eller har dette integrert i et større institutt eller fagdirektorat.

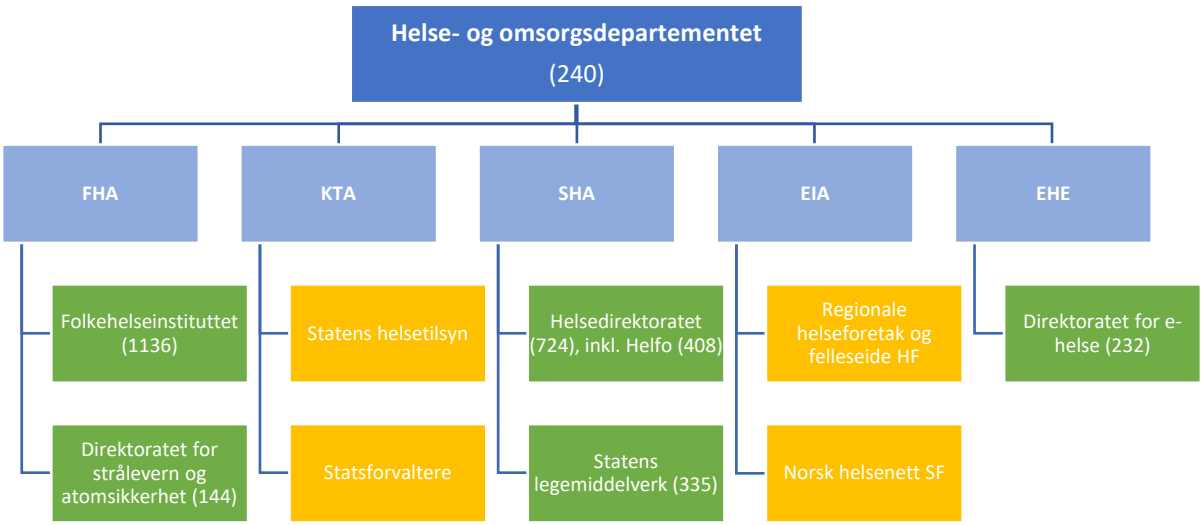
Paralleller mellom organiseringen av sentral helseforvaltning i Norge og Danmark er nærmere detaljert i vedlegg 3 og vedlegg 4.

Tabell 2.1: Oversikt over antall årsverk og lokalisering per virksomhet (innrapporterte tall fra etatene per januar 2023. NB. tallene er usikre).

Etat	Årsverk	Lokalisering
Helsedirektoratet (Hdir)	724	Oslo, Trondheim
Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)	408	Tønsberg
Folkehelseinstituttet (FHI)	1136	Oslo, Bergen, Levanger
Statens legemiddelverk (SLV)	335	Oslo
Direktoratet for e-helse (Dir. e-helse)	232	Oslo, Trondheim, Tynset
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)	144	Oslo, Svanvik, Tromsø
Totalt:	**2979**	

[2] Departementet har ansvar innenfor følgende hovedområder: folkehelse, kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester, tilbud til personer med psykiske helse-problemer, tjenester til personer med rusproblemer, habilitering og rehabilitering, tannhelsetjenester, ernæring og mattrygghet, alternativ behandling, legemidler, helsemessig beredskap, pasientrettigheter og bioteknologi.

Figur 2.1: Dagens organisering av den sentrale helseforvaltning, begrenset til berørte etater og tilgrensende virksomheter (antall ansatte i parentes, kilde: HOD og innrapporterte tall fra etatene per januar 2023. NB. tallene er usikre).



I løpet av de siste 20 årene er det gjennomført to større reformer av helseforvaltningen i Norge (2001-2002 og 2015-2016). Dagens modell er preget av prinsippene som lå til grunn for disse prosessene.

2001

Hovedmålet for omorganiseringen i 2001 var å samordne funksjoner, og å samle og styrke kompetansemiljøer. Det ble også overført oppgaver fra departementet til etatene. Behovet for endring i organisering horisontalt (mellom etater) ble særlig begrunnet med brukerperspektivet (flere etater og overlappende funksjoner) og at tilsynsvirksomheten var lite samordnet. Kompetansebehovet var viktig, både mtp. å skaffe og bruke kunnskap for å sørge for effektiv bruk av offentlige midler, og for å styrke kompetansen i forvaltningen.

Omorganiseringen resulterte i tre etater med hovedoppgaver innen henholdsvis tilsyn, utøvende oppgaver og forskningsrettet kunnskapsutvikling. Alle tre skulle ha rådgivnings- og formidlingsoppgaver, internasjonalt arbeid og beredskap. Sosial- og helsedirektoratet skulle ha overordnet ansvar for oppgaver knyttet til iverksetting av tiltak, rådgivning og formidling. For Folkehelseinstituttet (FHI) ble det presisert at kjerneoppgaver innen epidemiologi, smittevern og miljømedisin skulle være forskning, overvåkning, beredskap og rådgivning.

I høringsbrevet ble det pekt på tre store problemstillinger som det måtte arbeides videre med:

1. Gråsoner mellom etatenes rådgivningsoppgaver, myndighetsoppgaver innen smittevern og miljømedisin, grensen mellom kunnskapsmiljøer innenfor og utenfor forvaltningen, og godkjenning av innsatsfaktorer (tilsyn versus direktorat).

2. Behov for gjennomgang av sentrale metode- og kunnskapsmiljøer for å styrke kunnskapsbasert praksis for bruk av virkemidler, tiltak, behandling og praktisk politikk.
3. Forankring av beredskapsoppgaver.

Punkt to fikk den mest konkrete oppfølgingen gjennom etablering av en divisjon for kunnskapshåndtering i Sosial- og helsedirektoratet. Denne divisjonen ble senere (fra 2004) utskilt som en underliggende etat (Kunnskapssenteret) og slått sammen med to eksterne miljøer.

2015

Målet for arbeidet var å vurdere tiltak for å redusere den totale ressursbruken til administrative tjenester og funksjoner i helseforvaltningen, tiltak for å forenkle og effektivisere departementets styring, og tiltak for å sikre bedre rolleklarhet og mer hensiktsmessig arbeidsdeling mellom forvaltning, tilsynsvirksomhet og kunnskapsproduksjon.

Forslaget innebar en rendyrking av hovedmodellen for forvaltningen fra 2001, men med en klar funksjonsdeling mellom forvaltning/myndighet, kunnskapsproduksjon og tilsyn. Helsedirektoratet (Hdir) fikk flere direktoratsoppgaver, en sterkere faglig normerende rolle og et helhetlig ansvar for beredskap.

FHI fikk en styrket posisjon innen kunnskapsproduksjon og et nytt ansvar og samfunnsoppdrag som kunnskapsleverandør for helsetjenesten ved at hovedtyngden av Kunnskapssenteret ble flyttet til FHI. Et viktig moment var at forskere i Kunnskapssenteret ikke skulle arbeide i Hdir, da direktoratet ikke skulle drive med forskning. Dette førte til et større og mer helhetlig ansvar for kunnskapsinnhenting og kunnskapsoppsummering i FHI..

I 2017 gjennomførte departementet en detaljert grenseoppgang mellom Hdir og FHI innen samtlige gråsoner, med unntak for smittevernarbeidet. Grensedragningen innen smittevernområdet ble utsatt til arbeidet med ny smittevernlov. HOD sendte i 2017 et eget fellesbrev til Hdir og FHI om konklusjonene knyttet til de gråsonene hvor det i utgangspunktet var uklarheter om ansvar og roller.

Videre ble det i 2017 etablert en konsernmodell med sentralisering av administrative funksjoner som anskaffelser, IKT og informasjonsforvaltning/arkiv for alle underliggende etater i et felles tjenestesenter i Norsk helsenett SF (NHN). Alle etater i den sentrale helseforvaltningen tok da også i bruk Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØs) fullservicemodell for lønn, regnskap og reiseadministrasjon.

Direktoratet for e-helse (E-helse) ble etablert fra 2016 etter en utskillelse fra Hdir. Det har vært noen endringer i rolledelingen mellom E-helse og NHN siden etableringen.

Statens strålevern ble lagt inn som egen etat under Hdir, men ble skilt ut som et eget Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) fra 2018. DSA har blitt videreført med myndighetsoppgaver og tilsynsoppgaver innen sitt fagfelt, samt at de bidrar i enkelte prosjekter/internasjonalt arbeid knyttet til kunnskapsproduksjon.

Nåsituasjonen

Dagens helseforvaltning er forankret i organisasjonsendringer som ble iverksatt 1. januar 2016 og som bygger på en tredeling av roller: i) myndighetsrolle og gjennomføringsoppgaver; ii) kunnskapsproduksjon; og iii) tilsynsfunksjon. En slik tredeling

skulle både effektivisere forvaltningen og sikre tilstrekkelig uavhengighet mellom de ulike funksjonene. Prosjektet mener at en slik tredeling fremdeles er relevant som en prinsipiell rolledeling, men påpeker at dette ikke er gjennomført konsekvent i praksis. Mye av vurderingen omhandler hvilke etater som bør inneha hvilke roller, og om ulike etater kan ha en eller flere roller samtidig. I dagens organisering har Statens legemiddelverk (SLV) og DSA både myndighetsoppgaver og tilsynsoppgaver, samt i mindre grad kunnskapsproduksjon, innen sine fagfelt. I Hdir og FHI finner man en annen inndeling. Hdir har først og fremst en myndighets- og en gjennomføringsrolle, og omfatter mer tradisjonelle forvaltningsoppgaver, mens FHI har en kunnskapsrolle, men med enkelte myndighetsoppgaver og en rekke gjennomføringsoppgaver innen smittevernområdet[3]. Htil er en rendyrket tilsynsmyndighet, men er ikke omfattet av gjennomgangen.

Evalueringsarbeid viser at arbeidsdelingen stort sett fungerer godt, men at det er flere områder i forvaltningen som har forbedringspotensiale. En gjennomgang og klargjøring av rollene, ansvaret og myndigheten til nasjonale myndigheter, statsforvaltere og kommuner i en krisesituasjon ble også anbefalt av Koronakommisjonen for å sikre best mulig samvirke, jf. NOU 2022:5 punkt 12.5. Her kommer det bl.a. frem at «Rollefordelingen mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har som nevnt vært gjenstand for diskusjon og avklaring gjennom mange år. Rolleforståelsen var likevel uklar den første delen av 2020, og det tok tid for Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet å rendyrke rollene som henholdsvis myndighetsutøver og smittevernfaglig kunnskapsleverandør. Kommisjonen mener det er hensiktsmessig å skille mellom disse to rollene, slik også smittevernloven gjør. Slik sett mener vi at rollefordelingen mellom direktoratet og Folkehelseinstituttet i hovedsak er hensiktsmessig. Det er fornuftig at myndighetene på smittevernområdet ligger til et forvaltningsorgan som har bredt myndighets- og beredskapsansvar, slik Helsedirektoratet har».

Norge har også vært gjennom store endringer siden dagens organisering av sentral helseforvaltning ble iverksatt. Samfunnsutviklingen har vært og er preget av usikkerhet, både i møte med plutselige og uforutsette kriser som koronapandemien og krig i Europa, men også den demografiske utviklingen med eldrebølge og strammere økonomiske rammer med økt behov for prioritering av ressurser.

Forvaltningsgjennomgangen gjennomføres som svar på endringer i omgivelsene, nye prioriteringer, behov for nye rolleavgrensninger og for å sikre bedre styring og effektivisering av ressursbruken. I tillegg til et mål om en mer ressurseffektiv forvaltning, har prosjektet som mål å bidra til de helsepolitiske målene innen folkehelse, likeverdige og tilgjengelige tjenester, bedre kvalitet og pasientsikkerhet, effektiv samhandling og gode pasientforløp, samt god tillit. Viktige utviklingstrekk som teknologiutviklingen inkludert digitalisering og utnyttelse av helsedata, demografiske endringer, sentralisering og mangel på kompetent arbeidskraft, samt krevende økonomiske rammer vil være premisser som forvaltningen må håndtere i årene som kommer. I denne konteksten mener prosjektet at det er viktig å organisere helseforvaltningen med mål om en styrket helseberedskap og mer støtte til kommunal sektor.

[3] Forskrift om skadedyrbekjempelse - Lovdata, Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - Lovdata, Forskrift om tuberkulosekontroll - Lovdata, Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven] - Lovdata

2.2 Etatenes ulike roller

Alle de fem berørte etatene i gjennomgangen kan defineres som fagdirektorater. Prosjektet har tatt utgangspunkt i den generelle beskrivelsen av fagdirektoraters roller og oppgaver i tillegg til forarbeider for ny forvaltningslov[4]. Direktorater har to hovedroller – fagrollen og iverksetterrollen. Prosjektet har valgt disse kategoriene:

- Iverksettende roller
  - Myndighet
    - Tilsyn
    - Lovfortolkning, forvaltning av regelverk, forskrifter og rundskriv, enkeltvedtak, godkjenninger
    - Forvaltning av autorisasjonsordninger
    - Refusjoner, tilskuddsforvaltning
  - Gjennomføring av politikk
    - Løpende sektorpolitikk, oppfølging av kampanjer, handlingsplaner og strategier
    - Finansieringsordninger
    - Tjenesteyter, laboratorietjenester, registerdrift, innkjøp/lager
- Faglige roller
  - «Følge med»-ansvar
    - Overvåkning
    - Statistikk og analyser
  - Rådgivning til departement
  - Rådgivning til tjenestene og kommunene
  - Kunnskapsroller
    - Analyser av data og statistikk
    - Kunnskapsoppsummering, metodevurdering/HTA
    - Forskning
    - Formidling av forskning og kunnskapsoppsummeringer

Alle etatene har et ansvar for å gi råd oppover til departementet og til andre etater. Innen helseforvaltningen har den faglige rådgivningen ut mot tjenestene, helsepersonell og kommunene fått en særlig rolle og lovmessig forankring ved at Hdir har et nasjonalt normerende ansvar gjennom å gi ut nasjonale retningslinjer og andre normative dokumenter. Denne utadrettede rådgivningen kan derfor også ansees å være en myndighetsfunksjon. Andre etater gir også råd til tjenestene uten at denne rådgivningen har den samme lovforankringen og dermed ikke den samme nasjonale normerende funksjonen.

I vurderingen av ulike alternativer for rolledelingen mellom Hdir og FHI har prosjektet benyttet en forenklet kategorisering av funksjonene. Her er tilsynsoppgaver utelatt, og nasjonale normerende produkter er lagt under myndighetsfunksjonen. Gjennomføringsoppgaver, følge med-ansvar og overvåkning er samlet i én kategori da prosjektet vurderer at det er naturlig at disse hører sammen, mens kunnskapsrollene er delt i to kategorier med registeranalyser og

[4] Direktoratsrollene basert på: NOU 2019: 5 - Ny forvaltningslov, Direktoratenes rolle i statens styring av kommunene | DIFI 2013:14, Direktoratenes rolle i statens styring av kommunene | DIFI 2012:6, Merverdi eller unødig omvei? Om direktoratenes rolle i gjennomføringen av nasjonal politikk | DIFI 2013:11 og Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press? | DIFI 2008:14

statistikk (dels som grunnlag for følge med/overvåke) og kunnskapsoppsummeringer og forskning.

Figur 2.2: Roller og funksjoner i forvaltningen.

Overordnet rolle	Roller	Funksjoner	Forenklet kategorisering
Iverksetter	Myndighet	Lovfortolkning, regelverk	**Myndighet** **Normer** **Krav**
		Tilskudd, godkjenning	
		Refusjons- og finansieringsordninger	
		Faglig normering	
	Gjennomfører	Sektorpolitikk, kampanjer, planer, strategier	**Gjennomfører** **Følge med/overvåke** **Rådgivning**
		Tjenesteyter	
Faglig	Følge med	Vurdere statistikk og analyser	
		Overvåkning	
	Rådgivning	Løpende faglig rådgivning	
	Kunnskap	Analyser av statistikk	**Registeranalyser** **Statistikk**
		Kunnskapsoppsummering Forskning	**Kunnskapsoppsummering** **Forskning**

2.3 Logikk for organisering

Prosjektets kartlegging har tydeliggjort flere områder med uklar, overlappende og/eller manglende ansvars- og rollefordeling og forståelse. Det er også identifisert områder der organisasjonsendringer kan være et viktig virkemiddel for mer effektiv ressursutnyttelse, bedre styring og måloppnåelse. Utfordringer knyttet til de enkelte virksomhetene drøftes i påfølgende kapitler.

Overordnet viser prosjektet til følgende problemstillinger og prinsipielle utfordringer:

- Generelt har Hdir hatt myndighetsrollen og FHI har vært en kunnskapsprodusent, mens begge institusjoner har hatt ulike ansvar innen gjennomføring/overvåkning og analyser/statistikk. Likevel har FHI i dag enkelte myndighetsoppgaver innen smittevern, og det er overlappende funksjoner innen følge-med-rollen og knyttet til faglig rådgivning. Samtidig har man valgt å organisere enkelte etater tematisk med et mer helhetlig ansvar innenfor et fagområde, både uten (E-helse) og med integrert tilsynsfunksjon (DSA og SLV. I disse etatene er det imidlertid mer avgrenset kunnskapsfunksjoner og ikke egen forskningsaktivitet. Samtlige etater kan defineres som direktorater utfra DFØ sin generelle beskrivelse.
- Prosjektet mener det er behov for å tydeliggjøre hvilken organiserende logikk eller organisatorisk inndeling som skal legges til grunn for ny organisering av forvaltningen, dvs. om det skal være inndeling utfra roller, tematisk/faglig inndeling, eller ulike modeller for ulike fagområder. Eventuelle unntak bør begrunnes og tydeliggjøres. Det er fordeler og ulemper ved alle tilnærminger som beskrives nærmere i rapporten.

2.4 Kunnskapsproduksjon og forskning i forvaltningen

Overordnet viser prosjektet også til noen vurderinger knyttet til kunnskapsrollen i forvaltningen:

- Uavhengig forskning i forvaltningen sikres i dag dels gjennom rolledelingsprinsippet. Skillet skal bidra til uavhengig kunnskapsproduksjon og mer åpenhet om vurdering og beslutningsprosesser, men kan gi gråsoner mellom ulike former for rådgiving (faglige råd vs. formell normering) og i overgangen mellom kunnskapsprodusenten og etaten(e) med myndighetsrolle. Prosjektet vurderer at faglig uavhengighet og akademisk frihet med hensyn til hvordan forskningen gjennomføres kan sikres og formaliseres gjennom instruks eller vedtekter og legger derfor prinsipielt til grunn at alle etatene *kan* drive med forskning dersom dette er i tråd med samfunnsoppdraget.
- Videre følger spørsmålet om hvordan man styrer forskningen for å sikre at kunnskapsproduksjonen er relevant og til nytte for forvaltningen. Kunnskapsproduksjonen må være uavhengig. Samtidig må den også kunne styres utfra myndighetenes og tjenestenes behov. Et skille mellom kunnskapsproduksjon og myndighetsoppgaver tilrettelegger for og synliggjør uavhengighet og åpenhet om vurdering og bruk av kunnskapsgrunnlaget. Et helhetlig ansvar kan i større grad legger til rette for styring og prioritering av kunnskapsproduksjon, siden etatene da mer direkte også er brukere av kunnskapen. Samtidig vil også departementet ha behov for styring og prioritering av kunnskapsproduksjon for beslutninger og politikkutvikling. Se også seksjon 11.1 for anbefaling om en videre vurdering av hvilken type forskning forvaltningen har behov for.
- Forskningsaktivitet kan være rammefinansiert eller finansiert etter utlysning og konkurranse. Temaene kan være forskerinitierte eller oppdragsgiverinitierte. Prosjektet ønsker å klargjøre rammene for forskning i helseforvaltningen. For det første bør ikke etatene drive forskerinitiert forskning finansiert over grunnbevilgningen. Dette gjøres i UH-sektoren og instituttsektoren. Forskningen finansiert innenfor budsjettet i helseforvaltningen må være anvendt/ behovsbasert forskning relatert til konkrete oppdrag eller til samfunnsoppdraget, og den må overordnet være initiert av etaten som organisasjon og ikke som et resultat av enkeltforskeres interesseområder. Forskningen må kunne synliggjøres økonomisk adskilt fra øvrige forvaltningsoppgaver. Etatene bør kunne søke om forskningsmidler i konkurranse med andre forskningsinstitusjoner, men i begrenset omfang, innenfor det overordnede samfunnsoppdraget og ikke slik at det er en for vesentlig del av etatens totale aktivitet (eksempelvis, utgjør ekstern finansiert forskning rundt 15% av FHI sin aktivitet).
- Forvaltningen kan selv konkurranseutsette forskningsoppdrag og dermed være oppdragsgiver, men bør ikke konkurrere om midler utlyst som oppdragsforskning. Et viktig unntak er internasjonale oppdrag fra EU eller andre. Dersom andre departementer eller offentlige institusjoner ønsker å benytte forskningsmiljøer i helseforvaltningen til å gjennomføre forskning eller en forskningsbasert utredning, vil de kunne gjøre dette gjennom å gi oppdraget direkte i samforståelse med HOD og dermed ikke utlyse oppdraget.

2.5 Vurderingskriterier

Organiseringen av forvaltningen skal legge til rette for å få mest mulig ut av fagmiljøene på en mest mulig effektiv måte. Formålseffektivitet, herunder kvalitet i leveranser, skal sikres på en kostnadseffektiv måte. Organiseringen skal også gi fleksibilitet og omstillingsevne, og

beredskap for kriser. En god og tydelig avklaring av ansvar og roller er et virkemiddel for å oppnå god formålseffektivitet, styrket helseberedskap og bedre støtte til kommunal sektor. Samtidig må det unngås å gjøre endringer med store omstillingskostnader og usikkert gevinstpotensiale, eller endringer med stor risiko for svekket formålseffektivitet. God og riktig kompetanse og rekruttering i helseforvaltningen er nødvendig for å oppnå de ønskede gevinstene.

Prosjektet har tatt utgangspunkt i fem veiledende vurderingskriter:

1. **Bærekraft og formålseffektivitet**
   Virksomhetene bør være organisert på en hensiktsmessig måte for å svare på dagens utfordringsbilde, men også være fremtidsrettet og rigget for å tilpasse seg fremtidige nasjonale og internasjonale samfunnsutfordringer og muligheter. Disse kan være knyttet til teknologi, økonomiske forhold og øvrig organisering. Valg av organisasjonsmodell skal være best mulig egnet til å ivareta oppgaver og behov innen de ulike fagområdene. Det innebærer at en omorganisering skal bidra til at prioriterte oppgaver og kjerneoppgaver blir løst på en kvalitativ god måte som møter brukerbehov, samtidig som ny organisering også skal være funksjonell for å møte utfordringene knyttet til ressursknapphet (kompetanse, teknologi). Spesialkompetanse og sårbare fagmiljøer som ikke finnes utenfor sentralforvaltningen må ivaretas og tillegges vekt, herunder også behovet for å sikre attraktive arbeidsplasser og god kompetanse i forvaltningen. Organiseringen skal også bidra til fleksibilitet, omstillingsevne og kvalitet i leveranser for å være bærekraftig og formålseffektiv.
2. **Rolleklarhet og helhetssyn**
   Organiseringen av helseforvaltningen må ha klare og forutsigbare ansvarsforhold og etater må ha tydelig mandat og oppgaver for å bidra til å oppnå målene som er beskrevet i de andre vurderingskriteriene. Dette er også avgjørende i en beredskapssituasjon og ikke minst overfor kommunene som er avhengige av kunnskap, råd og støtte i mange sammenhenger.
3. **Bedre støtte til kommunal sektor**
   Organisering av sentral helseforvaltning bør bidra til bedre støtte til kommunal sektor. Prosjektet har vektlagt behovet for kunnskapsstøtte med mål om at kommunal sektor skal kunne ta kunnskapsbaserte beslutninger og iverksette lokalt tilpassede tiltak, både i helse- og omsorgstjenestene og i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet. Beslutninger skal ta bygge på oppdatert kunnskap om hva som virker i hvilken kontekst, samt være kostnadseffektive.
4. **Styrket helseberedskap**
   Alle anbefalinger skal vurderes fra et beredskapsperspektiv og organisasjonsendringer som kan styrke helseberedskapen skal vektlegges (jf. funn i Koronakommisjonens rapporter og annet evalueringsarbeid). Organisasjonsendringer skal ta høyde for de grunnleggende prinsippene for beredskap og krisehåndtering.[5] Beredskapsprinsippene

[5] I samfunnssikkerhetsinstruksen (2017) er de fire prinsippene definert slik:
1) *Ansvarsprinsippet* som innebærer at den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, også har ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området.
2) *Likhetsprinsippet* som betyr at den organisasjon man opererer med under kriser i utgangspunktet skal være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig.

forutsetter en organisering i normalsituasjon som er egnet til å håndtere raske endringer med økt belastning. Tilgang til kunnskap er avgjørende i kriser.

5. **God ressursutnyttelse**
   Organisasjonsendringer bør resultere i kostnadseffektivitet og skal vurderes opp mot eventuelle omstillingskostnader og risiko. Relevante nyttevirkninger inkluderer bl.a. mer effektive styringssystemer (tidsbesparelser, økt tillit), samordning og effektivisering, samlokalisering (styrket fagmiljø, stordriftsfordeler, synergieffekter og andre ringvirkninger), rene kostnadsbesparelser, personellmessig ressursbesparelse og økt produktivitet.

Vurderingskriteriene er ikke alltid forenlige i praksis. I prosjektet er det foretatt avveiinger og kompromisser mellom kriteriene. Rapporten forsøker å tydeliggjøre tilfeller der slike avveininger er tatt.

De berørte virksomhetene er også ulike med tanke på størrelse, samfunnsoppdrag og organisatoriske utfordringer. Vurderingskriteriene er derfor veiledende og må vektes ulikt og utfra kontekst.

Prosjektet viser også til vurderingskriteriene som ble brukt i 2015-reformen[6], og stortingsmeldingen om forvaltningspolitikk (*St. meld. nr. 19 2008-2009 Ei forvaltning for demokrati og fellesskap*).[7]

3) *Nærhetsprinsippet* som betyr at kriser organisatorisk skal håndteres på lavest mulig nivå.
4) *Samvirkeprinsippet* som betyr at myndigheter, virksomheter eller etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

[6] DFØ (2008) «Omstilling av statlige virksomheter. Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader»; DFØ (2014) «Veileder i økonomiske analyser»; DFØ (2011) «Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen».

[7] I stortingsmeldingen om forvaltningspolitikk (St. meld. nr. 19 2008-2009 Ei forvaltning for demokrati og fellesskap) ble det fastsatt et sett med ni prinsipper som skal ligge til grunn for organisering av statlig virksomhet. Anbefalingene i rapporten er i tråd med disse prinsippene. Stortingsmeldingen foreslår en rekke av vurderingsmomentene som må gjennomgås og utredes for å sikre best mulig måloppnåelse i forbindelse med organisering og omstilling. Disse spørsmålene har blitt vurdert og inngår i prosjektets utredninger og danner grunnlaget for anbefalinger i rapporten.

3 Endret organisering av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

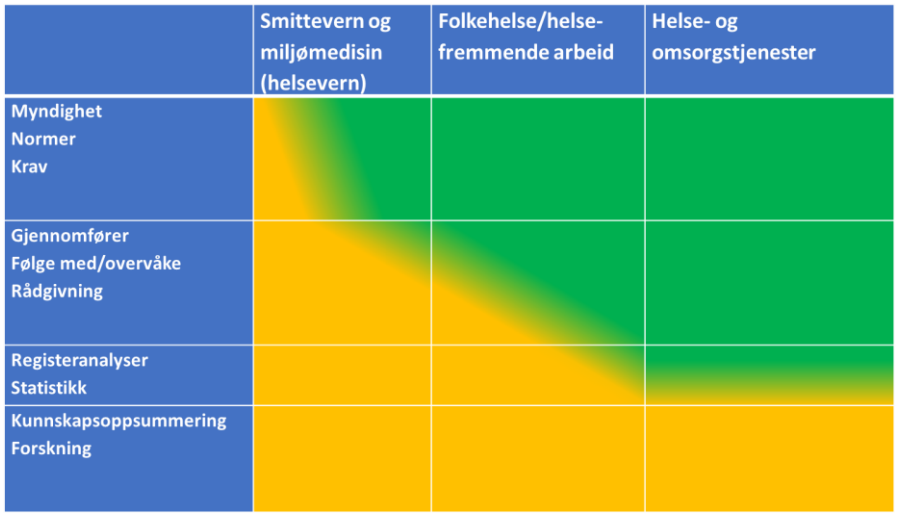
3.1 Dagens ansvars- og oppgavefordeling

Dagens organisering inkluderer to etater med til sammen omtrent 2000 ansatte (ekskl. Helfo) hvor Hdir primært har myndighetsoppgaver og FHI kunnskapsoppgaver. Samtidig er grenseflatene ikke entydige for de ulike fagområdene, spesielt innen smittevern, noe som gjør at helseforvaltningen ikke alltid oppleves som enhetlig og koordinert. Arbeid med samme fagområder i to etater gir risiko for dublering og dermed også mulighet for effektivisering hvis det gjennomføres endringer. Det er imidlertid ikke slik at overlappende fagområder alltid medfører dobbeltarbeid og dublering av funksjoner og kompetanse så lenge det er en fornuftig arbeidsdeling og god dialog mellom etatene, samt god etatsstyring fra departementet. Samtidig er det viktig at arbeidsdelingen er fornuftig og godt definert, slik at ressursene brukes mest mulig optimalt og kompensatoriske tiltak unngås.

Det er pekt på behov for avklaring av roller og ansvar både i interne og eksterne gjennomganger, spesielt innen smittevern, herunder av Koronakommisjonen (se kap. 2.1.1). Det er derfor behov for at den sentrale helseforvaltningen fremstår som mer samlet og taler med én tydelig stemme, spesielt i krisesituasjoner hvor det er behov for klare, enhetlige råd og anbefalinger.

I et brev fra HOD til Hdir og FHI fra 2017 beskrives noe av rolledelingen. Her står det at «Folkehelseinstituttet driver bl.a. med forskning. Helsedirektoratet er et myndighetsorgan og skal ikke drive med forskning». Videre ble det skilt mellom analyser/statistikk som har hovedtyngden rettet mot helse- og omsorgstjenesten (Hdir) og mot helsetilstand/ sykdomsbyrde (FHI). Samlet sett ga HOD sine føringer for etatenes roller og ansvar hvor dette dermed varierte på tvers av områdene smittevern og miljømedisin; helsefremmende arbeid/folkehelse; og helse- og omsorgstjenester. Figuren under viser nåsituasjonen med de noe uklare grenseflatene.

Figur 3.1: Dagens oppgavefordeling mellom Hdir og FHI.



De ulike oppgavene som Hdir og FHI utfører i dag er beskrevet for de ulike fagområdene i et eget vedlegg (se vedlegg 5).

3.2 Bakgrunn for å vurdere organisasjonsendringer

Som omtalt over er det pekt på behov for avklaring av roller, ansvar og oppgavedeling, spesielt innen smittevern, mellom Hdir og FHI. Dette er også et gjennomgående tema i innspillene til forvaltningsgjennomgangen. Den sentrale helseforvaltningen må fremstå som mer samlet, spesielt i krisesituasjoner hvor det er behov for klare råd og anbefalinger.

For å oppnå en god og formålstjenlig organisering av de samlede oppgavene og kompetansen i Hdir og FHI er det to sentrale hensyn som må ivaretas; en samling av fagmiljøer for å gi effektive arbeidsprosesser med høy kvalitet, og et skille mellom myndighetsfunksjoner og kunnskapsfunksjoner for å sikre uavhengighet og åpenhet om kunnskapsgrunnlaget. Disse hensynene vil måtte vurderes utfra flere perspektiver. Det kan f.eks. være hensiktsmessig å samle juridiske miljøer med erfaring med regelverksfortolkning og myndighetsutøvelse, eller forskningsmetodemiljøer, på tvers av de helsefaglige områdene, mens det samtidig kan være hensiktsmessig å samle miljøer som har ansvar for et fagområde fra kunnskap til gjennomføring – spesielt om det er et lite fagområde.

I dagens organisering er fagområdene ulikt organisert mht. denne logikken. Det skyldes til dels at arbeidsformer og leveranser er ulike, men det er også et resultat av tradisjoner, videreføring av miljøer i nye organisasjoner og tidligere organisasjonsendringer. Dermed har dagens organisering også ulik skillelinje mellom myndighet/gjennomføring og kunnskap innenfor ulike fagområder.

I alle organisasjoner er det etablerte verdikjeder hvor ulike kompetanser og oppgaver er vevd sammen for å skape en best mulig helhet for å løse virksomhetens oppgaver. Graden av sammenveving vil variere både ut fra tradisjoner og oppgavens art. Smittevernfeltet, og til dels miljømedisin, er et område hvor mange av arbeidsoppgavene er sammenvevd. Det skyldes bl.a. et behov for å kunne oppdage, analysere, og håndtere hendelser på kort tid, slik som ved utbruddsoppklaring. Et annet moment er hvor ekspertkompetansen ligger. For helse- og omsorgstjenestene ligger den faglige kompetansen primært i tjenestene. Helseforvaltningens arbeid dreier seg i stor grad om å følge med, utvikle og styre helsetjenestene, men helseforvaltningen har også behov for å kunne bruke denne kompetansen til deler av arbeidet sitt. Innen folkehelse ligger ekspertkompetansen først og fremst i forvaltningen selv, og kunnskap er et sentralt virkemiddel for å støtte gjennomføring av tverrsektorielt helsefremmende arbeid. Det samme gjelder dels for smittevern, men innen dette fagområdet er det er ekspertkompetanse også i sykehusene, bl.a. de fire regionale kompetansesentrene for smittevern. Slike forhold har også påvirket organiseringen av den sentrale helseforvaltningen.

Prosjektet beskriver her nåsituasjonen og foreslår en hovedmodell (modell A). I tillegg er det beskrevet en justert hovedmodell (modell A*) og en tydeliggjort nåsituasjon (modell B). Prosjektet har vurdert, men vil ikke anbefale, separate helkjedefunksjoner innen smittevern, miljømedisin, folkehelse- og helsetjenesteområdene, Av den grunn beskriver ikke rapporten en modell med egne folkehelse- og helse- og omsorgstjenesteetater. Selv om en slik endring med helkjedemodeller isolert sett kunne ha styrket folkehelsearbeidet, har det vært vurdert at hensynet til enkeltområder og helhet må balanseres på tvers av alle helsesektorens behov og sees i sammenheng i en samlet og robust helsemyndighet. Videre vil et slikt myndighetsorgan gjøre det enklere for kommunene ved at de har én organisasjon å forholde seg til når det gjelder nasjonale krav innen hele helseområdet. Samlet sett har dette veid

tyngst. I tillegg ville et skarpere skille mellom folkehelse og helsetjenester ha skapt nye grenseflater og gråsoner, samt dublering av kompetanse som begge etatene ville ha hatt behov for.

Prosjektet har også vurdert en modell som samler større deler av helsesikkerhetsfeltet, herunder atom- og strålevernfeltet, miljømedisin og smittevern, men et alternativ med et slikt «helsesikkerhetsdirektorat» er også lagt bort. Dette er dels begrunnet med DSA sin tverrsektorielle rolle hvor flere departementer ønsker DSA som en selvstendig institusjon, og at fagmiljøet er lite og sårbart. Prosjektet har vurdert at det er mest hensiktsmessig å samle de formelle myndighetsoppgavene innen de helsefaglige områdene i én etat, med en beskrivelse av ulike tilnærminger for organisering av de øvrige forvaltningsoppgavene (gjennomføring; følge med; rådgivning; analyser av statistikk; og kunnskap) innen de ulike fagområdene.

For de aktuelle modellene diskuteres det hvordan hensynet til effektive arbeidsprosesser, uavhengighet og klare roller og ansvar, og bedre støtte til kommunal sektor og andre sektorer er ivaretatt, samt mulighet for kompetente fagmiljøer som grunnlag for leveransekvalitet. I alle modellene er myndighetsrollen og det formelle ansvaret for normer og krav lagt til Hdir/myndighetsetat. Innen dette området videreføres dagens modell, hvor bl.a. juridisk kompetanse holdes samlet. Alle modellene legger også til grunn at metodevurderinger/HTA for legemidler og medisinsk utstyr samles i et direktorat for medisinske produkter, jf. kapittel 4. Videre er kunnskapsoppsummeringer og forskning lagt til FHI/kunnskapsetaten i alle modeller. Når det gjelder det koordinerende ansvaret i en beredskapssituasjon er det, som i dag, lagt til Hdir, men det tas forbehold om justeringer eller andre konklusjoner i Helseberedskapsmeldingen.

3.3 Forslag til ny organisering

Alternativ A: Heldekkende myndighetsetat og spisset kunnskapsetat

Denne modellen rendyrker skillet mellom en myndighetsetat og en kunnskapsetat. Det betyr at uavhengige kunnskapsfunksjoner, herunder primær- og sekundærforskning, kunnskapsoppsummeringer, metodevurderinger og økonomiske evalueringer legges til en kunnskapsetat. Videre vil myndighetsfunksjoner, gjennomføringsfunksjonen og følge-med-funksjonen, inkludert statistikk og registeranalyse, legges til en myndighetsetat. Inntil videre bør laboratorievirksomheten holdes samlet i kunnskapsetaten til videre utredninger er gjennomført, jf. kapittel 11.2. Modellen innebærer at store deler av smittevernfeltet legges til og samles i myndighetsetaten ved at gjennomføringsfunksjonen, inkludert mer operative oppgaver som håndtering av varsler og oppklaring av utbrudd av smittsomme sykdommer, og følge-med-funksjonen innen fysisk og psykisk helse, samt helsetjenesten, organiseres i myndighetsetaten. En slik modell svarer ut utfordringene med uklarhet rundt roller, ansvar og myndighet innen smittevern, som ble trukket frem av Koronakommisjonen, jf. kapittel 2.1 om nåsituasjonen. En tydelig rolle og ansvarsdeling vil alltid være viktig i en beredskapssituasjon.

En myndighetsetat som beskrevet vil gi mulighet for effektivisering og bedre samspill mellom fagområder, hvilket vil legge grunnlag for å arbeide med dagens utfordringsbilde og legge til rette for å kunne bruke ressurser på tvers under kriser. Samtidig vil etaten ha et stort spenn i oppgaver og det vil kreve et godt samarbeid med kunnskapsetaten slik at myndighetsetaten

mottar relevant og nyttig kunnskap. For myndighetsetaten vil registeranalyser og statistikk gi viktig kunnskap og kompetanse som kommer øvrige funksjoner i etaten til gode, og muligheten for oppgaver innen analyse og statistikk vil kunne stimulere til rekruttering og et større kompetansemiljø. En kunnskapsetat vil ha gode forutsetninger for å rekruttere spesialkompetanse og sikre gode fagmiljøer, da gode muligheter for forskning i seg selv er rekrutterende. Slik sett vil denne modellen kunne bidra til god og relevant rekruttering i begge etater. Likevel kan kunnskapsetaten miste kompetanse på kort sikt da mange medarbeidere både har gjennomførings-, analyse- og kunnskapsoppgaver. Samtidig er dette en generisk utfordring ved alle organisasjonsendringer, og det vil blant annet også kunne gjelde registermiljøer dersom de flyttes til kunnskapsetaten.

Kommunal sektor har behov for kunnskapsstøtte og beslutningsgrunnlag som er tilpasset den lokale situasjonen. Sektoren trenger også støtte til implementering og evaluering av tiltak, inkludert tiltak innen helse- og omsorgstjenesten, smittevern, miljørettet helsevern og helsefremmende tiltak som gjennomføres i andre sektorer. Modellen vil gjøre det tydeligere for kommunene hvor de kan hente støtte og dette er viktig både i det løpende arbeidet og i kriser.

Innen smittevern og miljømedisin vil flytting av registeranalyser og gjennomføringsoppgaver til myndighetsetaten kunne skape gråsoner mot kunnskapsproduksjon og forskning, og dette må gjennomgås og avklares i et gjennomføringsprosjekt. Samtidig ivaretas uavhengigheten mtp. kunnskapsproduksjon og forskning, jf. kapittel 2.4. Videre er det slik at dagens organisering i FHI innebærer at forskning innen smittevern ikke nødvendigvis er organisert i samme område som resten av smittevernarbeidet. Dette gjelder bl.a. CEIR (Senter for forskning på epidemitiltak). Med tanke på å sikre at kunnskapsproduksjonen blir relevant, spisset og tilgjengelig, spesielt i kriser, fordrer det tett dialog og godt samarbeid mellom kunnskapsetaten og myndighetsetaten, samt god etatsstyring fra departementet.

Innen folkehelsefeltet er det store miljøer både i Hdir og FHI i dag. Det er ikke like tett sammenvevde løpende forvaltningsoppgaver innen folkehelse/ helsefremmende arbeid som innen smittevern og dels miljømedisin. Med denne modellen vil gjennomføringsoppgaver og følge-med-funksjoner samles, og dette gir mulighet for effektivisering i forvaltningen av folkehelsearbeidet.

Det kan være mest aktuelt å plassere enkeltstående befolkningsstudier nært gjennomførerfunksjonen (fylkeshelseundersøker, tobakksvaner o.l.), mens store forskningsbaserte kohortstudier/helseundersøkelser kan plasseres i kunnskapsmiljøet (f.eks. MoBa). Det vil gi et skille i fagmiljøet som i dag har kompetanse til å analysere og vurdere data fra befolkningsstudier og overvåking. Innen helsetjenesteområdet vil arbeid med helsetjenesteanalyser og brukererfaringer legges til myndighetsetaten, mens kunnskapsoppsummeringer og helsetjenesteforskning blir værende i kunnskapsetaten.

Det legges til grunn at kunnskapsetaten skal gi råd til departementet og andre etater, og formidle kunnskap. Innen mattrygghet og drikkevann er FHI en kunnskapsleverandør for Mattilsynet, og det må avklares i et gjennomføringsprosjekt hvordan denne oppgaven kan ivaretas av de to etatene.

Modell A vil kreve en større omstilling fra dagens situasjon. Smittevern og til dels miljømedisin er operative fagområder, og er de fagområdene som vil oppleve de største endringene ved en slik modell. Samtidig vil store deler av smittevernfeltet fremdeles være

samlet, men i en myndighetsetat. Forskning innen smittevern forblir i kunnskapsetaten, og denne modellen gir mulighet til å bygge opp et sterkere forskningsmiljø innen smittevern. Det operative arbeidet innen smittevern er sammenvevd med kunnskapsproduksjon, som dels er basert på laboratoriefunksjoner både i og utenfor FHI. Plassering av laboratoriefunksjoner som brukes i det operative arbeidet, herunder referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi, må utredes.

Det anbefales at myndighetsetaten beholder navnet *Helsedirektoratet*, som er etablert og godt kjent blant tjenestene, øvrig forvaltning og befolkningen. Kunnskapsetaten, med hovedtyngden rundt forskning og kunnskapsoppsummeringer, vil likne forskningsinstituttene i instituttsektoren. På samme måte som Helsedirektoratet er *Folkehelseinstituttet* velkjent for de fleste, og det anbefales at kunnskapsetaten kan beholde dette navnet.

Figuren under illustrerer hvordan hovedoppgavene i en slik modell vil fordele seg.

Figur 3.2: Heldekkende myndighetsetat og spisset kunnskapsetat.

	Smittevern og miljømedisin (helsevern)	Folkehelse/helse-fremmende arbeid	Helse- og omsorgstjenester
Myndighet Normer Krav			
Gjennomfører Følge med/overvåke Rådgivning			
Registeranalyser Statistikk			
Kunnskapsoppsummering Forskning			

Alternativ A*: Heldekkende myndighetsetat og spisset kunnskapsetat, med unntak for smittevernområdet

Dersom en skal gjøre mindre endringer innen smittevernområdet enn i alternativ A, kan en alternativ modell være et unntak for dette fagfeltet. I en slik modell vil man da samle myndighetsfunksjoner, gjennomføringsfunksjoner og registeranalyser/statistikk innen helsetjeneste- og innen folkehelseområdet i myndighetsetaten, men gjør unntak for fagområdene smittevern og miljømedisin. Regelverksfortolkning og formelle myndighetsfunksjoner vil fremdeles være samlet i et helhetlig direktorat.

I modell A* vil kunnskapsoppsummeringer og forskning holdes samlet med registeranalyser og gjennomføringsoppgaver innen smittevern og miljømedisin, noe som kan være hensiktsmessig siden kunnskap og løpende operative oppgaver er sammenvevde. Dette vil også kunne være en fordel i beredskapssituasjoner mtp. kunnskap i kriser, samtidig som pandemien har vist at det må gjennomgås og defineres klare grenseoppganger mtp. roller og oppgavefordeling innen smittevern og beredskap. Selv om ansvaret for operative funksjoner innen smittevernet blir i FHI, kan koordineringsansvar for helse- og omsorgssektorens innsats under kriser delegeres til Hdir, som i dag. For alle områdene vil Hdir ha ansvar for å vurdere konsekvenser for helse- og omsorgstjenesten, samt å gi normerende råd til

tjenestene og befolkningen. For smittevernfeltet gir denne modellen en organisering som ligner den danske organiseringen med Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institutt (SSI). Modellen krever et godt og tett samarbeid mellom myndighetsetaten (som har det formelle myndighetsansvaret også innen smittevern) og kunnskapsetaten.

Dette er en modell som først og fremst fører til at store deler av folkehelsefeltet samles i Hdir ved at oppgaver innen feltet i FHI vil bli flyttet (se omtale under modell A). Det er dermed mindre behov for omstilling sammenlignet med modell A. I denne modellen har myndighetsetaten det formelle ansvaret for alle de tre fagområdene. For å unngå dagens uklare rollefordeling mellom Hdir og FHI hva angår smittevern og beredskap fordrer en slik modell en avklart oppgavefordeling, som omtalt over. Dette gjelder bl.a. ansvaret for å utgi normerende veiledning. Det vil være en fordel om kunnskapsetaten har noen operative oppgaver slik som å gi støtte til kommunene i utbruddsoppklaring, men at myndighet til å gjøre vedtak mv. ligger hos myndighetsetaten som har den juridiske kompetansen. Modellen forutsetter at myndighetsetaten får et sterkere smittevernfaglig miljø enn i dag, jf. Koronakommisjonens påpekninger, slik at myndighetsetaten har tilstrekkelig autoritet og kompetanse innen dette fagområdet. Figuren under illustrerer hvordan hovedoppgavene i en slik modell vil fordele seg.

Figur 3.3: Heldekkende myndighetsetat og spisset kunnskapsetat, med unntak for smittevernområdet.

	Smittevern og miljømedisin (helsevern)	Folkehelse/helse-fremmende arbeid	Helse- og omsorgstjenester
Myndighet Normer Krav			
Gjennomfører Følge med/overvåke Rådgivning			
Registeranalyser Statistikk			
Kunnskapsoppsummering Forskning			

Alternativ B: Nåsituasjonen tydeliggjort

Modell B representerer en tydeliggjort nåsituasjon. Selv ved å beholde dagens overordnende organisering er det behov for justeringer slik at roller og ansvar er mer definerte. Det kan gjøres ved å beholde en ulik deling mellom de tre fagområdene. Analyse av dagens organisering viser at det er behov for bedre og mer koordinert styring fra departementet slik at etatenes ressurser brukes til å besvare samfunnsoppdraget. Det inkluderer forskning i FHI, som må være relevant og nyttig for myndighetene og/eller tjenestene. Det vil være behov for gjennomgang av instrukser til etatene og bedre koordinering av tildelingsbrev slik at helseforvaltningen benyttes mer samlet. I tillegg er det behov for gjennomgang av samarbeidsavtaler mellom Hdir og FHI, og bedre koordinering ved råd rettet mot tjenesten og befolkningen slik at den sentrale helseforvaltningen oppleves som samlet. Justeringer i

dagens modell kan tydeliggjøre roller og ansvar, vil medføre mindre omstillingskostnader, men gir samtidig liten mulighet for økt ressurseffektivitet.

Denne modellen medfører at FHI beholder gjennomføringsoppgavene innen smittevern og miljømedisin, at FHI gjør registeranalyser og statistikk knyttet til helsetilstand og risikofaktorer/helsedeterminanter, mens Hdir gjør registeranalyser og statistikk knyttet til helse- og omsorgstjenester, helsepersonell og tiltak innen folkehelseområdet. Videre vil det være FHI som fremdeles driver med forskning og kunnskapsoppsummering innen alle områder, mens regelverksfortolkning og formelle myndighetsfunksjoner fremdeles vil være samlet i et helhetlig direktorat.

Ved flere mindre endringer i dagens modell kan man oppnå synergier langs en eller begge akser. Dette må vurderes og følges opp i et gjennomføringsprosjekt.

Figuren under illustrerer hvordan hovedoppgavene i en slik modell vil fordele seg.

Figur 3.4: Nåsituasjonen tydeliggjort.

	Smittevern og miljømedisin (helsevern)	Folkehelse/helse-fremmende arbeid	Helse- og omsorgstjenester
Myndighet Normer Krav			
Gjennomfører Følge med/overvåke Rådgivning			
Registeranalyser Statistikk			
Kunnskapsoppsummering Forskning			

3.4 Vurdering

En robust og heldekkende myndighetsetat som i modell A, har størst potensiale for bedre ressursutnyttelse sammenlignet med dagens situasjon. Fagmiljøene samles og styrkes på tvers av fagområder, noe som både kan gi stordriftsfordeler, synergieffekter og muligheter for effektivisering. Samtidig avklares roller og ansvar innen de ulike fagområdene hvor dette har vært uklart eller uavklart. Modell A legger også til rette for bedre støtte til kommunal sektor og forenkler dagens situasjon ved at kommunene har én etat å forholde seg til. Etaten må også se folkehelse og helse- og omsorgstjenestene i sammenheng, og har mulighet til å bruke hele virkemiddelapparatet. I et beredskapsperspektiv vil en modell med en robust og heldekkende myndighetsetat være i stand til å samordne og koordinere i kriser om dette delegeres fra departementet. Samtidig vil en rendyrket kunnskapsetat bygge opp viktig kompetanse innen forskning og kunnskapsoppsummeringer, som vil være nødvendig for mye av myndighetsetatens arbeid.

Akkurat som for tjenestene må også en fremtidsrettet helseforvaltning ha mulighet for fleksibilitet og omstilling ved behov. Det kan for eksempel bety at ressursene i kunnskapsetaten brukes i myndighetsetaten under en krise. Fleksibilitet og omstilling er spesielt viktig i relasjon til samfunnsutviklingen med erfaringer fra bl.a. koronapandemien og

krigen i Ukraina, samt den demografiske utviklingen med eldrebølge og strammere økonomiske rammer med økt behov for prioritering av ressursene. En moderne helseforvaltning skal være rigget for å takle dagens og morgendagens utfordringer.

3.5 Konklusjon

Etter en samlet vurdering (jf. vurderingskriteriene i kapittel 2.5), og med spesielt behov for tydelige roller og ansvar og mulighet for effektivisering, anbefaler prosjektet modell A med en helhetlig myndighetsetat og en spisset kunnskapsetat med ansvar for kunnskapsoppsummeringer og forskning. Dette vil bl.a. bety en samling av det meste av smittevernkompetansen i myndighetsetaten. Inntil videre bør laboratorievirksomheten holdes samlet i kunnskapsetaten til videre utredninger er gjennomført, jf. kapittel 11.2.

Det vises til kapittel 12 hvor anbefalingen fra dette kapittelet er satt inn i helhetlige modeller.

4 Statens legemiddelverk som utgangspunkt for et direktorat for medisinske produkter

4.1 Dagens ansvars- og oppgavefordeling

Legemiddelverkets samfunnsoppdrag er å være fag- og tilsynsmyndighet for legemidler og medisinsk utstyr. Legemiddelverket skal bidra til at de overordnede målene for legemiddelpolitikken blir oppfylt. Målene er å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler, at legemidler skal ha lavest mulig pris, likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler og å legge til rette for forskning og innovasjon. For medisinsk utstyr skal Legemiddelverket påse at medisinsk utstyr som produseres og omsettes i Norge er trygt og sikkert.

Legemiddelverket er gjennom forskrifter tillagt forvaltningsmyndighet for regulering av legemiddel- og medisinsk utstyrsmarkedet. Legemiddelverket godkjenner hvilke legemidler som kan markedsføres i Norge og fastsetter prisen på reseptpliktige legemidler til mennesker. Legemiddelverket fatter videre vedtak om hvilke legemidler som skal gis forhåndsgodkjent refusjon innenfor blåreseptordningen hvis budsjettkonsekvensen er under fullmaktsgrensen. Legemiddelverket fatter vedtak om apotek-konsesjon og om tillatelse til tilvirknings- og grossistvirksomhet med legemidler, samt er tilsynsmyndighet overfor legemiddelprodusenter, grossister og apotek.

SLV representerer Norge i internasjonale fora, herunder det europeiske legemiddelbyrået EMA, *Heads of Medicines Agencies* (HMA) og *Det europeiske direktoratet for legemiddelkvalitet og helseomsorg* (EDQM). Legemiddelverket representerer også Norge i europeiske fora innen området medisinsk utstyr, herunder *Medical Device Coordination Group* (MDGC), *Competent Authority Medical Devices* (CAMD) og diverse arbeidsgrupper i Europakommisjonen.

Markedstilsyn, utpeking og tilsyn av norsk kontrollorgan, regelverksutvikling og fortolkning innen området medisinsk utstyr er også Legemiddelverkets ansvar.

SLV har ansvar for å utføre hurtig- og forenklede metodevurderinger av legemidler som behandles i systemet for nye metoder for bruk i spesialisthelsetjenesten og folketrygdfinansierte legemidler, og fatter beslutning om opptak om forhåndsgodkjent refusjon i blåreseptordningen. Legemiddelverket har ansvaret for å tidlig varsle om nye legemidler som forventes å komme til Norge.

SLV har 335 årsverk og er finansiert over statsbudsjettet, inkl. gebyrinntekter. Samlet inntektsramme er 408 mill. kroner hvorav 124 mill. kroner er gebyrinntekter. SLV er lokalisert på Helsfyr i Oslo.

4.2 Behov for navneendring

SLVs portefølje inneholder i dag både legemidler og medisinsk utstyr. Etter prosjektets vurdering bør det vurderes å endre navn til Direktoratet for medisinske produkter slik at etatens ansvar blir gjenspeilet i navnet. Dette vil også være en fordel i forbindelse med det internasjonale arbeidet.

4.3 Bakgrunn for å vurdere organisasjonsendringer

Produktporteføljen

Prosjektet har vurdert et «helseproduktdirektorat» med ansvar for alle markedsførte helseprodukter. Utgangspunktet har vært dagens SLV sitt ansvar for legemidler og medisinsk utstyr, som er produkter med et definert medisinsk formål. Ut over dette finnes det et vell av produkter som prosjektet har kalt velferdsteknologisk utstyr. Dette er utstyr som, kort fortalt, kan anvendes i helsetjenesten, men uten et definert medisinsk formål. Såkalte helseapper er et samlebegrep for flere digitale løsninger og kan, avhengig av bruken, kategoriseres enten som medisinsk eller velferdstekologisk utstyr.

Bakgrunnen for denne delen av prosjektets vurderinger følger dels av at det er en stor utvikling ikke minst innen digitalisering og bruk av helsedata og kunstig intelligens. Helsepersonellutfordringer vil også kunne drive fram behov for et bredere produktspekter enn i dag. Dette er et felt som vil kreve økt kapasitet og kompetanse i forvaltningen i årene som kommer og som både kan kreve økte regulatoriske funksjoner og bedre ordninger for vurdering, innføring og finansiering. Forvaltningen må rustes for å kunne gjøre dette og se de ulike helseproduktene i sammenheng, samt kunne vurdere dem opp mot effekt/nytte, trygghet og ressurseffektivitet.

Forsyningssikkerhet og beredskap

Forsyning av legemidler og medisinsk utstyr er av ytterste viktighet. Både pandemien og utviklingen i mangelsituasjoner de senere årene har vist sårbarheten. Det er viktig å organisatorisk legge til rette for at arbeidet knyttet til forsyningssikkerhet og beredskap kan løses best mulig. Dette har implikasjoner for organisering, ansvarsplassering og rolleavklaringer.

Metodevurderinger

Både FHI og SLV bidrar med kunnskap til system for nye metoder i spesialisthelse-tjenesten. Overordnet vurderer SLV legemidler, mens FHI vurderer medisinsk utstyr. I tillegg gjør FHI vurdering av metoder knyttet til diagnostikk og behandling, organisatoriske forhold, etc. Det finnes ulike typer metodevurderinger: Fullstendige metodevurderinger, hurtige metodevurderinger og forenklede metodevurderinger. FHI har etablert et miljø som utgjør brorparten av etatenes kompetanse innen fullstendige metodevurderinger (Health Technology Assessment, HTA). SLV har etablert et miljø for hurtige metodevurderinger av legemidler. Utover dette bistår DSA i metodevurderinger der DSAs særskilte kompetanse behøves. Videre utføres mini-metodevurderinger på helseforetaksnivå. Det er således mange aktører som er involvert i de ulike stadiene ved vurdering av nye metoder. Prosjektet har vurdert samling av HTA-metodevurderingsmiljøet (i hovedsak FHI) og miljøet for hurtig metodevurdering (SLV).

Anskaffelser

Staten er landets største innkjøper, og helsesektoren inkl. folketrygdordningene står for en betydelig andel av statens samlede innkjøp. Spesialisthelsetjenesten og kommunene har i dag ansvar for sine sektorvise innkjøp av legemidler og medisinsk utstyr. Prosjektet har ikke vurdert noen endringer for denne ansvarsplasseringen, men har vurdert om det kan foreligge noen gevinster knyttet til å samle anskaffelser av legemidler inkl. vaksiner og medisinsk

utstyr som finansieres over folketrygden. For vaksinefeltet vil en flytting av anskaffelsesansvaret fra FHI til SLV også være en fordel da det setter FHI bedre i stand til å arbeide opp mot vaksineprodusenter uten interessekonflikt i forbindelse med anskaffelser. Det er videre vurdert hvordan en slik samlet anskaffelse kan organiseres og det er da sett hen til eksisterende anskaffelsesmiljøer.

Blod, celler og vev

Over de siste tiårene har utviklingen innenfor legemiddelfeltet vært betydelig. Vi har sett en rivende utvikling av legemidler basert på blod, celler og vev. Disse legemidlene reguleres gjennom et særskilt EØS-regelverk for avanserte terapier. Alle disse terapiene må godkjennes som legemidler av Legemiddelverket. I tillegg er det slik at alle som tilvirker legemidler basert på blod, celler og vev må godkjennes av Legemiddelverket. I Norge er det i all hovedsak blod-, celle- og vevsbankene i spesialisthelsetjenesten. Legemiddelverket fører derfor tilsyn med disse etter reglene om tilvirkning av legemidler. I tillegg er det slik at EØS-retten har regler om blod-, celle- og vevsbanker. De må godkjennes jevnlig for å kunne tappe og teste av blod og blodkomponenter, celle og vev. Denne godkjenningen gis av Hdir. Prosjektet har vurdert en samling av området.

4.4 Forslag til ny organisering

Produktporteføljen

SLV har legemidler og medisinsk utstyr i det vi kan kalle produktporteføljen. Det er reist spørsmål om produktporteføljen også bør omfatte det prosjektet har definert som velferdsteknologisk utstyr (alt utstyr som ikke har et definert medisinsk formål), herunder helseapper.

I de fleste land har man på direktoratsnivå etablert en ansvarsorganisering som omfatter både legemidler (inkl. veterinære) og medisinsk utstyr i samme direktorat. Prosjektet har ikke funnet noen tydelige eksempler på at velferdsteknologisk utstyr også er organisert sammen med legemidler og medisinsk utstyr, men det er på de respektive nettsider ikke alltid like tydelig hvilken egenskap (medisinsk vs. velferdsteknologisk utstyr) et digitalt produkt har. Ut over dette lar mange land sin legemiddel- og produktmyndighet også ha ansvar kosmetiske produkter og tatoveringsblekk, som i Norge er plassert i Mattilsynet. (Prosjektet har ikke sett nærmere på endret ansvarsplassering av kosmetiske produkter og tatoveringsblekk.)

Velferdsteknologisk utstyr består for en stor del av helseapper. Det er løpende gråsoner mellom medisinsk utstyr og velferdsteknologisk utstyr. Med dagens ansvarsplassering faller velferdsteknologisk utstyr, inkl. helseapper, inn under ansvarsområdet til Hdir.

Å flytte ansvaret for velferdsteknologi til et produktdirektorat vil internalisere gråsonen i ett direktorat. Det vil likevel være forskjellige regelverk som regulerer de to forskjellige gruppene produkter. Ansvaret for produktene som faller utenfor regelverket om medisinsk utstyr ligger i dag i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Forbrukertilsynet.

Forsyningssikkerheten til legemidler og medisinsk utstyr er viktig, og det er et område som dagens SLV arbeider med (i tillegg til spesialisthelsetjenesten som også følger med på forsyningssikkerhet for egne produkter). For velferdsteknologisk utstyr er ikke forsyningssikkerhet en tematikk som sådan. Å la et direktorat for medisinske produkter også

ha ansvar for velferdsteknologisk utstyr vil derfor innebære en organisering som velger å ikke rendyrke arbeidet med forsyningssikkerhet, med dertil risiko for nedprioritering av området.

Samlet sett er det prosjektets vurdering at det ikke bør gjøres endringer i produktporteføljen til SLV. Denne bør fremdeles bestå av legemidler og medisinsk utstyr. Prosjektet vurderer videre at ansvaret for velferdsteknologisk utstyr bør tydeliggjøres og legges til Hdir. Sistnevnte omfatter også utviklingsarbeid i tilknytning til helseapper.

Forsyningssikkerhet og beredskap

Forsyning av legemidler og medisinsk utstyr er av ytterste viktighet. Både pandemien og utviklingen i mangelsituasjoner de senere årene har vist sårbarheten. Det er viktig å organisatorisk legge til rette for at arbeidet knyttet til forsyningssikkerhet og beredskap kan løses best mulig. Etter prosjektets vurdering bør særlig følgende vurderes ved valg av organisering:

- Rendyrking av produktporteføljen, jf. vurderinger over.
- Forholdet til Europa (EU).
- Hvilke(n) etat(er) bør være beredskapsmyndighet?

Når det gjelder vurderinger rundt produktporteføljen vises det til avsnittet «Produktporteføljen» over.

EU har tatt flere grep for å styrke helseberedskapen. Kunnskapsgrunnlaget styrkes gjennom å styrke det europeiske smittevernbyrået (ECDC). Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har fått økt kompetanse som innebærer at vi på europeisk nivå overvåker tilgangen til kritiske legemidler og medisinsk utstyr, og forsyningssikkerheten av disse. EMA har f.o.m. 2022 fått utvidet sitt mandat til å bl.a. gjelde beredskap for legemidler og medisinsk utstyr. Dette innebærer ansvar for å overvåke forsyningssikkerheten av legemidler og medisinsk utstyr, herunder å komme med forslag til tiltak når tilgangen er utfordret.

EMAs ansvarsområder speiles allerede inn i norsk organisering gjennom dagens SLV. Hensynet til tydelighet overfor europeiske (og øvrige internasjonale) parter kan være en selvstendig motivasjon til en navneendring (fra SLV til Direktoratet for medisinske produkter, jf. kapittel 4.2) som tar opp i seg at også medisinsk utstyr er omfattet av direktoratsansvaret.

EU har samtidig styrket Kommisjonens koordineringsevne for alvorlige, grensekryssende helsetrusler. Som en overordnet myndighet er helsekrisemyndigheten DG HERA (Health Emergency Response Authority) etablert. HERA er et generaldirektorat underlagt kommisjonen og skal være et bindeledd mellom forskning, utvikling, produksjon, innkjøp og distribusjon av kriserelevante medisinske mottiltak. I en krise kan HERA få fullmakt til å iverksette hele spekteret av disse tiltakene for å sikre tilgangen til medisinske mottiltak som er nødvendige for å håndtere krisen i EUs medlemsland. Data fra EMA og ECDC vil gi HERA oversikt over hva og hvor mye Europa trenger av ulike medisinske mottiltak for å håndtere krisen. På denne måten sikrer EU robuste forsyningskjeder for medisinske mottiltak, og ivaretar Europas tilgang til medisinske mottiltak i en krise.

Prosjektet har vurdert om det også burde etableres «et norsk HERA» for å speile EUs organisering innen området. Det er imidlertid etter prosjektets vurdering mindre realistisk å på noen måte skulle kopiere HERA-strukturen til et norsk direktorat. Dette følger dels av nivået på myndigheten HERA (et «departement» med de regulatoriske virkemidler det

innebærer), dels at større deler av virkemidlene til HERA er irrelevante for norske forhold (eksempelvis har HERA inngått avtaler for å holde produksjonslinjer «varme» og som raskt kan omstilles ved mangelsituasjoner, noe som er mindre aktuelt i Norge med et fåtall nasjonale produsenter) og dels av at mye av HERAs funksjon ved kriser er leveranser av legemidler og medisinsk utstyr til EUs medlemsland og ev. andre land som er tilknyttet. Det arbeides allerede med hvordan Norge best kan bidra i implementeringen av HERAs mandat, inkludert gjennom egne virkemidler. Regjeringen har besluttet (r-konferanse 13. januar 2022) at det skal innledes forhandlinger med EU med sikte på full norsk tilknytning til det europeiske helseberedskapssamarbeidet, herunder HERA, på så like vilkår med EUs medlemsland som mulig. Formålet med forhandlingene er å styrke norsk helseberedskap og sikre tilgang til vaksiner, legemidler og medisinsk utstyr i kriser.

Selv om det etter prosjektets vurdering ikke synes nødvendig å skulle etablere et norsk HERA, kan det likevel være rasjonelt å etablere entydige ansvarsforhold (ansvarspunkt) i den norske strukturen om hvem som skal ha systematisk kontakt med generaldirektoratet (HERA) og de forskjellige byråer (EMA, ECDC). Det synes etter prosjektets vurdering åpenbart at SLV / et direktorat for medisinske produkter bør ha ansvaret for løpende kontakt med EMA.

Hvorvidt et direktorat for medisinske produkter også skal ha ansvaret for løpende kontakt med HERA er etter prosjektets vurdering noe mer uklart. Dette følger dels av HERAs myndighetsnivå og dels av hvilket norsk direktorat som skal være beredskapsmyndighet for legemidler og medisinsk utstyr. Roller og ansvar for løpende kontakt med EUs organisasjoner i freds- og krisetid bør etter prosjektets vurdering tydeliggjøres. Foreløpig ligger denne kontakten i HOD. Fullmaktene lagt til HERA er også av en slik art at det trolig vil være nærliggende at HOD fortsatt har den overordnede kontakten, og at ev. bidrag fra underliggende etater vurderes fortløpende av HOD.

Hdir er i dag både legemiddelberedskapsmyndighet og beredskapsmyndighet for medisinsk utstyr. I høringsnotatet «Innretning av legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten» som nylig har vært på offentlig høring (frist 6. januar d.å.) anføres det at *«flere myndigheter og aktører har ulike roller og ansvar i organiseringen av legemiddelberedskapen i Norge. Det kan oppleves som utfordrende å danne seg et tydelig bilde av forvaltningen av området. Dette påpekes også av Koronakommisjonen.»*

Ansvarsdelingen for legemiddelberedskap mellom Hdir og SLV følger per i dag i hovedsak inndelingen mellom Hdir som myndighetsorgan og SLV som fag- og tilsynsorgan. I kriser og andre beredskapssituasjoner kan Hdir få fullmakt fra departementet til å koordinere beredskapsarbeidet. Rollene i slike situasjoner er som ved vanlige situasjoner at SLV er fagorgan og Hdir er myndighetsorgan med fullmakter etter helseberedskapsloven. Konkret overvåkning av forsyningssikkerheten vil måtte foregå i regi av SLV, selv om Hdir koordinerer arbeidet med å håndtere en krise. I nevnte høring foreslår departementet opprettelsen av et Nasjonalt legemiddelberedskapsråd (en erstatning for nåværende Nasjonal legemiddelberedskapskomite) ledet av Hdir med sekretariatsfunksjon. Rådet skal ha medlemmer fra de etatene som har ansvar innen legemiddelberedskapsfeltet og de regionale helseforetakene (RHFene). Nærmere mandat for rådet vil utarbeides av departementet. Rådet skal møtes jevnlig og raskt ved behov.

Tilsvarende ansvarsdeling mellom Hdir og SLV har vi for beredskapsmyndighet for medisinsk utstyr, der Hdir er beredskapsmyndighet mens SLV er fag- og tilsynsorgan. Det kan på dette området virke som om roller og ansvar likevel ikke er like avklart som for legemidler, og det kan være behov for tydelig rolleavklaring og ansvarsplassering. Høringsnotatet er skrevet under gjeldende organisering av etatene, og det pekes på at det kan komme endringer i roller og ansvar i etterkant av gjennomgangen av sentral helseforvaltning. Det er således behov for å vurdere beredskapsorganiseringen både innen legemiddelfeltet og for medisinsk utstyr på nytt i lys av evt. endret organisering av den sentrale helseforvaltningen.

Prosjektet viser til Helseberedskapsmeldingen som autoritativt arbeid for vurdering av organisatorisk plassering av beredskapsmyndighetsfunksjonen for både legemidler og medisinsk utstyr.

Metodevurderinger

Etter prosjektets vurdering bør miljøene for både fullstendige og forenklede metodevurderinger for medisinsk utstyr og legemidler samles i SLV / et direktorat for medisinske produkter.

Vurderingen følger av at det kan ligge synergier i en slik samling. En samling vil være rasjonell med tanke på at fagmiljøer i både FHI og SLV utarbeider beslutningsgrunnlag til system for nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Med tanke på at direktoratet for medisinske produkter både skal dekke legemidler og medisinsk utstyr, er det også naturlig at metodevurderinger for det samme spekteret av produkter samles på samme sted.

Fra 2025 vil EØS-regelverk om HTA få anvendelse. Regelverket er i ferd med å innlemmes i EØS-avtalen. Merk at regelverket kun gjelder en vurdering av relativ klinisk effekt for nærmere angitte legemidler og medisinsk utstyr. EØS-regelverket innebærer at det skal gjennomføres felles vurderinger av relativ klinisk effekt for enkelte legemidler og medisinsk utstyr. Disse felles vurderingene må det tas hensyn til i de nasjonale metodevurderingene som i tillegg vil inkludere økonomisk evaluering. En samling av miljøene for metodevurderinger for legemidler og medisinsk utstyr fremstår som egnet sett i lys av dette.

Ved en samling av de to miljøene i et direktorat for medisinske produkter vil man for FHI måtte vurdere omfanget av HTA av mer generelle kunnskapsoppsummeringer inkludert spørsmål om folkehelsetiltak, kliniske tiltak i tjenestene som ikke er bruk av produkter og spørsmål knyttet til organisering, styring, finansiering o.l. av tjenestene, inkl. digitale løsninger. Det vil etter prosjektets vurdering være fornuftig å la kunnskapsoppsummeringer om slike spørsmål ligge igjen i en kunnskapsetat.

En samling av metodevurderinger av medisinske produkter i et direktorat for medisinske produkter kan enten inngå i den ordinære organiseringen til direktoratet, alternativt kan man tenke seg dette organisert som et «nivå 3», bl.a. for å skape noe distanse til og faglig uavhengighet fra den overordnede etaten. Videre vil en slik løsning kunne bidra til åpenhet om kunnskapsgrunnlaget for sentrale prioriteringer.

Anskaffelser

Prosjektet har vurdert om det kan foreligge noen gevinster knyttet til å samle anskaffelser av legemidler (inkl. vaksiner) og medisinsk utstyr som finansieres over folketrygden. Det er videre vurdert hvordan en slik samlet anskaffelse kan organiseres og det er da sett hen til

eksisterende anskaffelsesmiljøer. Av disse er Statens innkjøpssenter og anskaffelses-funksjonen i NHN, funnet uaktuelle av prosjektet. Prosjektet har således fokusert på Sykehusinnkjøp HF som et mulig miljø det kan bygges videre på.

SLV har siden 2017 hatt en avtale med Sykehusinnkjøp HF om å drive anskaffelser (prisforhandlinger) på legemidler. Områdegjennomgangen av blåreseptområdet i 2020 anslo et potensiale for økonomiske gevinster ved å i større grad legge om anskaffelsene fra prisforhandlinger til anbud. Det er SLV som har det formelle ansvaret for anskaffelsene. Alt merkantilt arbeid utføres av Sykehusinnkjøp HF etter den inngåtte avtale om tjenestekjøp. Selve anskaffelsesavtalen inngås av Hdir fordi de har budsjettansvar for aktuell post i statsbudsjettet. Dette bør vurderes endret. Etter prosjektets vurdering bør det bygges videre på et opplegg der Sykehusinnkjøp gjør det merkantile arbeidet ved anskaffelsene. Samtidig tilsier erfaringene med tjenestekjøpsavtalen som er inngått mellom SLV og Sykehusinnkjøp HF, at SLV ikke kommer godt nok i inngrep med Sykehusinnkjøps interne prioriteringer. Dette kan vanskelig godtas dersom det skal bygges videre på Sykehusinnkjøp som aktør. Det bør både vurderes om det kan inngås en mer stringent samarbeidsavtale enn i dag, alternativt og kanskje også som et supplement, bør det vurderes om HOD gjennom eierstyring av RHFene skal pålegge Sykehusinnkjøp HF å gi tjenestekjøpsavtalen som er inngått mellom SLV og Sykehusinnkjøp HF tilstrekkelig prioritet.

Alternativet til endring i tjenestekjøpsavtale og ev. bruk av eierstyring kan være at staten gjennom en virksomhetsoverdragelse overtar eierskapet til Sykehusinnkjøp HF, enten for hele organisasjonen eller for legemiddelfeltet spesielt. Slike overdragelser er gjort tidligere, jf. NHN. Prosjektet vurderer at en først bør vurdere bedre avtalestruktur og nærmere eierstyring, før en virksomhetsoverdragelse vurderes.

I dag er ansvaret for forhandlinger og innkjøp av medisinske mottiltak fragmentert i helseforvaltningen, med den konsekvens at gevinster (kvalitet og penger) ved stordriftsfordel og spesialisering ikke tas ut. Etablering av en samlet forhandlings- og anbudsenhet for offentlig finansierte legemidler ved Sykehusinnkjøp SF er tidligere (2017) vurdert av departementet som et egnet tiltak, men er av ulike årsaker bare delvis fulgt opp. Etter prosjektets skjønn bør det nå vurderes å gå videre med en slik etablering, jf. potensialet for gevinster.

Tabellen under viser hvilke arbeid med anbud, prisforhandlinger og innkjøp som kan være aktuelle å være omfattet i en samordnet anskaffelsesenhet.

Tabell 4.1: Arbeid med anbud, prisforhandlinger og innkjøp som kan være omfattet av en samordnet anskaffelsesenhet.

Oppgave	**Ansvar i dag**	**Utføres i dag av**	**Ev. endring**	**Merknader**
Prisforhandlinger for legemidler finansiert over folketrygden §§ 2 og 3	SLV	Sykehusinnkjøp	Øke graden av anbud i anskaffelsene ut over 2022-piloten, jf. Områdegjennomgangen	Gjeldende tjenestekjøpsavtalen fungerer ikke tilfredsstillende.
Anbud og prisforhandlinger om grossisttjenester	SLV	Sykehusinnkjøp		Gjeldende tjenestekjøpsavtalen fungerer ikke tilfredsstillende.
Innkjøp av vaksiner i program og over folketrygden (blåreseptforskriften § 4)	FHI	FHI	Vurdere direktoratsansvar for anskaffelse. Flytte det merkantile til Sykehusinnkjøp.	
Beredskapsinnkjøp (eks. smittevernutstyr underpandemien og jod ifm. Ukraina krigen)	Hdir	Hdir, ad hoc Sykehusinnkjøp under pandemien	Formalisere Sykehusinnkjøps rolle.	
Innkjøp via JPA (Joint Procurement Agreement) – felles anskaffelser med EU (EØS).	Koordinering lagt til Hdir		Formalisere Sykehusinnkjøps rolle	
Fellesanskaffelser med EU etter avtalen om helseunionen	Avhengig av hva som kjøpes		Formalisere Sykehusinnkjøps rolle	

Som det fremkommer er det flere potensielle kandidater som kan vurderes lagt inn i en samlet innkjøpsenhet. En nærmere vurdering av områder bør gjøres i gjennomføringsprosjektet, herunder ev. forhold knyttet til grossist- og lagerfunksjon.

Blod, celler og vev

Prosjektet mener at arbeidet med blod-, celle og vevsbanker bør vurderes lagt til SLV / et direktorat for medisinske produkter. Dette er et fagområde under stor utvikling hvor det kan være nyttig med et styrket fagmiljø. Fagområdet preges av sterk innovasjon og et styrket fagområde kan gi Norge et fortrinn. Tilsynet har mange likheter og kan fremstå effektiviserende. Argumenter mot en flytting av dette fagområdet er at det i Hdir er del av bioteknologimiljøet som ikke nødvendigvis bør flyttes i sin helhet. Miljøet er lite (i størrelsesorden 3-5 årsverk) og gjennomføringsprosjektet bør vurdere forhold knyttet til sårbarhet og tilgrensende og til dels overlappende områder (bioteknologi, myndighet innen organdonasjon/transplantasjon).

4.5 Konklusjon

- Det anbefales å etablere et direktorat for medisinske produkter (DiMP) som får ansvar for legemidler og medisinsk utstyr, dvs. tilsvarende dagens portefølje i SLV.
- DiMP får ikke ansvaret for velferdsteknologisk utstyr (utstyr som ikke er medisinsk utstyr), herunder utviklingsarbeid knyttet til helseapper. Dette ansvaret bør tydeliggjøres og tillegges myndighetsetaten (dagens Hdir).
- HTA/medisinske metodevurderinger for medisinske produkter samles og legges til DiMP. Øvrig ansvar for kunnskapsoppsummering forblir i kunnskapsetaten/FHI.
- Ansvar for blod, celler og vev flyttes fra Hdir til DiMP, mens øvrige oppgaver på bioteknologifeltet, bl.a. forvaltning av bioteknologiloven, beholdes i Hdir.
- Direktoratet skal ha ansvar for innkjøp av legemidler, vaksiner og medisinsk utstyr. Det innebærer at ansvaret for anskaffelser av vaksiner legges sammen med øvrige innkjøpsfunksjoner i DiMP, hvor felles innkjøpsenhet benyttes. Ansvarsforhold og rolleavklaringer må utredes videre som del av et gjennomføringsprosjekt, men kompetansemiljøet i FHI / kunnskapsetaten vil benyttes for innkjøp av vaksiner på lik linje med at kompetansemiljøene i helseforetakene (HFene) benyttes ved legemiddelanbud.
- DiMP bør få et reelt ansvar for forsyningssikkerhet for legemidler inkl. vaksiner og medisinsk utstyr. Oppfølging av forsyningssikkerhet må ivaretas av prosjektet som arbeider med Helseberedskapsmeldingen.
- Forsynings- og innkjøpsfunksjoner utredes videre som del av et gjennomføringsprosjekt. Det anbefales at selve innkjøpsfunksjonen må ta utgangspunkt i og bygge på kompetansen som finnes i Sykehusinnkjøp. Det må i forbindelse med gjennomføringsprosjektet vurderes alternative samarbeidsstrukturer (avtaler, eierstyring) og/eller tilknytningsformer, herunder eierskap, for Sykehusinnkjøp.
- Spørsmål knyttet til grossist- og lagerfunksjon, må også utredes videre som del av et gjennomføringsprosjekt.
- Det bør utpekes entydige ansvarspunkter for systematisk kontakt med HERA, EMA og andre relevante EU-organisasjoner. Det vil være naturlig at DiMP fortsatt har ansvaret for kontakt med EMA.

5 Organisering av myndighetsoppgavene innen digitaliseringsområdet

5.1 Dagens ansvars- og oppgavefordeling

I dag er myndighetsoppgavene innen e-helseområdet samlet i E-helse. Direktoratet skal som nasjonal myndighet innen e-helseområdet bidra til at vedtatt politikk innen digitaliserings-området settes i verk i tråd med føringene fra HOD. Direktoratet skal legge til rette for en helhetlig e-helseutvikling gjennom å samle sektorens behov og utarbeide forslag til nasjonale strategier og planer innen e-helseområdet. Videre skal direktoratet utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale veiledere og retningslinjer om standarder, kodeverk, klassifikasjoner, terminologi, arkitektur, informasjonssikkerhet mv. Direktoratet har fått delegert fortolkningsansvar for deler av pasientjournalloven med tilhørende forskrifter. E-helse skal i tillegg være helse- og omsorgssektorens og departementets sentrale rådgiver innen e-helseområdet, og kompetansemiljø for nasjonale digitaliseringstiltak i sektoren.

Direktoratet ble etablert 1. januar 2016 basert på divisjon for e-helse fra Hdir. Målet var å etablere en sterkere nasjonal myndighet som skal bidra til økt gjennomføringsevne for e-helse på nasjonalt nivå. Direktoratet var samtidig ansvarlig for å levere de nasjonale e-helseløsningene til helse- og omsorgssektoren. Det ble etter hvert vurdert som nødvendig å rendyrke direktoratets rolle og unngå dobbeltrollen som myndighet og leverandør av tjenester. Fra 1. januar 2020 ble oppgaven med å utvikle og forvalte de nasjonale e-helseløsningene (e-resept, kjernejournal, helsenorge.no, grunndata) overført fra E-helse til NHN. Om lag 230 årsverk og oppgaver knyttet til drift, forvalting og utvikling ble virksomhetsoverdratt. Fra 1. januar 2022 ble det gjort ytterligere endringer som innebærer at NHN får oppdrag om å lede delprosjekter i de nasjonale programmene direkte fra departementet, mens E-helse har det helhetlige ansvaret for gjennomføring av programmene. E-helse har 232 årsverk (faste og midlertidige ansatte) og 23,7 innleide årsverk. Driftsbudsjettet er på i underkant av 400 mill. kroner. Hoveddelen av virksomheten er lokalisert på Skøyen i Oslo Helsedataservice er lokalisert på Tynset og i Trondheim.

NHN har som nasjonal tjenesteleverandør ansvaret for de nasjonale e-helseløsningene, og skal levere gode og trygge digitale tjenester og infrastruktur i helse- og omsorgssektoren. NHN har plikt til å gjøre helsenettet, kjernejournal, e-resept og helsenorge.no tilgjengelige for virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og virksomheter i statlig helseforvaltning, jf. § 19 i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger. NHN har også ansvar for Felles tjenestesenter for helseforvaltningen som leverer tjenester innen dokumentasjonsforvaltning, anskaffelser og IKT til virksomheter i helseforvaltningen. NHN håndterer teknisk drift (ikke forvaltning) av registrene til FHI og Hdir og de fleste nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

RHFene, kommuner og andre aktører i helse- og omsorgssektoren har ansvar for å utvikle og forvalte egne IKT-løsninger.

5.2 Bakgrunn for å vurdere organisasjonsendringer

Behov for en sterkere myndighet innen digitaliseringsområdet

Det er et mål at digitalisering skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenesten og en naturlig del av hvordan oppgavene løses, jf. Prop. 1 S (2022-2023). Fordi alle etater og

tjenesten driver med digitalisering og har grenseflater mot andre, så er det behov for en tredjepart som kan gjøre vurderinger og gjennomføre normering på tvers av både etater og aktørene i tjenesten. Sektoren etterspør i større grad nasjonal styring for å sikre en mer koordinert utvikling, og Riksrevisjonen har pekt på behovet for at nasjonale myndigheter tar et større ansvar for dette området. Det er behov for en sterkere myndighet knyttet til normering, standardisering, veiledning, regelverksfortolkning og koordinering. Felles krav til infrastruktur og grensesnitt er nødvendig for å legge til rette for samhandling og for å hente ut gevinster av digitale løsninger.

Digitalisering kan være et viktig virkemiddel for å effektivisere arbeidsprosesser og bidra til å redusere noe av veksten i behov for helsepersonell. Helsepersonellkommisjonen (NOU 2023:4) har et eget kapittel om digitalisering og teknologisk utvikling i helse- og omsorgstjenesten, og legger vekt på at det trengs en mer balansert og målrettet styring og koordinering av de digitale ressursene for å kunne ta ut effektivitetspotensialet i den videre digitaliseringen i helse- og omsorgstjenestene. Det er også behov for en nasjonal myndighet som har ansvar for at arbeidet med digitale trusler og håndtering av digitale hendelser slik at dette integreres med og sees i sammenheng med andre beredskapstiltak.

Digitalisering forutsetter at aktørene til en viss grad går i takt for å oppnå helhetlig samhandling og datadeling som støtter opp om målet om sømløse pasientforløp og forenklet datautveksling med helse- og omsorgstjenesten og etater. I digitaliseringsarbeidet vil det være interessemotsetning mellom aktørene som gjør at det er behov for en aktør uten bindinger til egne løsninger som kan veie ulike hensyn mot hverandre og bidra til at nasjonale hensyn blir ivaretatt. Den nasjonale rådsmodellen for e-helse er etablert for å samle sektoren om felles prioriteringer. Nasjonalt e-helseråd er etablert som et rådgivende organ for direktoratet som igjen skal gi selvstendige råd til departementet. KS har bygd opp kompetanse og kapasitet innen digitalisering de senere årene og har etablert felles plan og rammeverk for kommunal sektors ambisjoner innen e-helseområdet. Det er likevel behov for å styrke kommunenes rolle og representasjon i digitaliseringsarbeidet i helse- og omsorgssektoren.

Internasjonalt øker innsatsen knyttet til standardisering. EU-kommisjonens forslag til forordning om det europeiske helsedataområdet (European Health Data Space, EHDS) peker i retning av økt bruk av obligatoriske standarder som virkemiddel. Flere land er i gang med å vurdere egen organisering innen e-helse, i stor grad foranlediget av økt volum og at EU tar en større rolle innen e-helse. Dette gjelder især forordningsforslaget om det europeiske helsedataområdet som bl.a. skisserer obligatorisk etablering av ulike myndighetsfunksjoner – Digital Health Authority; Health Data Access Body; og Market Surveillance Authority. I Norge er obligatoriske standarder mest aktuelt der frivillige metoder ikke når frem, og det er utredet og konkludert med at standarden vil ha en positiv effekt. Retningslinjer og pålegg brukes som virkemiddel for å sørge for at etternølerne tar standardene i bruk.

Behov for tydeligere skille mellom myndighet og tjenesteleverandør

E-helse er myndighetsorgan og departementets faglige rådgiver innen digitaliseringsområdet i saker av strategisk og prinsipiell betydning, mens NHN har det operative ansvaret for mange av sektorens IKT-løsninger. Bakgrunnen for organisasjonsendringer som ble gjennomført i 2020 var å rendyrke rollene som tjenesteleverandør og myndighetsorgan og

unngå at direktoratet skulle komme i en dobbeltrolle som ansvarlig for å levere nasjonale e-helseløsninger og myndighetsorgan innen e-helseområdet.

Til tross for de endringene som er gjennomført for å tydeliggjøre ansvarsfordelingen, er det likevel et gjennomgående tema i innspillene til forvaltningsgjennomgangen at ansvars- og oppgavefordeling mellom E-helse og NHN oppleves som uklar. I tillegg er det utfordringer i samarbeidet mellom virksomhetene som delvis kan skyldes gråsoner og overlapp, uklar styring fra departementet og at virksomhetene har ulike interesser og prioriteringer.

For å redusere overlapp og gråsoner, kan det være aktuelt å se nærmere på direktoratets rolle i gjennomføring av de nasjonale programmene slik at tjenesteleverandøren gis et større ansvar for gjennomføring av de operative oppgavene, mens direktoratet får tydeligere ansvar for myndighetsoppgavene. Det kan i den sammenheng være aktuelt å gjøre en ny vurdering av hvor dataansvaret for de nasjonale e-helseløsningene bør plasseres. Dataansvaret ble overført til NHN samtidig med at NHN overtok ansvaret for de nasjonale e-helseløsningene i 2020. Det ble vurdert som mest hensiktsmessig å flytte dataansvaret sammen med ansvaret for utvikling, forvaltning og drift av løsningene. Erfaring viser at det er noen utfordringer knyttet til at dataansvaret er plassert hos tjenesteleverandøren, f.eks. i sammenheng med spørsmålet om nasjonal og lokal lagring, regelverksfortolkning mm.

Uklar ansvarsfordeling og dublering av ressurser og kompetanse

Prosjektets vurdering er at arbeidsdelingen mellom etatene i hovedsak er slik at digitaliseringsoppgaver som er nært knyttet til bestemte fagområder og utvikling av tjenestene i hovedsak ivaretas av fagetatene, og oppgaver knyttet til helhetlig informasjonsflyt og datadeling på tvers i helse- og omsorgssektoren ivaretas av E-helse.

Innspill fra forvaltningsgjennomgangen viser likevel at det innen noen områder er uklarheter når det gjelder arbeidsdeling. Hdir, E-helse, NHN, RHFene, KS og Oslo kommune peker på at det i dag er uklart hvem som har ansvar for enkelte oppgaver, f.eks. kunstig intelligens, alvorlig sykt barn, velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, elektronisk helsekort for gravide og digitale tjenester til barn og unge.

Både Hdir og FHI har store miljøer for IKT og helsedata som delvis overlapper med kompetansen til E-helse. Det tilsier at det er et visst potensial for å effektivisere gjennom å redusere overlapp og fjerne uklarheter i arbeidsdeling. I Hdir er IKT-miljøene organisert i Divisjon digitalisering og helseregistre som har 188 årsverk, av dette er om lag 60 årsverk knyttet til Pasient- og brukerombudet. FHI har organisert IKT-miljøene, helseregistrene og de befolkningsbaserte helseundersøkelsene i Området for helsedata og digitalisering som har 179 årsverk. En vesentlig del av IKT-ressursene er knyttet til forvaltning av helseregistrene.

Styring av digitaliseringsområdet

Utfordringer knyttet til styring og organisering av e-helseutviklingen er tatt opp i alle de revisjonene som Riksrevisjonen har gjennomført innen området de senere årene. Det gjelder revisjonene av arbeidet med *Én innbygger – én journal*, IKT-sikkerheten i HFene og av helseregisterfeltet som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål.

I rapporten om revisjonen av *Én innbygger – én journal* fra 2021 skriver Riksrevisjonen at «Rollen til nasjonale myndigheter er ikke tydelig definert, og mekanismene for styring, prioritering og forankring av e-helseutviklingen er ikke effektive nok». Riksrevisjonen

kritiserer helsemyndighetenes styring og kontroll av arbeidet med É*n innbygger – én journal*, som viser at det har vært store svakheter i departementets oppfølging og at det ikke har vært god nok fremdrift i gjennomføring av tiltakene. Riksrevisjonen anbefaler bl.a. at departementet sørger for en bedre koordinering av IT-utviklingen, sikrer bedre involvering og medinnflytelse fra sektoren, i større grad involverer forsknings- og fagmiljøer i utrednings-prosesser, videreutvikler og avklarer rollefordeling, viderefører arbeidet med nye mekanismer for prioritering og samfinansiering, og sørger for at felles grunnmur og nasjonale e-helseløsninger blir videreutviklet i tråd med sektorens behov.

I revisjonen av IKT-sikkerheten i HFene i 2019 og 2020 konkluderer Riksrevisjonen med at HOD ikke bruker alle tilgjengelige virkemidler og at E-helse har få oppgaver utover *Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse*. I sluttmerknaden til revisjonen av helseregisterfeltet, som ble gjennomført i 2017, heter det: «Riksrevisjonen mener imidlertid at den komplekse organiseringen av helseregisterfeltet medfører et stort behov for styring og oppfølging».

Styringsutfordringen gjelder både utvikling av digitalisering i sektoren som helhet, forholdet mellom nivåene og arbeidsdelingen mellom E-helse og NHN i gjennomføring av digitaliseringstiltak, noe som stiller store krav til departementets styring. Flere avdelinger i HOD peker på behovet for å bedre departementets styring av digitaliseringsområdet. Det blir også tatt til orde for at departementet i for stor grad har delegert ansvaret for gjennomføring av de store nasjonale e-helseprosjektene til E-helse.

Prosjektet mener at det er et potensial for å bedre departementets strategiske styring innen digitaliseringsområdet og legge større vekt på realisering av nytte for sektoren. Det kan i sammenheng med gjennomføringen av endringer i organiseringen av helseforvaltningen være aktuelt å vurdere justeringer i instruks og vedtekter, vurdere styresammensetning av NHN, og sørge for mer samordnet og effektiv styring fra departementet, inkludert bedre samordning mellom eierstyring og innholdsstyring av NHN. Arbeidet med de formelle styringsdokumentene som foretaksprotokoll og oppdragsdokument skjer i tett samarbeid mellom EHE og EIA. Det er imidlertid behov for å være tettere på oppfølging av NHN i politikkutviklingen på digitaliseringsfeltet. Dette skyldes at NHN de siste årene har fått ansvar for løsninger som er strategisk viktig for digitaliseringsarbeidet i sektoren. Dette utfordrer ansvarsforholdet mellom tjenesteleverandør og myndighetsorgan, særlig grenseflaten mellom premissgiverrollen og løsningsutvikling.

5.3 Egen etat eller integrert i myndighetsorgan med ansvar for tjenesteutvikling

Et strategisk valg departementet står overfor når det gjelder organisering av myndighetsoppgavene innen digitalisering, er om disse oppgavene skal organiseres i en egen etat, eller integreres i en etat som har ansvar for tjenesteutvikling. I tillegg er det aktuelt å vurdere om ansvaret for registrene skal organiseres sammen med digitaliseringsarbeidet eller samles i en annen etat (myndighetsetat eller kunnskapsetat). Se kapitlet 6 om mer samlet forvaltning av helseregistrene.

Digitalisering organisert i egen etat

Alternativet innebærer at dagens organisering med E-helse som myndighetsorgan (med nytt navn) og NHN som tjenesteleverandør videreføres. Skillet mellom myndighet og

tjenesteleverandør opprettholdes og tydeliggjøre. I tillegg er det aktuelt å vurdere grenseflater når det gjelder digitaliseringsoppgaver mellom digitaliseringsdirektoratet og øvrige etater/virksomheter, for eksempel digital sikkerhet, kunstig intelligens, alvorlig sykt barn, velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, elektronisk helsekort for gravide og digitale tjenester til barn og unge.

Det kan også være aktuelt å vurdere om flere forvaltnings- og driftsoppgaver innen IKT-området kan flyttes til NHN. Det siste forutsetter at det etableres systemer som sikrer etatene innflytelse over innhold og prioritering. I tillegg kan det være aktuelt å flytte Helsedataservice og helsedatasatsingen til et samlet helseregistermiljø i en kunnskapsetat eller myndighetsetat, eller alternativt samle digitaliseringsarbeidet og forvaltning av helseregistre.

Det viktigste argumentet for å opprettholde en egen etat er at digitalisering krever samordning på tvers som utfordrer eksisterende styringslinjer, i en sektor preget av sterke og til dels sprikende interesser. Det krever oppmerksomhet og kapasitet for å lykkes. En digitaliseringsetat vil ha mindre kontrollspenn og mulighet for topplederoppmerksomhet som kan gi større potensial for prioritet til dette arbeidet, enn en etat med et bredere ansvarsområde. Det kan også være en fordel at en unngår bindinger til egne løsninger og kan vurdere og avveie hensyn på tvers av etater og ulike deler av tjenesten. Den største ulempen med en egen etat er at det blir større avstand til tjenesteutvikling som kan gjøre at digitalisering blir satt på dagsorden for sent i tiltak for å videreutvikle tjenestene. Dette gir større risiko for å miste helhetsperspektiv mtp. hvilke tjenester helsesektoren har behov for. Det kan også føre til større grad av duplisering av ressurser og kompetanse fordi helsefagmiljøet er i en etat og digitaliseringsmiljøet i en annen. Det kan være en mulighet for at miljøet blir for svakt etter avskallingen mot NHN, eventuell flytting av Helsedataservice og uten forvaltning av helseregistrene. Alternativet har lave omstillingskostnader, men noe potensial for effektivisering – selv uten ansvar for forvaltning av helseregistre. Dette ligger i mulighet for å overføre digitaliseringsoppgaver fra andre etater til digitaliseringsetaten.

Organisering av myndighetsoppgavene innen digitalisering i en egen etat er i tråd med internasjonale trender og kommende forordning om et europeisk helsedataområde (European Health Data Space, EHDS), som bl.a. skisserer behov for etablering av ulike myndighetsorganer. Flere land har valgt en løsning med samlet myndighetsfunksjoner og ansvarsområder innen e-helse til dedikerte organisasjoner (Danmark – Sundhedsdatastyrelsen, Sverige – e-Hälsomyndigheten, Frankrike – Digital Health Agency). Nederland og Tyskland ser behovet for å samle e-helse-oppgavene og vurderer å etablere egne organisasjoner innen e-helseområdet. Egen organisering innen e-helse i disse landene, er i stor grad foranlediget av økt volum og at EU tar en større rolle knyttet til forordnings-forslaget.

Digitalisering som en del av en «samlet myndighetsetat»

Alternativet innebærer at et samlet myndighetsorgan (Hdir) overtar myndighetsoppgavene innen digitaliseringsområdet. Oppgavefordelingen mellom myndighetsorganet og NHN som tjenesteleverandør videreføres omtrent som i dag, men må klargjøres tilsvarende som for alternativet med en egen etat for digitalisering. Oppgavefordelingen med øvrige etater må vurderes nærmere og avhenger av helheten i endringer i organisering av helseforvaltningen. Alternativet tilsvarer omtrent situasjonen før etablering av E-helse og innebærer at hele virksomheten overføres til en samlet myndighetsetat, eventuelt med unntak av avdeling for

helsedata som inkluderer Helsedataservice dersom forvaltning av helseregistrene samles i en kunnskapsetat.

Den største fordelen med dette alternativet er at myndighetsrollen knyttes tettere til tjenesteutvikling og at digitalisering i større grad integreres med andre statlige virkemidler, som faglig normering, tilskuddsforvaltning, regelverksutvikling, informasjon og veiledning. Endringene i oppgavene til E-helse de senere årene, bort fra anskaffelser og drift av løsninger og mer i retning av standardisering og normering, innebærer også at det er enklere å innlemme virksomheten i et samlet myndighetsorgan. Dette alternativet innebærer også at de normerende oppgavene kan sees i sammenheng, noe som gir fordeler all den tid digitaliseringen mer og mer er en integrert del av pasientbehandlingen.

Ulempene er at digitalisering får et mindre synlig organisatorisk avtrykk og ikke får samme plass på dagsorden. Stort kontrollspenn kan føre til at feltet får mindre oppmerksomhet og lavere prioritet i konkurranse med andre oppgaver. Det er betydelige innslag av interessemotsetninger mellom aktørene i sektoren som krever ressurser og oppmerksomhet for å avveie interesser og ivareta nasjonale hensyn om bedre informasjonsflyt og samhandling mellom virksomheter og nivåer i tjenesten.

Alternativet har omstillingskostnader, men også større potensial for effektivisering enn videreføring av et eget digitaliseringsdirektorat uten ansvar for forvaltning av helseregistre. Effektiviseringsgevinstene vil i hovedsak være knyttet til fellesfunksjoner, men det er også et mulig potensial for å redusere overlapp av ressurser og kompetanse.

5.4 Konklusjon

Prosjektet viser til behovet for å styrke digitaliseringsarbeidet for å møte de utfordringene helsetjenesten står overfor med mangel på personell og behov for effektivisering. Videre viser prosjektet til at utfordringer knyttet til styring og organisering av e-helseutviklingen er tatt opp i alle de revisjonene som Riksrevisjonen har gjennomført innen området de senere årene. Sektoren etterspør i større grad nasjonal styring for å sikre en mer koordinert utvikling, og Riksrevisjonen har pekt på behovet for at nasjonale myndigheter tar et større ansvar for dette området. Innspillene til forvaltningsgjennomgangen tyder også på at det innen noen områder er uklarheter når det gjelder arbeidsdeling. Endret organisering kan også bidra til nytenking og påvirke viljen til samordning i tjenestene.

Prosjektet har drøftet om det nasjonale digitaliseringsarbeidet best kan ivaretas i en egen etat eller som en del av et bredere myndighetsorgan. Det er fordeler og ulemper med begge alternativer og prosjektet anbefaler at vurderingen av den organisatoriske forankringen av myndighetsoppgavene innen digitalisering ses i sammenheng med øvrige endringer i organisering. Det gjelder både endringer i organiseringen mellom Hdir og FHI, og forankring av et mer samlet miljø for forvaltning av helseregistre. Endringer i organisering bør bidra til å styrke digitaliseringsarbeidet, sikre en mer effektiv ressursutnyttelse og legge til rette for en klarere arbeidsdeling. Uavhengig av hvor myndighetsoppgavene innen digitaliserings-området forankres, anbefaler prosjektet at det vurderes:

- Tiltak for å spisse og tydeliggjøre myndighetsoppgavene innenfor standarder, kodeverk og terminologi, kunnskapsbasert digitaliseringsarbeid, realisering av gevinster av investeringene og støtte til sektoren – særlig kommunesektoren og for samhandling på tvers av forvaltningsnivåene

- Ytterligere justeringer i oppgavefordelingen mellom myndighet og tjenesteleverandør, herunder ansvaret for gjennomføring av nasjonale programmer og om det er mer hensiktsmessig at myndighetsorganet har dataansvaret for de nasjonale e-helseløsningene
- Tiltak for å bedre departementets strategiske styring innen digitaliseringsområdet, herunder forholdet mellom eierstyring og innholdsstyring fordi NHN har fått en langt mer sentral rolle enn tidligere, samt hvordan departementet i større grad kan styre på realisering av nytte for sektoren.
- Vurdere mulighet for mer samling av digitaliseringsoppgaver som i dag ligger i andre etater, spesielt Hdir og FHI, sammen med digitaliseringsoppgaver som i dag ligger i E-helse.

6 Mer samlet forvaltning av helseregistrene

6.1 Dagens ansvars- og oppgavefordeling

Ansvar for forvaltning av nasjonale helseregistre er fordelt på Hdir, FHI og RH-ene. Hdir har ansvar for Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), som er registre med administrasjon og styring som hovedformål. FHI har ansvaret for en rekke nasjonale registre som har helseovervåking, analyser og forskning som primærformål, herunder Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK). SLV har ansvar for bivirkningsregisteret. RHFene har ansvaret for de medisinske kvalitetsregistrene og for Kreftregisteret (enhet i Oslo universitetssykehus med eget styre) med tilhørende kvalitetsregistre. Det er i dag nær tilknytning mellom hovedformålene til registrene og samfunnsoppdraget til etatene som har ansvaret for forvaltning av dem. Data registrene brukes imidlertid også av andre etater i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og av eksterne aktører.

Det er registerforvalterne som er dataansvarlige og har ansvar for strategisk utvikling av registre, herunder gi råd til departementet om etablering av nye registre, utvidelse av eksisterende registre, og prioriteringer i arbeidet med å videreutvikle registrene. RHFene gjennom sine HF er dataansvarlige for de fleste nasjonale medisinske kvalitetsregistrene med unntak av kvalitetsregistrene som er tilknyttet Medisinsk fødselsregister og Hjerte- og karregisteret. FHI er dataansvarlig for disse registrene og har inngått databehandleravtale med HFene om forvaltning av registrene. RHFene driver også Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre som tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dataansvaret for befolkningsbaserte helseundersøkelser og biobanker, sosioøkonomiske og demografiske data, og grunndata ligger i dag spredt på mange virksomheter også utenfor forvaltningen.

NHN håndterer teknisk drift (ikke forvaltning) av registrene til FHI og Hdir og de fleste nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Kreftregisteret bruker en egenutviklet plattform (KREMT) til drift av kvalitetsregistrene på kreftområdet, men det er besluttet at disse på sikt skal over på samme plattform som øvrige registre.

Systemet for tilgang til helsedata omfatter også ulike godkjenningsmyndigheter som i tillegg til den enkelte registerforvalter, behandler søknader om tilgang til og bruk av data, for eksempel Hdirs behandling av dispensasjon fra taushetsplikten, REKs etiske godkjenning av forskningsprosjekter og SSBs behandling av tilgang til sosioøkonomiske data. E-helse har gjennom forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata fått hjemmel til å behandle søknader og beslutte tilgang til data fra nasjonale helseregistre (inkl. medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status) og FHIs befolkningsundersøkelser. Vedtaksmyndigheten overføres gradvis og E-helse ved Helsedataservice overtar fra 15. mars 2023 vedtaksmyndigheten for søknader om tilgang til data fra følgende registre: NPR, KPR, Legemiddelregisteret, SYSVAK, MSIS og andre lovbestemte registre.

Hdir har organisert forvaltning av helseregistrene i avdeling for helseregistre (89 årsverk) i Divisjon for digitalisering og helseregistre. FHI har organisert forvaltning av helseregistrene og de befolkningsbaserte helseundersøkelsene, med unntak av infeksjonsregistrene, i Område for helsedata og digitalisering (om lag 85 årsverk til forvaltning av registrene). Smittevernregistrene er organisert i en egen avdeling i Området for smittevern (om lag 24

ansatte, jf. hjemmesiden). I Hdir har Divisjon for digitalisering og helseregistre følgende avdelinger: Avdeling helseregistre (utvikler og forvalter tekniske løsninger for registrene); Avdeling utvikling og digitale kanaler (utvikler og forvalter Hdir og Helfos IKT-systemer og digitale kanaler for helsefaglig innhold); og Avdeling prosjekt og tjenestedesign (utvikler digitale tjenester). I FHI er IKT-miljøene organisert i en IT-klynge i Området for helsedata og digitalisering. Området inkluderer følgende avdelinger: IT-systemer i Bergen; IT-systemer i Oslo; og Nettportaler og samhandling. IT-avdelingene ivaretar bl.a. forvaltning, drift og utvikling av IT-systemer for registrene, og støttefunksjoner, verktøy og arbeid med felleskomponenter og designbibliotek. I tillegg er det en egen avdeling for rådgivning e-helse med ansvar for rådgiving, prosjektledelse, programledelse og porteføljestyring innenfor IT og e-helse.

6.2 Bakgrunn for å vurdere organisasjonsendringer

Det er behov for fornying og digitalisering av registrene for å forenkle tilgang til helsedata, særlig ved behov for data på tvers av registre. Videre er det behov for investeringer på tvers av registrene for samlet å ivareta helsepolitiske mål knyttet til utvikling av kvalitet i tjenesten, videreutvikling av tjenestene, pasientrettigheter og beredskap. I sluttmerknaden til revisjonen av helseregisterfeltet, som ble gjennomført i 2017, heter det: «Riksrevisjonen mener imidlertid at den komplekse organiseringen av helseregisterfeltet medfører et stort behov for styring og oppfølging». Selv om det har vært en positiv utvikling innen området i det siste tiåret, er det fremdeles i begrenset grad etablert tekniske fellesløsninger på tvers av registrene, og kvalitetsregistrene kan i liten grad gjenbruke data fra pasientjournalsystemer og elektroniske fagsystemer. Det gjenstår således et betydelig arbeid med å modernisere de sentrale helseregistrene. I tillegg gjenstår utfordringer med tilgjengeliggjøring av helsedata til styringsinformasjon, helseanalyser, kvalitetsforbedring og forskning, selv om regelverket er forbedret og Helsedataservice er under utvikling som felles løsning for tilgang til data fra helseregistrene. Etablering av Helsedataservice vil bidra til å forenkle søknadsprosessen, men uten Helseanalyseplattformen må den enkelte registerforvalter fremdeles tilgjengeliggjøre og legge til rette for sammenstilling av data.

Prosjektets vurdering er at det er behov for å forbedre og effektivisere forvaltning og utvikling av registrene og legge til rette for enklere datafangst og økt bruk av datamaterialet. Større grad av samling av registerforvaltningen i en etat kan bidra til å nå disse målene, bl.a. gjennom å fremme utvikling av felles tekniske grensesnitt og harmonisering av innholdet i registrene. Dagens organisering med nasjonale registre spredt på flere registerforvaltere gjør det mer krevende å få til standardisering og harmonisering for å oppnå effektiv forvaltning og drift, samt at det skaper utfordringer med å forenkle tilgang til helsedata – særlig ved behov for data på tvers av registre. Nærhet til fagmiljø og spesialisering av registrene bidrar til å ivareta behovene registerforvalterne har for å ivareta sitt samfunnsoppdrag knyttet til registerbruk. Koblingen mellom etatenes samfunnsoppdrag og registrenes hovedformål bidrar også til at registrene utvikles til å dekke helsetjenestens behov for nye registre og data, men kan samtidig risikere å bidra til å begrense utnyttelsen av registrene på tvers av fagmiljø, inkludert på tvers av forvaltningen.

Vurderingen er at større grad av samorganisering er et viktig virkemiddel for å få sterkere framdrift i arbeidet med å utvikle registerfeltet, bl.a. ved å bidra til å utvikle felles teknisk grensesnitt og effektivisere arbeidet med datafangst og automatisk innrapportering. Dette er

oppgaver som både krever innsats fra en nasjonal myndighet innen digitalisering og som krever innsats fra tjenesten. Selv om det er et potensial for å stille tydeligere krav til etatene og videreutvikle fellesløsninger innenfor dagens organisering, vil ikke dette i samme grad legge til rette for å styrke arbeidet med en helhetlig utvikling av registerfeltet. Prosjektet viser til at helseregisterområdet også bør vurderes i lys av den strategiske utviklingen i EU innen dette området. Hovedlinjene i forordning om det europeiske helsedataområdet, European Health Data Space (EHDS), omfatter bruk av internasjonale standarder, terminologi og kodeverk, bedre rammer for sikker og effektiv digital samhandling, samt behov for en nasjonal helsedatamyndighet. Den danske Sundhedsdatastyrelsen er et eksempel på en organisering der arbeidet med standarder, terminologi og kodeverk er organisert i samme virksomhet som nasjonale helseregistre til sekundærbruk. Større oppmerksomhet på synergier mellom primær- og sekundærdata kan bidra til økt datakvalitet og mer utbredt bruk av registerdata.

Ved å samle forvaltning av de nasjonale registrene legges det også til rette for å integrere Helsedataservice som nasjonal funksjon for tilgang til helsedata i samme organisasjon. I tillegg til å etablere «en vei inn» for søknader om tilgang til data, vil en oppnå å samle både søknadsbehandling, tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av data i én virksomhet. Det løser også noen av de utfordringene registerforvalterne har pekt på når det gjelder skillet mellom søknadsbehandling i Helsedataservice og tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av data via registerforvalterne (manglede kjennskap til data, kompetanse og ressurser, mulig dobbeltarbeid osv.), jf. innspill til høringen av forskriften som gir Helsedataservice vedtaksmyndighet. Det var bred støtte til forslaget, men bekymring for at funksjonen ikke tilføres tilstrekkelig ressurser og kompetanse. En slik samling kan bidra til å styrke Helsedataservice og til mer effektiv utnyttelse av ressursene i en situasjon der det ikke lenger er aktuelt å realisere Helseanalyseplattformen som en felles dataplattform.

Både Hdir og FHI er opptatt av at et organisatorisk skille skaper større avstand mellom miljøene som skal bruke data og miljøet som forvalter registrene, gir mindre innflytelse over utvikling av registrene, ikke gir rask nok tilgang til data og gir økt risiko for misforståelser og feil. *Hdir* legger vekt på at forvaltning av KPR og NPR er tett knyttet til direktoratets myndighetsutøvelse. Data fra registrene brukes direkte som styringsinformasjon for finansiering av helsetjenesten, for kvalitetsmåling og -utvikling, for å kunne følge opp for eksempel fristbrudd, forløp og rettigheter som er en del av direktoratets følge-med-rolle osv. *FHI* legger vekt på nærhet til et analyse- og forskningsmiljø som bruker data fra registeret. Instituttet åpner for at det kan være gevinster ved å samle registrene i én organisasjon, men at dette krever grundig planlegging og investeringer. FHI mener videre at det vil være særlig høy risiko for registrene innen smittevernområdet. Det vises til at smittevernregistrene skiller seg fra de andre registrene når det gjelder krav til tilgjengelighet, nærhet til fagkompetanse og tilgjengelighet for nøkkelpersoner som følger opp varslingspliktige sykdommer eller utbruddsetterforskning. Flere av registrene innen smittevernområdet, særlig MSIS, er fremdeles basert på mer manuell innmelding og det gjør det mer krevende å løsrive registrene fra fagmiljøet. Samtidig er det et mål at registeret skal bli mer automatisert.

Det er en forutsetning at etatene har enkel og løpende tilgang til data som er nødvendig for å løse samfunnsoppdraget, og Helserettsavdelingens vurdering er at adgangen til å bruke dataene i registeret ikke vil endres med en samlet organisering. Det blir imidlertid viktig at det kan etableres databehandleravtaler som sikrer fleksible løsninger for tilgang til data på tvers

av organisatoriske grenser innenfor dagens regelverk. Et samlet miljø for helsedata vil bli leverandør av data og fast statistikk til tjenesten og forvaltningen. Organisatorisk samling av registrene vil ikke løse behovet for investeringer i modernisering av registrene og vil ha omstillingskostnader som kan være krevende å håndtere, men kan bidra til bedre prioriteringer og mer kostnadseffektiv utvikling på tvers av det enkelte register over tid.

Prosjektets vurdering er at det er mest aktuelt å samle Dødsårsaksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Abortregisteret, Nasjonalt hjerte- og karregister og Legemiddelregisteret som FHI har dataansvaret for, og NPR og KPR (inkl. det historiske IPLOS-registeret) som Hdir har dataansvaret for. Det kan også være aktuelt å inkludere overvåkningssystemene for smittsomme sykdommer og antibiotikaresistens, avhengig av organisatorisk forankring av et mer samlet registermiljø og hvordan smittevernmiljøene kan sikres tilgangen til data fra disse registrene. Prosjektet anbefaler at det vurderes å legge Kreftregisteret som en del av et samlet registermiljø og viser til at det flere ganger har vært vurdert å endre den organisatoriske forankringen av registeret slikt at det blir en del av helseforvaltningen. Kreftregisteret er i dag nærmere knyttet til tjenesten enn de andre lovbestemte registrene gjennom å være en del av et samlet kreftkunnskapsmiljø ved Radiumhospitalet, har dataansvaret for kvalitetsregistrene innen kreftområdet (tilsvarende som kvalitetsregistre knyttet til fødselsregisteret og hjerte-/karregisteret), inkluderer et stort forskningsmiljø og har det administrative ansvaret for offentlige screeningprogrammer innen kreftområdet. Prosjektets vurdering er at miljøet bør beholdes mest mulig samlet og mener derfor at det er mest aktuelt å inkludere Kreftregisteret som del av en kunnskapsetat.

6.3 Alternativer for organisatorisk forankring

Prosjektet har vurdert to alternativer for mer samlet forvaltning av helseregistrene:

1) etablere et «helsedatadirektorat» med ansvar for helseregistre og digitalisering
2) samle registrene i en kunnskapsetat eller en myndighetsetat

Det må gjøres en helhetlig vurdering av de organisatoriske alternativene opp mot øvrige endringer i organisering, særlig endringer i organisering av FHI og Hdir og myndighetsoppgavene innen digitaliseringsområdet. Se kapittel 12 for omtale av helhetlige modeller. Det kan uavhengig av modell være aktuelt å vurdere om flere oppgaver når det gjelder teknisk forvaltning og drift av registrene bør ivaretas av NHN. Det forutsetter at det etableres et system som sikrer etaten som forvalter registrene innflytelse over innhold og prioritering.

«Helsedatadirektorat» med ansvar for helseregistre og digitalisering

Alternativet innebærer at digitalisering, forvaltning og drift av flere helseregistre (inkludert dataansvar) og Helsedataservice samles i en etat etter mønster fra Sundhedsdatastyrelsen i Danmark. E-helse inngår i sin helhet i «helsedatadirektoratet». Det samme gjelder avdelingene for helseregistre i Hdir og FHI, og deler av IKT-avdelingene i FHI som ivaretar oppgaver for registrene. Samlet sett innebærer dette om lag 80-90 årsverk fra hver av virksomhetene. I tillegg kan det være aktuelt å vurdere om det er hensiktsmessig å flytte smittevernregistrene til en slik etat. Det avhenger delvis av hvordan smittevernarbeidet blir organisert, og delvis av en vurdering av om omfanget av manuell rapportering og om tilknytningen til smittevernarbeidet gjør dette uhensiktsmessig. Alternativet kan kombineres med alle alternativer for organisering av FHI og Hdir.

Alternativet gir tettere kopling mellom helsedata og digitalisering enn i dag og gir større mulighet for standardisering og harmonisering av tekniske løsninger mellom registrene og på tvers av primær- og sekundærbruk av helsedata. Dette var også bakgrunnen for at E-helse fikk et større ansvar innen helsedataområdet, med etablering av Helsedataprogrammet i 2017 og med beslutningen om å legge Helsedataservice til direktoratet. Organisering av Helsedataservice sammen med forvaltning av de nasjonale registrene kan bidra til å gjøre tjenesten mer robust i en situasjon der Helseanalyseplattformen ikke blir realisert. Alternativet er også i tråd med utviklingen av EUs forordning om det europeiske helsedataområdet, og en utvikling som har pågått over flere år innen helsedataområdet. Utviklingen av registrene må i større grad tilpasses den tekniske utviklingen av journalsystemene og de digitale samhandlingsløsningene. Dette vil kunne bidra til å forbedre kvaliteten i helseregistrene, redusere rapporteringsbyrden og legge til rette for utvikling av bedre løsninger for primærbruk fordi utviklingen av digitale løsninger i større grad tar hensyn til behovene i tjenesten. Det vil også kunne bidra til større vekt på behovene til hele bredden av aktører som har behov for data fra registrene.

Ulempen er at registrene i dette alternativet flyttes lengre unna fagmiljøene i etatene og formålene de er opprettet for. Det bryter på denne måten verdikjeden for disse fagmiljøene. Det kan argumenteres for at etater som har ansvar for utvikling av helsetjenesten, helseovervåking, kunnskapsproduksjon og beredskap har bedre forutsetninger for utvikling av registrene i tråd med behovene enn et helsedatadirektorat. Videre vil disse etatene ha den samme styringen over prioriteringene i utvikling av registrene dersom de ikke selv har ansvar for forvaltningen. Etablering av et «helsedatadirektorat» forutsetter nært samarbeid med øvrige etater, og det må etableres databehandleravtaler for å sikre etatene løpende tilgang til data som de trenger for å løse samfunnsoppdraget. Videre må et helsedatadirektorat, på samme måte som Hdir og FHI i dag, ha samarbeid med tjenesten og andre brukere av data fra registrene.

Stordriftsfordelene ved samling av registrene vil ikke løse investeringsbehovene framover, men det vil kunne gi en mer helhetlig prioritering av investeringene i modernisering og utvikling av felles tekniske løsninger. Alternativet vil ha omstillingskostnader som må ses i sammenheng med øvrige endringer i organisering.

Integrere helseregistre i en kunnskapsetat eller en myndighetsetat

Alternativet innebærer at forvaltning og drift av helseregistrene i Hdir og FHI samles, enten i en kunnskapsetat eller i en myndighetsetat. Myndighetsoppgaver innen digitaliseringsområdet (terminologi, kodeverk og standardisering) forblir enten i et eget digitaliseringsdirektorat eller flyttes til en ny myndighetsetat. Alternativet kan kombineres med alle alternativene for endret organisering av FHI og Hdir. Om registrene plasseres i myndighets- eller kunnskapsetaten må sees i sammenheng med hvor grensen mellom myndighetsoppgaver og kunnskapsproduksjon settes. Det bør vurderes om Helsedataservice må organiseres sammen med forvaltning av registrene fordi det kan gi effektiviseringsgevinster å samle søknadsbehandlingen, tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av data fra registrene.

Den største fordelen med å samle registrene i en kunnskaps- eller myndighetsetat er at forvaltning av innholdet i registrene knyttes tettere opp mot miljøene i helseforvaltningen som skal benytte registrene og dermed legge til rette for at registrene treffer behovet for å ivareta

samfunnsoppdraget. Fagmiljøet som registrene er forankret i vil beholde styringen over utvikling av registrene. Dersom Helsedataservice inkluderes, vil det kunne bidra til å styrke den videre utviklingen av Helsedataservice og gjøre tjenesten mer robust i en situasjon der Helseanalyseplattformen ikke blir realisert. Dersom registrene samles i en myndighetsetat, vil registrene imidlertid ligge utenfor styringslinjen til kunnskapsetaten og ha noen av de samme ulempene for denne etaten som i alternativet der registrene blir plassert i et «helsedatadirektorat». Tilsvarende gjelder for myndighetsetaten hvis registrene samles i kunnskapsetaten.

Ulempen er at alternativet ikke gir den koplingen mellom digitalisering og utvikling av registrene som har vært pekt på som viktig, og som var bakgrunnen for at Helsedataprogrammet ble forankret i E-helse. Forankring av registrene i et kunnskapsmiljø som bruker data til egen kunnskapsproduksjon kan også oppleves som en utfordring for eksterne forskningsmiljø som har uttrykt bekymring for at det ikke blir lik tilgang til data for alle.

Alternativet har omstillingskostnader og vil i likhet med alternativet med et helsedatadirektorat ikke løse investeringsbehovene framover. Mer samlet forvaltning av registrene vil imidlertid kunne gi en mer helhetlig prioritering av investeringene i modernisering og utvikling av felles tekniske løsninger.

6.4 Konklusjon

Prosjektets vurdering er at det er behov for å forbedre og effektivisere forvaltning og utvikling av helseregistrene og å legge til rette for enklere datafangst og økt bruk av datamaterialet. Større grad av samling av registerforvaltningen i en etat kan bidra til å nå disse målene, bl.a. gjennom å fremme utvikling av felles tekniske grensesnitt og harmonisering av innholdet i registrene. Dagens organisering med nasjonale registre spredt på flere registerforvaltere gjør det mer krevende å få til standardisering og harmonisering for å oppnå effektiv forvaltning og drift, og skaper utfordringer med å forenkle tilgang til helsedata – særlig ved behov for data på tvers av registre. Prosjektet anbefaler derfor at:

- Helseregistrene som FHI og Hdir har ansvar for samles i en etat (Dødsårsaksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Abortregisteret, Nasjonalt hjerte- og karregister og Legemiddelregisteret som FHI har dataansvaret for, og NPR og KPR som Hdir har ansvar for.
- Det vurderes om smittevernregistrene også inkluderes i et samlet registermiljø, avhengig av organisatorisk forankring, arbeidet med automatisering av datainnsamling og hvordan smittevernmiljøene kan sikres tilfredsstillende tilgang til data. Samtidig er det viktig at etatene uansett har tilgang til data for å løse sine samfunnsoppdrag.
- Det vurderes om registrene enten samles i et «Helsedatadirektorat», integreres i myndighetsetat eller integreres i en kunnskapsetat. Valg av organisatorisk forankring vurderes som en del av helheten av organisasjonsendringer, jf. omtalen av helhetlige modeller i kapittel 12.
- Kreftregisteret inkluderes i et samlet registermiljø dersom dette forankres i en kunnskapsetat
- Helsedataservice vurderes inkluderes i et samlet registermiljø uavhengig av organisatorisk forankring

- Flere oppgaver knyttet til forvaltning og drift av registrene vurderes flyttet til NHN, men dette forutsetter at det etableres et system med innflytelse over innhold og prioriteringer

7 Kunnskapsstøtte til og kompetansesentre for kommunal sektor

7.1 Dagens organisering av kompetansesentrene

Kompetansesentrene

Omfanget av kompetansesentre under HOD som har kommunal sektor som primær målgruppe har utviklet seg gradvis og utgjør i dag et stort omfang. Samlet sett er det over 20 slike kompetanse-, kunnskaps-, og forskningssentre på regionalt eller nasjonalt nivå, i tillegg til utviklingssentrene.

Det samlede tilskuddet til kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten er omfattende, i underkant av 1 mrd. kroner over Prop. 1 S. Mer konkret:

- Kap. 761 (Omsorgstjeneste) – 78 mill. kr årlig
- Kap. 762 (Primærhelsetjeneste) og Kap. 783 (Personell) – 62,6 mill. kr årlig
- Kap. 765 (Psykisk helse, rus og vold) – 585,2 mill. årlig
- Kap. 770 (Tannhelsetjenester) – 152,2 mill. kr årlig

Tilskuddene forvaltes av Hdir. Samlet sett omfatter kompetansesentrene trolig rundt 7-800 årsverk.

I 2012 fikk Hdir i oppdrag å gjennomgå regionale og nasjonale kompetansesentre utenfor RHFene. Hensikten var å sikre en formålsrettet og god samlet utnyttelse av ressursene, tilpasset målgruppens behov. Til tross for gjennomgangen og ulike foreslåtte tiltak, gjenstår det noen utfordringer:

For det første, sentrene er i hovedsak blitt etablert innen kunnskapssvake områder i perioden 1991 til 2008 gjennom bevilgninger på statsbudsjettet og som ledd i ulike satsinger (opptrappingsplaner, stortingsmeldinger og lignende). Det er, med andre ord, ingen enhetlig systematikk mtp. hvilke områder det er avsatt penger til og hvilke områder som har fått lite/mindre ressurser. Områdene kompetansesentrene dekker, stemmer med andre ord ikke helt med dagens utfordringsbilde og dermed kunnskaps- og kompetansebehovene i kommunal sektor.

For det andre, ulik eierstruktur gir veldig ulik mulighet for styring av sentrene. Noen av sentrene er indirekte eller direkte statskontrollert, og kan gis oppdrag i medhold av unntaket om utvidet egenregi, andre kan det ikke. Denne variasjonen eksisterer også innenfor samme sentertype (f.eks. for de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTSene)).

For det tredje bidrar det faktum at det er så mange sentre som har kommunene som nedslagsfelt og mottakere, til at det er krevende for kommuner å navigere i tilbudene som finnes. Det er bl.a. eksempler på overlappende tilbud. Dette har imidlertid blitt noe bedre gjennom at Hdir har tvunget gjennom mer samarbeid og felles planlegging.

I tillegg har innskjerpingen av at tilskuddsvirkemiddelet ikke kan følges av konkrete leveranser, vanskeliggjort både samlet og individuell styring av sentrene. Samtidig har det blitt gjort et godt arbeid ved å samordne samfunnsoppdrag og dermed gi nettverk av sentre et mer lignende sett av oppgaver.

7.2 Bakgrunn

Gjennom prosjektprosessen er det blitt tydeliggjort et behov for å gi mer støtte til kommunal sektor. Mange av utfordringene vi står overfor i helse- og omsorgstjenesten vil i særlig grad ramme kommunal sektor: personellutfordringer og sentralisering for å nevne noe. Sektoren vil derfor ha et stort behov for støtte til å gjøre de riktige prioriteringene (jf. bl.a. NOU 2023: 4 *Helsepersonellkommisjonen*).

For å kunne bruke de begrensede ressursene der de gir mest nytte og på en mest mulig riktig og rettferdig måte, må vi ha kunnskap om tiltakene som vurderes iverksatt. De senere årene har forskningsmidler blitt mer målrettet mot kommunene (jf. vedlegg til Forskningsrådets årsrapport 2021, Departementsvis rapportering), men det mangler fortsatt mye kunnskap og forskning i, med og for den kommunale sektoren, inkludert kunnskapsbehovene innen folkehelsearbeidet (jf. Folkehelsemeldingen). Det er videre en utfordring at kunnskap som utvikles ikke utnyttes godt nok i kommunene, at kunnskapen ikke er satt i tilstrekkelig system og at det er krevende å spre og implementere kunnskapen som produseres (jf. bl.a. Meld. St. 38 (2020-2021) *Nytte, ressurs og alvorlighet,* Meld. St. 5 (2022-2023) *Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032*).

I kapittel 3 om Hdir og FHI understrekes det at helseforvaltningen har behov for gode kunnskapsmiljøer og solid kunnskapsgrunnlag for å kunne gjøre gode vurderinger og ta riktige beslutninger. Et relevant spørsmål er dermed hvordan forskningen styres best mulig, slik at den er riktig dimensjonert og i tråd med samfunnsoppdraget – og på en slik måte at den kan bidra til å understøtte kunnskapsbasert praksis i kommunal sektor. Organiseringen bør også legge til rette for å kunne gi implementeringsstøtte til kommunene.

Prosjektet har drøftet og vurdert om en samling av kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten vil kunne bidra til å møte behovene kommunal sektor har for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling, samt bidra til kunnskapsoppsummeringer og støtte ved implementering av tiltak. Dette er også løftet som forslag av FHI, i skriftlig innspill til prosjektet.

7.3 Mulige løsninger for en mer samlet organisering

Det er behov for å utnytte ressursene i kompetansesentrene bedre enn i dag, og å se sentrene i sammenheng med andre kunnskapsmiljøer i forvaltningen. Prosjektet anbefaler derfor at det i oppfølgingen bør utredes en samling av kompetansesentrene for en mer helhetlig tilnærming. Kunnskapsfunksjoner og grenseflater til kunnskapsetaten, herunder kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger, bør inngå som problemstillinger for videre utredning. Samtidig bør statsforvalterens rolle vurderes opp mot en slik samling (se seksjon 11.1 for videre drøfting). Prosjektet vurderer at det er fire alternative modeller for et mer helhetlig system for kompetansesentrene for kommunene, med ev. underalternativer:

- Modell 1: Fortsette tilskuddsfinansieringen av dagens miljøer (Null-alternativet)
- Modell 2: Oppgavene settes ut på oppdrag (Konkurransemodellen)
- Modell 3: Egenregi: Nasjonalt institutt eller divisjon/område integrert i en kunnskapsetat, og med ulike geografiske lokalisasjoner (Forvaltningsmodellen)
- Modell 4: Utvidet egenregi: Etablering av eget selskap/foretak (Foretaksmodellen) med ulike alternativer for kobling til og rolledeling overfor en kunnskapsetat, samt med ulike geografiske lokalisasjoner

Modell 1: Null-alternativet

Et null-alternativ vil være å fortsette med dagens modell, der Hdir forvalter tilskuddene. I denne modellen kan det arbeides videre med å samordne og ev spisse samfunnsoppdraget, med tanke på en mer helhetlig tilnærming. Det kan da legges opp til at sentrene samarbeider innenfor rammene av et kunnskapssystem for kommunal sektor og med kunnskapsetaten som nav.

Fordelen med denne modellen er at den er lite ressurskrevende *på kort sikt*. Den har også mindre risiko enn de øvrige modellene, og gir rom for at tilskudd kan nedskaleres eller bortfalle. Det kan imidlertid være politisk krevende å nedskalere/ta bort tilskudd, jf. diskusjonen om dette etter fremleggelse av Prop. 1 S (2022-2023) knyttet til pasient- og brukerorganisasjoner. Prosjektet vurderer derfor at dette rommet i praksis vil være begrenset og ikke gi den ønskede fleksibiliteten.

Det er videre en ulempe at modellen på sikt vil være mer ressurskrevende; en mer bærekraftig utvikling forutsetter at ressursene brukes mer riktig (riktig prioritering). Det er et stort behov for å utnytte kompetansesentrene på en annen måte enn i dag, for å styrke kommunenes kunnskapsgrunnlag og kompetanse. Det samme gjelder veiledning mht. implementering av kunnskap i kommunal sektor og innen folkehelsearbeidet, inkludert samhandling med HFene.

Det er også en mulighet innenfor denne modellen å gjøre tilskuddene søknadsbasert, og å utarbeide tydeligere tilskuddsvilkår. Dette vil kunne gi en økt bevissthet og bedre oversikt over enkeltstående tilskudd. En slik ordning vil også kunne bidra til at man kan vurdere mottakerne på like(re) vilkår og ut fra kriterier som vil gi mest verdi.

Ulempen med å gjøre tilskuddene søknadsbasert, er som for forrige alternativ, at det vil gjøre driften uforutsigbar, skape bekymringer for videre drift, føre til nedbemanninger på grunn av usikkerheten og derigjennom føre til redusert aktivitet som ikke er ønskelig. Videre vil det skape mye politisk støy og uro når miljøer ikke får innvilget støtte.

Prosjektet vurderer at det innenfor denne modellen også er et alternativ at kunnskapsstøtte-systemet som er under utvikling ved FHI og Førstelinjeløftet som Hdir har fremmet, blir en del av kompetansesenterstrukturen med et mer spisset mandat og samorganisert og administrert fra kunnskapsetaten. Formaliseringen av et kunnskapsstøttesystem kan i noen grad bidra til bedre struktur på kunnskapen som utvikles, og en mer strategisk styrt innføring av kunnskap i kommunal sektor gjennom kompetansesentrene.

Modell 2: Konkurransemodellen

Dersom tilskuddsvirkemiddelet ikke i tilstrekkelig grad bidrar til at HOD får det nødvendige ut av de totale investeringene som går inn i kompetansesentrene for kommunene, er det i praksis to alternativer. Man kan enten a) gå over til et system hvor oppgavene settes ut på oppdrag (konkurranse-modellen) eller b) man kan endre organisatorisk forankring av sentrene slik at oppgavene kan utføres i egenregi eller innenfor unntaket om utvidet egenregi. Egenregi-alternativet kan dermed deles inn i to alternativer: eget forvaltningsorgan/institutt eller etablering av et eget selskap/foretak (se beskrivelse av hhv modell 3 og 4 under).

Konkurransemodellen innebærer at man endrer dagens system med tilskuddsfinansiering av sentrene, til et system der oppgavene settes ut på oppdrag. Her kan man se for seg at oppdragene kan ha en varighet på mellom 3 og 5 år.

En slik modell vil kunne gi mer fleksibilitet enn dagens modell mtp hva det forskes på og hvilken kunnskap som oppsummeres og formidles (hva det til enhver tid er behov for at man får mer kunnskap om).

Modellen fremstår imidlertid som krevende mht. administrasjon og omfang av transaksjoner, da man i praksis vil måtte etablere et «mini-NFR» i Hdir – som da får ansvar for å vurdere kunnskapsbehov og fordele midlene (1 mrd. kroner) etter nærmere bestemte kriterier. Sammenhengen med en ev. kunnskapsetat vil også være uklar.

En omlegging til en konkurransemodell vil også skape uro og ustabilitet i de etablerte miljøene. I tillegg vil mye av tiden som burde vært brukt til kunnskapsgenerering, kvalitetsforbedring og implementering, bli brukt til å søke om midler.

For spesialisthelsetjenesten har man valgt en konkurransebasert modell med midlertidighet. Det gir rom for å avvikle og etablere sentre utfra behov og leveranser/ytelser. Dette kan imidlertid gjennomføres innen rammene av relativt store HF hvor arbeidstakere kan tilbys andre arbeidsoppgaver når et senter avvikles. Dette er krevende i et heterogent system av kompetansesentre som har kommunal sektor som primær målgruppe, hvor sentrene er mer adskilte enheter. Det kan argumenteres for at samordnet organisering (de to neste modellene) vil gi mer fleksibilitet for å kunne gjøre endringer.

Modell 3: Forvaltningsmodellen

Et alternativ er dermed å vurdere en form for egenregi. Sentrene er i dag organisert som stiftelser, selskap, er del av UH-sektor, er del av større forskningsinstitutter eller del av RHF-systemet. En helhetlig tilnærming vil medføre å endre organisatorisk forankring til å bli en del av staten (Forvaltningsmodellen) eller opprette en ny juridisk enhet som oppfyller vilkårene for utvidet egenregi (se modell 4 under).

Modell 3a: Instituttmodellen

En variant av forvaltningsmodellen innebærer at det etableres et nasjonalt institutt for kommunale helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid.

Instituttet vil kunne organiseres som et eget forvaltningsorgan på nivå 2. Instituttet bør, for å sikre god lokal forankring, etableres med ulike regionale lokalisasjoner som ivaretar lokaliseringen av dagens kompetansesentre.

Fordelen med forvaltningsmodellen, er den helhetlige tilnærmingen – sentrene etableres i en samlet moderorganisasjon som har det samordnende og helhetlige ansvaret. Modellen gir også mulighet for en mer fleksibel styring, basert på kunnskapsbehovene, og vil gi en samlet økonomisk rammestyring. Ved i tillegg å etablere lokale forankringspunkter, vil det også langt på vei møte behovet for støtte til lokal implementering og strategisk støtte til kommunal sektor. Styringen av sentrene vil også bli mer oversiktlig enn i dag.

Kommunene må selv definere sine kunnskapsbehov og bidra inn i arbeidet med kunnskapsgenerering og prioritering basert på kunnskap om lokale behov og utfordringer.

Forvaltningsmodellen vil imidlertid være krevende mtp å sikre medinnflytelse og eierskap fra kommunene gjennom for eksempel roller i styrer e.l.

Å etablere et (nytt) nasjonalt institutt med flere regionale lokalisasjoner, vil også føre til at det vil bli en vesentlig økning i antallet personer ansatt i sentralforvaltningen.

Modell 3b: Kunnskapsetatsmodellen

Et alternativ til å etablere et nytt institutt vil være å etablere en divisjon/område for «kunnskapsstøtte og kompetansesentre» i kunnskapsetaten. De regionale lokalisasjonene beskrevet under modell 3a, vil i denne modellen kunne etableres som ytre etater som styres av divisjonen/området som er det nasjonale organet.

I likhet med modell 3a, vil modell 3b legge til rette for en helhetlig tilnærming av sentrene og en styring av sentrene som er mer oversiktlig og helhetlig enn i dag. Modellen gir også mulighet for en mer fleksibel styring, basert på kunnskapsbehovene.

Ved å etablere en divisjon/område i kunnskapsetaten vil det, som for modell 3a, bli en vesentlig økning i antall personer ansatt i sentralforvaltningen.

Å etablere en divisjon/område i kunnskapsetaten, fremfor som et eget institutt, vil vanskeliggjøre reell medinnflytelse og eierskap fra kommunene gjennom f.eks. roller i styrer e.l. Dette er avgjørende for å sikre legitimitet i kommunal sektor. Innlemmelse av kompetansesentrene i kunnskapsetaten vil også medføre at den vil øke vesentlig i størrelse.

Mulige utfordringer med å innlemme sentrene som en del av statsforvaltningen

Prosjektet viser til forsøket med å innlemme Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i FHI i 2017. Forsøket møtte stor motstand fra NKVTS, med påfølgende politisk press fra Stortinget, og forsøket ble derfor lagt til side.

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ble fra 2016 innlemmet i FHI. Tilsvarende ble Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) i 2018 en del av i FHI. Disse to sentrene eksisterer per i dag ikke som egne sentre, men som en del av den større organisasjonen.

Modell 4: Foretaksmodellen

Denne modellen skiller seg fra forvaltningsmodellene gjennom eierformen (foretaksmodell) og modellen gir også mulighet for kommuner og andre aktører å delta i styringen. I likhet med forvaltningsmodellen, vil foretaksmodellen ivareta helheten i sektoren.

Prosjektet vurderer at det med hensyn til behovet for å unngå vekst i antall ansatte i forvaltningsorganer i helseforvaltningen, vil være mer hensiktsmessig at et system av kompetansesentre organiseres med en selskapsform som gir staten anledning til å benytte unntaket for utvidet egenregi til å gi og finansiere oppdrag. Samtidig kan det sikres innflytelse fra kommunene og fylkeskommunene.

Prosjektet foreslår at foretakets primære mandat er eierskap og styring av kompetansesentrene. Dette vil kunne gjøres enten gjennom at alle sentrene legges direkte inn i selskapet (en 1-nivåmodell) eller ved at det etableres fire (ev. fem) regionale datterselskaper hvor kompetansesentrene innlemmes (en 2-nivåmodell). Alternativt kan datterselskapene eller divisjoner i selskapet være knyttet til helsefellesskapene. Prosjektet

vurderer at det vil sikre økt lokalt og regionalt eierskap gjennom en modell med fire (fem) regionale datterselskaper med egne styrer. Dette vil også kunne understøtte behovet for støtte til lokal implementering og strategisk styring. Regionale selskaper vil også være nærmere til å kunne styre personellressurser ved turnover og rekrutteringsbehov.

Kommunene må selv definere sine kunnskapsbehov og bidra inn i arbeidet med kunnskap om lokale behov og utfordringer. I motsetning til forvaltningsmodellen, vil 2-nivåmodellen med et nasjonalt styre og regionale underselskaper med egne styrer, sikre medinnflytelse og eierskap fra kommunene gjennom formaliserte roller i styrene og ev. andre organer.

Prosjektet vurderer at styret i det nasjonale foretaket bør ha representasjon fra kommunal sektor. I tillegg bør det være deltagere fra relevante etater og fra RHFene.

De regionale underselskapenes styrer bør ha medlemmer fra kommunal sektor i nedslagsområdet for det regionale underselskapet og staten, inkludert ev. statsforvalter.

En 2-nivåmodell vil kunne innføres trinnvis ved at det nasjonale eierselskapet etableres først, og at man så etablerer de fire (ev. fem) regionale selskapene og gjennomfører virksomhetsoverdragelser av kompetansesentrene til disse ett år senere.

Bestillingene til foretaket bør, etter prosjektets vurderinger, kunne komme fra kommunal sektor, RHF/HF, Direktoratet for medisinske produkter og Hdir/FHI. I tillegg bør det vurderes om direktorater og etater som sorterer under andre departement, bør kunne bestille og finansiere oppdrag (f.eks. Udir, NAV, Bufdir).

Prosjektet vurderer at det er et spenn mtp alternativer for hva som kan inngå i det nasjonale foretaket: fra kun en liten administrativ enhet som har som oppgave å koordinere de regionale underselskapene, via en modell der man innlemmer miljøet som arbeider med kunnskapsstøttesystemet for kommunal sektor ved FHI, til en modell der det etableres et kunnskapssenter/-institutt som utgjør et samlet nasjonalt miljø for kunnskapsstøtte, kunnskapsoppsummeringer, metodevurderinger og helseøkonomiske evalueringer for hele helse- og omsorgssektoren.

HRA har gjort en vurdering av aktuelle selskapsformer og konkluderer med at aktuelle modeller er: enten kommunalt medeierskap ved opprettelse av ansvarlig selskap (ANS) eller aksjeselskap (AS/ASA), eller et selskap hvor staten er eneste eier, inkludert statsforetak.

7.4 Konklusjon

Prosjektet anbefaler at kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten samles, med mål om å etablere et mer helhetlig system. Det bør vurderes om det kan være aktuelt å legge noen av sentrene til en kunnskapsetat. Dette må utredes nærmere. Relevante aktører, slik som KS og HelseOmsorg21-rådet, bør trekkes inn i arbeidet. Videre arbeid bør også se hen til en ev. videreutvikling av de regionale forskningsfondene (RFF).

Kommunene mangler i dag støttestrukturer som kan bidra til strategisk innføring av kunnskapsbaserte tiltak og som kan bidra med å sikre kvaliteten i kommunale helse- og omsorgstjenester. Det bør derfor være et mål at sentrene får en rolle som strategisk støttespiller inn mot kommunal sektor, ved bl.a. å bidra til implementering av kunnskap.

Egnet selskapsmodell og tidslinje for iverksetting av en samling av sentrene bør utredes nærmere som del av et gjennomføringsprosjekt. Kunnskapsfunksjoner og grenseflater til kunnskapsetaten, herunder kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger, må inngå

som problemstillinger for videre utredning. Det bør også utredes om det er aktuelt å samle kompetansesentrene utenfor RHF og kunnskapsetaten i én organisasjon.

8 Overføre oppgaver fra helseforvaltningen til de regionale helseforetakene

8.1 Dagens ansvars- og oppgavefordeling

RHFene ble etablert i 2002 for å sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen i helseregioner. Sykehusene har fire oppgaver: i) pasientbehandling, ii) utdanning av helsepersonell, iii) forskning og iv) opplæring av pasienter og pårørende.

8.2 Bakgrunn for å vurdere organisasjonsendringer

Gjennom helseforetaksreformen fikk staten vesentlig større muligheter til å styre spesialisthelsetjenesten enn tidligere, selv om sykehusene ble organisert som foretak og dermed ble mer fristilt enn om de hadde vært forvaltningsorganer. Likevel er det mange likhetstrekk mellom departementets eierstyring av RHFene og myndighetsstyringen av de underliggende etatene, eksempelvis gjennom oppdragsdokument og tildelingsbrev. RHFene er i dag store og robuste organisasjoner med godt samarbeid seg imellom (bl.a. gjennom interregionale fagdirektørmøter, AD-møter og system for nye metoder/beslutningsforum/bestillerforum). Samlet sett mener prosjektet at dette er et godt utgangspunkt for å vurdere om det er oppgaver som kan overføres fra den sentrale helseforvaltningen til RHFene.

Allerede i dag har RHFene noen forvaltningsoppgaver. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) jobber med å kartlegge og synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenesten. SKDE produserer helseatlas, drifter nasjonale medisinske kvalitetsregistre og driver med helsetjenesteforskning. Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) driver med forskning og kunnskapsformidling (se kapittel 11.2). RHFene har store IKT-miljøer som jobber med regionale infrastrukturtjenester. Videre har RHFene også etablert nasjonale tjenester, som er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale medisinske kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

I prosjektarbeidet har det kommet frem behov for bedre koordinering og gjensidig orientering mellom Hdir og RHFene iom. at det ikke foreligger direkte styringslinjer mellom etaten og helseregionene. Den eventuelle formelle styringslinjen må gå via departementet, men det er forbedringsmuligheter når det gjelder koordinering og bedre samarbeid. Overføring av oppgaver kan i seg selv føre til mer og bedre dialog og samarbeid.

8.3 Forslag til ny organisering

Prosjektet legger frem forslag om at ansvar for utvikling og oppdatering av enkelte nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og faglige råd kan overføres fra sentralforvaltningen til RHFene. Dette begrunnes med at:

- Øvrig forvaltning kan i større grad innrette sin virksomhet mot den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
- Fageksperter fra RHFene/HFene brukes allerede ofte til utvikling av disse produktene da Hdir ikke har denne ekspertkompetansen internt.
- RHFene har over tid utviklet diverse lokale, regionale og interregionale prosedyrer, retningslinjer og metodebøker, og det er viktig at disse fagressursene kommer til bruk. RHFene har etablert metodebok.no for samling og deling av fagressurser.

- RHFene har gjennom skriftlige innspill og møter stilt seg positive til et slik grep.
- Prosjektet viser til økt politisk oppmerksomhet knyttet til tillit og delegering av ansvar til tjenestene, og mener at en slik overføring kan bidra til effektivitet da mye av fagkompetansen allerede er i spesialisthelsetjenesten og man unngår dermed transaksjons- og koordineringskostnader.
- Tiltaket har lave omkostninger.

Samtidig er det flere viktige forutsetninger:

- Ansvaret bør avgrenses til produkter som er av begrenset omfang og relevante kun for spesialisthelsetjenesten (for eksempel nasjonale faglige retningslinjer innen kreftområdet, antibiotika i sykehus, mm.). Omfanget bør også begrenses til områder der RHFene besitter relevant fagkompetanse, og der gjennomførings- og budsjettansvar ligger i spesialisthelsetjenesten (for eksempel bruk av nye legemidler).
- Normerende produkter som dekker begge tjenestenivåene, eller normerende produkter hvor eventuelle endringer kan føre til oppgaveflytting eller andre konsekvenser for kommunene, bør helt og fullt eies av direktoratet.
- Forvaltningens fagkompetanse innen spesialisthelsetjenesteområdet må ivaretas ved forflytning av ansvar og oppgaver.
- Interregionalt samarbeid og felles enighet.

En stor andel av de normerende produktene omhandler spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesteloven § 7-3 og helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 sier at Hdir «skal utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere som understøtter de mål som er satt for helse- og omsorgstjenesten. Retningslinjer og veiledere skal baseres på kunnskap om god praksis og skal bidra til kontinuerlig forbedring av virksomhet og tjenester». Eventuelle endringer hvor RHFene utvikler og/eller vedlikeholder nasjonale faglige retningslinjer og veiledere kan dermed kreve endringer i lovverk. Dette må vurderes nærmere.

Alternativt kan det vurderes om RHFene kan utvikle interregionale faglige produkter som ikke er å anse som formelle normerende produkter, men beste anbefalte praksis («best practice»). Selv om faglige produkter ikke er å anse som normerende produkter tolkes de som beste anbefalte praksis og brukes av bl.a. tilsynsmyndighetene og NPE i deres vurderinger. Hdir har utarbeidet en veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer[8] som kan brukes i utarbeidelsen av faglige produkter, og RHFene kan innrette sitt arbeid i tråd med denne. Alternativt kan Hdir ha et redaktøransvar og «godkjenne» produktene som normerende produkter.

Samlet sett vil en overføring til RHFene bidra til at Hdir kan dreie noe av sin ressursbruk på normerende produkter mot den kommunale helse- og omsorgssektoren og mot områder som omhandler begge eller samhandling mellom tjenestenivåene.

8.4 Konklusjon

Etter en samlet vurdering anbefaler prosjektet at det utredes om, og ev. hvordan, ansvar for utvalgte nasjonale faglige retningslinjer og veiledere kan overføres fra den sentrale

[8] Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer, Helsedirektoratet, IS1870

helseforvaltningen til RHFene. Det vil dreie seg om produkter av faglig art som kun berører spesialisthelsetjenesten. Prosjektet viser til tillitsreformen, og mener at en slik overføring kan bidra til effektiviseringsgevinster da mye av fagkompetansen allerede er i spesialisthelsetjenesten. Forslag til tiltak må utredes videre i et eventuelt gjennomføringsprosjekt. Forslaget bør også vurderes i sammenheng med *Seksjon 11.9. Etablering av et forum for faglig normering.*

9 Samordning av beredskapsansvar

9.1 Dagens ansvars- og oppgavefordeling

Helseberedskapen i Norge bygger på det daglige folkehelsearbeidet og den daglige helse- og omsorgstjenesten, i tråd med prinsippene om ansvar, nærhet, likhet og samvirke. Hdir har i dag et helhetlig koordineringsansvar for den nasjonale helseberedskapen. Utover dette har alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren beredskapsrelaterte oppgaver og ansvar. Overordnet kan man vise til følgende ansvarsfordeling (Nasjonal helseberedskapsplan, 2018):

- Den sentrale helseforvaltningen, men myndighets-, fag-, og tilsynsorganer, har ansvar for forvaltningen av helse- og omsorgstjenesteområdet og folkehelseområdet. De mest sentrale aktørene er Hdir, FHI, DSA, E-helse, Htil, SLV og Mattilsynet.
- Statsforvalter står for regional helseforvaltning og er bindeledd mellom nasjonalt og lokalt nivå. Sysselmesteren på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen og har rolle som både politimester og statsforvalter.
- Kommunal sektor har ansvar for helse- og omsorgstjener og folkehelsearbeid.
- RHFene sørger for spesialisthelsetjenester gjennom HFene.
- NHN driver helsenett, HelseCERT, Kjernejournal, e-resept, Helsenorge.no og er felles tjenestesenter for den sentrale helseforvaltningen.

- En legemiddelforsyningskjede er organisert gjennom apotek og grossister.

Fagansvaret innen CBRNE-feltet er i dag fordelt mellom flere etater og virksomheter. Det samme gjelder sikker vannforsyning og IKT-sikkerhet.

9.2 Bakgrunn for å vurdere organisasjonsendringer

Helseberedskapen står overfor et uforutsigbart og mer sammensatt trusselbilde. Helse- og omsorgssektoren må dermed være forberedt på å håndtere flere og mer komplekse kriser i tiden fremover. Samtidig er det viktig å vurdere organiseringen av forvaltningen i lys av erfaringer fra COVID-19 pandemien. Prosjektet er derfor bedt om å særlig vurdere beredskapsrelaterte oppgaver, inkludert smittevern og atomberedskap.

Funn i Koronakommisjonens rapporter, egne evalueringer i departementet og skriftlige innspill har tydeliggjort en rekke områder med behov for klargjøring av roller og ansvar innen helseberedskap og krisehåndtering. Prosjektet har lagt følgende til grunn for anbefalinger:

1) Behov for overordnet koordinering og strategisk ledelse av helseberedskapen:

- Det er uklarheter i ansvarsforholdet mellom departementet og Hdir når det gjelder koordinering og strategisk ledelse av helseberedskapen. Departementet bør ha en overordnet og strategisk rolle og myndighetsetaten/Hdir en koordinerende rolle.
- Det er uklarheter om den koordinerende rollen til Hdir. Gjennom delegasjon og myndighet han Hdir gis en rolle i krisehåndtering som de ikke har til daglig. Både RHFene og FHI peker på at det er uklart hva som reelt ligger i den delegerte myndigheten. Som angitt i forrige punkt bør departementet ha den overordnede og strategiske rollen, Hdir en

koordinerende og samvirkende rolle og for øvrig bør ansvars-, likhets- og nærhetsprinsipp følges.

2) Behov for tverrsektorielt og tverretatlig samarbeid og samordning innen helseberedskap generelt og CBRNE-feltet spesielt:

- Det er behov for mer og bedre samvirke mellom etatene tverrsektorielt. Kriseutvalget for atomberedskap (KUA) bør vurderes som modell for annet tverrsektorielt samarbeid.
- Det mangler generiske organisasjonsmodeller som kan understøtte ledelse og koordinering av større helsekriser. Det er således behov for felles utvalg, planverk og avtalevirkemidler for håndtering av større helsekriser.
- Mulighet for samling og samarbeid mellom strålevern og andre helsevernområder i den ordinære virksomheten (utenom beredskap) må vurderes. Det kan være fordeler ved et tettere og formalisert faglig samarbeid på tvers av CBRNE-feltet (gjelder primært dagens FHI, DSA og Hdir, og vil i anbefalt modell primært gjelde myndighetsetaten/Hdir og DSA, jf. kapittel 3. Samtidig vil det også være behov for koordinering med RHFene og statsforvalter).
- Videre er det behov for samordning av informasjonskanaler til befolkningen og helsetjenester, med mekanismer som sikrer enhetlig informasjon. Helsenorge.no bør være eneste skriftlige informasjonskanal til befolkningen.

3) Kapasitetsutfordringer (strålevern og atomsikkerhet):

- Fagmiljøet innen strålevern og atomsikkerhet er lite og DSA har en tverrsektoriell rolle hvor flere departementer ønsker DSA som en selvstendig institusjon. Det anbefales derfor et fortsatt samlet fagmiljø. Modeller for å styrke mer bredde i fagkompetansen knyttet til strålevern og atomsikkerhet bør vurderes.
- Kapasiteten i DSA er liten mtp. en håndtering av en større atomhendelse med stråling på norsk jord. Det må vurderes om mer systematisk samarbeid mellom etater kan sikre tilstrekkelig kapasitet, spesielt med den helhetlige myndighetsetaten/Hdir. DSA har mye erfaring med øvelser, men lite erfaring med reell krisehåndtering. Grep som kan styrke mer bredde i den helsefaglige fagkompetanse bør prioriteres. Samtidig er det behov for å sikre tilstrekkelig kapasitet til å håndtere myndighetsoppgaver (særlig kommunikasjon og informasjonsbehov) ved en større hendelse.
- Eventuelle organisasjonsendringer må sikre tilstrekkelig uavhengighet innen atomsikkerhetsområdet, i henhold til internasjonale forpliktelser.
- Eventuelle organisasjonsendringer må også sikre Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet sin faglige oppdragsstyring av DSA.

4) Forholdet mellom faglige råd og normerende føringer (særlig innen smittevern):

- Det bør utarbeides klare retningslinjer for rollene og rådgivningsansvaret Hdir og FHI har i forbindelse med beslutninger om smitteverntiltak etter smittevernloven. Det vises til kapittel 3 for videre drøfting.
- Det bør gå fram av retningslinjene i hvilken grad fagetatene skal gjøre vurderinger som går utover de rent smittevernfaglige, og hvilke forhold de eventuelt skal ta hensyn til. Koronakommisjonen anbefaler at myndighetene så langt det er mulig, synliggjør ulike hensyn som inngår i helhets- og forholdsmessighetsvurderingene i beslutningsgrunnlagene.

- I dag er det reelt to linjer mot kommunene. En faglinje (til kommunelege) om faglige råd og veiledning, og en formell myndighetslinje (via statsforvalter). Uklarheter om roller og ansvar innen smittevernområdet kan føre til at det er vanskelig for mottakere å skille mellom faglige råd på den ene siden og krav og føringer på den andre. Det vises igjen til kapittel 3 for videre drøfting.

9.3 Bedre samordning av helseberedskapen

En styrket helseberedskap[9] inngår som et vurderingskriterium i alle modeller som har blitt vurdert av prosjektet. I dette kapittelet drøftes to alternativer for bedre samordning av CBRNE-feltet:

1. Organisatorisk samle fagmiljøene innen CBRNE helt (smittevern, miljømedisin og strålevern/atomsikkerhet) eller delvis (smittevern og miljømedisin), enten i et eget direktorat eller som del av øvrig forvaltning.
2. Etablere formelle samarbeidslinjer mellom fagmiljøene.

Fordeler ved en organisatorisk samling av fagmiljøene inkluderer mulige stordriftsfordeler, styrket kapasitet ved en atomhendelse, avklarte ansvarslinjer og et mer samordnet og helhetlig beredskapsarbeid og krisehåndtering. Prosjektet viser til Storbritannias UK Health Security Agency (UKHSA) som et internasjonalt eksempel på samling av slike funksjoner i et eget direktorat.

Alternativene legger til grunn at formelle myndighetsfunksjoner vil forbli samlet i myndighetsetaten (Hdir i dagens organisering). En samling av CBRNE-feltet vil derfor ikke svare ut utfordringer knyttet til synergier og samling mellom kunnskap- og myndighetsfunksjoner i en krise. En slik organisatorisk løsning vil også skape større avstand til øvrig folkehelsearbeid og helsetjenestene, samt at det blir flere etater å forholde seg til for f.eks. kommunene.

Prosjektet viser til tidligere forsøk på å innlemme DSA i Hdir i 2016. Endringen ble raskt reversert etter større koordinert motstand i fagmiljøet, DSA, departementer (særlig KLD, UD og NFD) og internasjonalt. Motstand, både da og i dag, begrunnes med internasjonale krav om uavhengighet. DSA utfører arbeid for både KLD, UD og NFD og det er derfor også en uro for at veien fra disse departementene til enheten som forvalter myndighet og tilskudd blir lang. Etter utredning vurderer prosjektet likevel at en innlemming av DSA i øvrig helseforvaltning er gjennomførbart og mulig å utføre uten å bryte med internasjonale forpliktelser. Samtidig mener prosjektet at et slik grep i dagens kontekst ikke nødvendigvis vil gi tilstrekkelig nytteverdi om man tar risiko og omstillingskostnader i betraktning. En delvis organisatorisk samling av smittevern og miljømedisin i egen etat vurderes ikke som formålseffektivt.

Imidlertid bør det etableres forpliktende samarbeidslinjer mellom fagmiljøene og etatene med ansvar innen CBRNE-feltet. En slik løsning kan sikre bedre bruk av det større fagmiljøet knyttet til strålevern og atomsikkerhet (bl.a. toksikologisk, epidemiologisk, annen helsefaglig kompetanse, analysekompetanse/register, osv.). Forpliktende samarbeid kan også resultere i en mer hensiktsmessig oppgavefordeling mellom etatene ved en større hendelse (analyser,

[9] Forsyningssikkerhet og beredskap drøftes i *kapittel 4. Statens legemiddelverk som utgangspunkt for et direktorat for medisinske produkter*. Organisering av smittevern drøftes i *kapittel 3. Endret organisering av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet*.

sammenstillinger, kommunikasjon, osv.). Prosjektet forutser ikke betydelig kostnader ved etablering av slike avtalevirkemidler, verken på kort eller lang sikt. Kostnad og risiko ved å ikke gjøre endringer vil være store ved en større hendelse på norsk jord. Helseberedskapsprosjektet vil vurdere disse problemstillingene nærmere.

9.4 Konklusjon

Etter en samlet vurdering anbefaler prosjektet ikke en organisatorisk samling av fagmiljøene innen CBRNE-feltet og dermed at DSA består som en egen etat.

Samtidig finner prosjektet at det er behov for å styrke DSAs kapasitet på andre måter. Det anbefales at det etableres formelle samarbeidslinjer mellom DSA og hhv. kunnskapsetaten og myndighetsetaten for å styrke helseaspekter ved atomhendelser. Dette bør utredes videre som del av et gjennomføringsprosjekt.

Beredskapsarbeidet knyttet til atomområdet bør i større grad sees i sammenheng med annet beredskapsarbeid innen departementets ansvarsområder. Dette skal inkludere beskrivelse av DSAs sårbarhet knyttet til kommunikasjon og informasjon, samt behov for sterkere samarbeidsavtaler om dette.

Prosjektet anbefaler at det etableres samarbeidsflater for helseberedskap og krisehåndtering på departementsnivå (Helsekriseråd) og etatsnivå (generisk tverrsektorielt kriseutvalg). KUA bør inngå i disse løsningene. Prosjektet viser til pågående arbeid med Helseberedskapsmeldingen for videre utredning av disse tiltakene.

10 Videreutvikle departementets styring

Prosjektet viser til at det uavhengig av hvilke organisatoriske endringer som gjennomføres er behov for å vurdere endringer i departementets styring av etater og foretak. Aktuelle problemstillinger kan være å:

- bedre og samordne departementets etatsstyring på tvers av virksomhetene, herunder harmonisering av tildelingsbrev, instrukser og øvrig etatsstyring
- tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom etatene
- mer effektiv utnyttelse av ressursene
- bedre samordning mellom eierstyring og innholdsstyring, se bl.a. kapittel 5.2
- bedre styring av digitaliseringsområdet, gjelder samordning av styring på tvers av virksomheter, etatsstyring av E-helse og forholdet mellom eierstyring og innholdsstyring av NHN.
- bedre styring av forskning og kunnskapsproduksjon slik at den er mer relevant
- vurdere hvordan beredskapsperspektivet skal ivaretas i styringen
- gå opp samarbeidsrelasjonen mellom RHF og myndighetsetat/Hdir, jf. at Hdir mener muligheten for å etterspørre informasjon fra spesialisthelsetjenesten er for begrenset. I henhold til helseforetaksloven er det kun foretaksmøtet (dvs. departementet) som kan gi oppdrag direkte til RHFene.

Endringer i organisering av og oppgavefordeling mellom etatene vil også kunne påvirke hvordan etatsstyringen og eierstyringen organiseres og gjennomføres i departementet. Det gjelder for eksempel endringer i organisering som har implikasjoner for styringen i et beredskapsperspektiv og nye gråsoner som krever særlig oppmerksomhet.

Prosjektet har i arbeidet vurdert ansvars- og rollefordeling mellom underliggende etater og departementet. Det er ikke gjort funn i prosjektet som tilsier at det hadde vært hensiktsmessig for departementet å overta ansvar og oppgaver fra underliggende etater. Imidlertid beskrives det områder der det er uklare ansvarsforhold, bl.a. mellom HOD og Hdir når det gjelder koordinering og strategisk ledelse av helseberedskapen (se kapittel 9). På generelt grunnlag vurderer prosjektet at dagens organisering med en stor grad av delegering til underliggende etater bør videreføres. Departementet bør ha en overordnet og strategisk rolle, og mindre operativt styre i smått (jf. Koronakommisjonens funn).

Konklusjon: Prosjektet anbefaler at det i sammenheng med gjennomføringen av endringer i organisering av helseforvaltningen også vurderes behov for endringer i organisering og gjennomføring av departementets etats- og eierstyring.

11 Andre problemstillinger som anbefales fulgt opp

I dette kapitlet omtales problemstillinger som er relevante for forvaltningsgjennomgangen, men som foreslås håndtert utenfor prosjektet, enten fordi de avhenger av andre prosesser eller fordi det kan håndteres uavhengig av øvrige organisasjonsendringer.

11.1 Forskning i forvaltningen

Forskning er et viktig verktøy og en ressurs i forvaltningssammenheng. Tradisjonelt har kunnskap om helsestatus og årsaksforhold og om omfang av tjenestebruk osv. vært viktig for å gi departementet og andre sentrale aktører oversikt over hvilke utfordringer helsesektoren står overfor. I senere år har man i større grad enn tidligere benyttet effektstudier o.l., slik det er innen det kliniske området, for å gi grunnlag for å prioritere tiltak som både er effektive og kostnadsbesparende, samt for å avdekke bredere samfunnsmessige implikasjoner av tiltak. Både forvaltningen, ved FHI, og universitetsmiljøene gjennomfører i dag befolkningsbaserte undersøkelser i form av nasjonale og regionale kohorter. Det er behov for å vurdere behov, organisering og finansiering av disse framover.

Prosjektet vurderer at det er potensiale for å utnytte forskningskompetansen og kunnskapsgrunnlaget som produseres i forvaltningen og i nettverket av kompetanse-, kunnskaps- og forskningssentre bedre enn i dag. Dette krever bl.a., tydeligere styring av rammene for forskningen.

Konklusjon: Prosjektet anbefaler at forvaltningens bruk av forskning utredes videre og tydeliggjøres som del av gjennomføringsprosjektet. Dette bør inkludere drøfting av kunnskapsbehov i departement og etater, samt mekanismer for å sikre at kunnskapen brukes og omsettes til beslutninger og handling. Som en del av utredningen bør det utvikles en helhetlig strategi og planer for regelmessige befolkningsbaserte helseundersøkelser. Det kan være aktuelt å justere innretningen til kunnskapsetaten og kompetansesentrene i lys av konklusjoner. Utredningen bør også drøfte behov for økt bruk av flerfaglige tilnærminger og bredere samfunnsmessige og økonomiske vurderinger og analyser.

11.2 Laboratorievirksomhet

De nasjonale referansefunksjoner innen mikrobiologi er i dag delt mellom FHI og RHFene. I tillegg finnes det referansefunksjoner innen mikrobiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Veterinærinstituttet. Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi er tillagt følgende oppgaver i henhold til MSIS-forskriften: referansediagnostikk; opprettholde en samling av stammer og annet referansemateriale; vitenskapelig råd og støtte; samarbeid og forskning; og bistå i overvåkning, beredskap og respons ved utbrudd av smittsomme sykdommer.

Som nasjonalt smitteverninstitutt skal FHI sørge for at det finnes systemer for påvisning av biologiske smittestoff som har særlig betydning for nasjonal sikkerhet og beredskap (både i fredstid, krise og krig). I henhold til MSIS-forskriften og HODs tolkning av den, skal referanse-laboratoriesystemet være fleksibelt, men med nasjonal styring. HOD skal, etter faglige råd fra underliggende etat, skalere referansefunksjonene opp eller ned, basert på nasjonale behov. FHI skal i dag ha nasjonal oversikt over de viktigste data fra alle referansefunksjoner, også de som ikke er tillagt FHI.

Delt sektoransvar for smitteverndiagnostikk (helsesektor, landbrukssektor og miljøsektor) har resultert i at de tre sektorene planlegger sin virksomhet etter enkelt-sektor-behov. Det er heller ikke noen felles kunnskapsplattform for å sikre et helhetlig bilde, f.eks. ikke en felles laboratoriedatabase som kan gi varsel om samtidige epidemiologiske endringer i flere sektorer. Det er imidlertid etablert gode samarbeidsavtaler og gode relasjoner mellom sektorene, slik at man for eksempel ved de enkelte utbrudd etablerer raske samarbeidsprosjekter for å løse aktuelle problemer.

Konklusjon: Prosjektet anbefaler at plassering av laboratoriedrift og laboratoriefunksjoner innen mikrobiologi/smittevern utredes videre. I tillegg til evt. plassering i myndighetsetaten eller kunnskapsetaten, bør andre virksomheter vurderes (RHF/HFene, NMBU og Veterinærinstituttet). Den overordnede forvaltningsoppgaven som nasjonal koordinator, samordner og rådgiver innen det infeksjonsepidemiologiske feltet er et ansvarsområde som bør forbli i en av HOD sine underliggende etater. Laboratorievirksomheten bør holdes samlet i en kunnskapsetat/FHI til eventuell utredning er gjennomført. Utredningen bør være en egen prosess og ikke del av et eventuelt gjennomføringsprosjekt da det er behov for tid til å vurdere ulike løsninger med tilhørende avtaleverk, samarbeidsrelasjoner, investeringsbehov etc.

11.3 Statsforvalters rolle

En utvidet rolle for statsforvalteren som strategisk støttespiller når kommunal sektor skal planlegge og dimensjonere sine tjenester har blitt tatt opp og drøftet i prosjektet. Hdir skriver i sitt innspill til prosjektet: «Vi anser det for å være et enda større potensial i statsforvalterens arbeid inn mot kommunene for å bidra med implementering av den politikken som er vedtatt, samt veiledning og oppfølging av kommunene på helse- og omsorgsfeltet».

Imidlertid har flere andre innspill vist til at det vil være krevende å på den ene siden ivareta rollen som strategisk organ for utvikling av kommunale tjenester, og på den andre siden tilsynsmyndighet og klageinstans for kommunale vedtak. Blant annet skriver Htil i et innspill til prosjektet at det er behov for et tydeligere skille mellom tilsynsfunksjon og iverksetterfunksjonen hos statsforvalterne, både i krise og i normaltid.

Innen helsikkerhetsområdet (smittevern, strålevern og miljørettet helsevern) er statsforvalterens rolle omtalt i utkast til folkehelsemelding: *Statsforvalter skal være bindeledd mellom lokalt og nasjonalt nivå, og har ansvar for samordning av samfunnssikkerhet og beredskap i fylket. Statsforvalteren skal ha tilstrekkelig samfunnsmedisinsk kompetanse og kapasitet til å ivareta myndighetsoppgaver, og for råd veiledning og støtte til kommunene. Regjeringen vil komme tilbake til dette i forbindelse med helseberedskapsmeldingen og revisjon av regelverk knyttet til helseberedskap og smittevern.*

Konklusjon: Prosjektet mener det bør utredes videre om statsforvalter bør få en forsterket rolle mtp å understøtte kommunal sektor i kvalitetsutvikling og strategisk innføring av nye tiltak, herunder vurdere statsforvalters rolle i en evt. endret organisering av kompetansesentrene (jf. kapittel 7). Statsforvalters rolle bør også vurderes med hensyn til oppgavene innen tilsynsområdet.

11.4 Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)

Prosjektet viser til at Menon Economics på oppdrag fra departementet i 2021 gjennomførte en evaluering av NSE sammen med en kartlegging og vurdering av dagens virkemidler og aktivitet innenfor norsk e-helseforskning.

Rapporten viser at e-helseforskningen er i vekst og at flere forskningssentre er etablert med stor geografisk spredning. Likevel beskrives forskningsfeltet fremdeles som fragmentert og umodent, og kunnskapsbehovet som stort. Samlet sett vurderes e-helseforskningen som underfinansiert og i liten grad prioritert både av RHFene, kommunene og den sentrale helseforvaltningen. Forskningen preges av mindre kvalitative studier og tilfredsstiller ikke etterspørselen etter kunnskap som kan gi en samlet vurdering av implementering og effekt av nasjonale e-helseløsninger.

NSE blir vurdert til å ha en sentral rolle som forskningsformidler og som et sentralt ledd i kunnskaps- og forskningsproduksjonen innen e-helsefeltet. Vurderingen er at senteret leverer forskning på sammenlignbart nivå og tematikk som resten av e-helseforskningen i Norge, og skiller seg positivt ut når det gjelder omfanget av samarbeid med andre miljøer både nasjonalt og internasjonalt. Forskningen i regi av senteret sammenfaller med nasjonale behov, men vurderes å ha store kunnskapshull med hensyn til metodikken for kontrollerte studier som kan utfordre senterets evne til å dekke kunnskapsbehovene. Senteret har en stor andel finansiering som ikke er konkurranseutsatt sammenlignet med andre sentre i instituttsektoren.

Samlet sett er vurderingen at dagens virkemidler innen dette området, inkludert NSE, fungerer etter formålet og har en akseptabel effekt og effektivitet. I rapporten konkluderes det likevel med at det er behov for et retningsvalg når det gjelder videre utvikling av NSE, enten ved å

1) Rendyrke NSEs rolle som forskningssenter og heve ambisjonene for forskningen. En slik utvikling forutsetter større grad av finansiering gjennom konkurranseutsatte forskningsmidler

   eller

2) Legge større vekt på NSE som kompetansesenter for å dekke forvaltningens og tjenestens behov, inkludert videreutvikling av kompetansen på kunnskapsoppsummeringer og en mulig satsing på metodevurdering. Alternativet krever avklaringer knyttet til arbeidsdeling mot E-helse, FHI og andre aktører

I dag er NSE organisert som en avdeling i Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Senteret finansieres med en øremerket bevilgning på i overkant av 40 mill. kroner over kap. 745 post 70 i statsbudsjettet. Midlene overføres fra Helse Nord RHF til universitetssykehuset. Senteret ble etablert med utgangspunkt i Telemedisinsk senter og ble omgjort fra et nasjonalt senter til enhet forankret i UNN i 2016. Rammene ble gitt i et forventningsbrev fra departementet. Departementet bestemte at det skulle etableres en styringsgruppe for senteret med representanter fra helse- og omsorgssektoren. I dag ledes styringsgruppen av Erik M. Hansen fra Helse Vest RHF. HOD er observatør i styringsgruppen. HOD driver ikke aktiv styring av senteret.

Anbefalingene i evalueringen er så langt ikke fulgt opp, men E-helseavdelingen i HOD har gjort en foreløpig vurdering av mulige endringer i organiseringen av NSE. Avdelingens har

vurdert 4 alternative modeller: 1) videreføre som i dag med forankring i UNN og øremerket bevilgning; 2) overføring av midler og ansvar til Helse Nord RHF; 3) flytte midler og ansvar til FHI; og 4) flytte senteret til UH-sektoren (UiT). Avdelingen legger vekt på at NSE har sin styrke og kompetanse på forskning innen e-helseområdet, det er et godt fungerende miljø som bør bevares, og den nære tilknytning til tjenesten bør videreføres. Avdelingen mener samtidig at senteret vil være tjent med en klarere styringslinje.

Konklusjon: Prosjektet anbefaler at spørsmålet om organisatorisk forankring av NSE avklares uavhengig av forvaltningsgjennomgangen. Det kan imidlertid være aktuelt å se behovet for kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger innen e-helseområdet i sammenheng med organisatorisk forankring av disse miljøene i forvaltningen. Det er en oppgave som ikke ivaretas av NSE i dag.

11.5 Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO)

Prosjektet har vurdert om det bør gjøres endringer i organisering og eierskap til HDO i sammenheng med forvaltningsgjennomgangen. Et argument for å endre organiseringen av HDO er at virksomheten i dag eies av RHFene, men leverer tjenester til både sykehus og kommuner. Et annet argument kan være at det er DSB som har ansvar for nødkommunikasjon generelt, og dermed også bør ha ansvar for brukerrelatert utstyr.

I 2017 ble det vurdert 4 alternative eierskapsmodeller til HDO innenfor helsesektoren: 1) NHN eier hele helsetjenestens brukerutstyr i nødnettet; 2) NHN eier kommunenes brukerutstyr og foretakene spesialisthelsetjenestens; 3) RHFene eier hele tjenestens brukerutstyr; og 4) kommunene tar ansvar for brukerutstyr i kommunehelsetjenesten og RHFene for brukerutstyr i spesialisthelsetjenesten. Det ble ikke vurdert alternativer utenfor helsesektoren, men det er relevant fordi selve nødnettet forvaltes av DSB. HDO forvalter brukerutstyret og er en av tre driftsorganisasjoner i tilknytning til nødnettet. De to andre er Politiets IKT-tjenester (PIT) og Branns driftsorganisasjon (BDO) som leverer brukerutstyr til hhv. politi og brann.

Det viktigste argumentet for å ikke endre eierskapsmodellen i 2017 var behovet for en nær knytning til den medisinske nødmeldetjenesten for HFene og kommunene både når det gjelder drift og utvikling av nødnett. Det ble også vist til at HDO hadde bygget opp kompetanse og samarbeidsrelasjoner som er avgjørende for å nå målene ved innføring av nødnettet, samt at det var etablert en modell for finansiering og drift i samarbeid med kommunene. I tillegg er det noen anskaffelsesrettslige utfordringer med å flytte eierskapet til NHN. I dag er det arbeidet med framtidens nød- og beredskapskommunikasjon som skal erstatte nødnettet som gjør at det er lite hensiktsmessig å vurdere endringer i organisering og eierskap nå. Løsningen vil mest sannsynlig innebære at et nødnett med statlig eid og drevet tetra-teknologi vil bli erstattet av løsninger innenfor kommersiell GSM-teknologi (G5). I denne sammenheng vil det være nødvendig å etablere en ny organisasjon som skal drifte og utvikle løsningen. Det er per i dag uklart hvilken rolle staten vil ha i løsningen og det er for tidlig å si hva dette vil bety for HDOs virksomhet og organisering.

Konklusjon: Prosjektet mener at det er relevant å gjøre en ny vurdering av endringer i organisering og eierskap til HDO, men anbefaler at departementet avventer det pågående arbeidet med en framtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon som gjennomføres av Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med berørte departementer og etater.

11.6 Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Prosjektet viser til at en vurdering av de organisatoriske rammebetingelsene for sekretariatet for VKM har vært reist som en problemstilling i denne forvaltningsgjennomgangen. Sekretariatet for VKM ble innlemmet som en egen enhet i FHI fra 1. januar 2016. Begrunnelsen var at VKM allerede var geografisk, faglig og administrativt nært knyttet opp til instituttet, og at dette ville gi en enda sterkere tilknytning til helseforvaltningens største kunnskaps- og forskningsmiljø. Sekretariatets uavhengighet var et sentralt spørsmål i sammenheng med organisasjonsendringen. Det ble besluttet at sekretariatet skulle være underlagt vitenskapskomitéen og at ledelsen i FHI bare kunne instruere sekretariatet i administrative og økonomiske spørsmål. Det har ikke vært gjort endringer i sekretariatsfunksjonen etter organisasjonsendringen i 2016.

Sekretariatet for VKM er delvis finansiert av Miljødirektoratet. I tillegg får FHI tilskudd fra Hdir og SLV til noen mindre oppdrag. Det pågår diskusjoner om uavhengigheten til sekretariatet når det gjelder finansiering, det vil si om kutt i bevilgningen til FHI også skal treffe sekretariatet. Det har også vært diskusjoner om VKMs rolle i beredskap som er landet slik at i beredskapssituasjoner går bestillingene direkte til relevante etater og ikke til komitéen. Det har også vært noen diskusjoner om hvilke type oppdrag som skal gå til VKM og hvilke oppdrag som skal gå direkte til instituttene. Dette henger sammen med hvem som får betalingen, det vil si når VKM får oppdrag går betalingen direkte til personene som bidrar og ikke til instituttene. Det er totalt sett ikke snakk om store beløp, men dette er noe av bakgrunnen for beslutningen om at VKM skal evalueres i 2023, jf. omtale i Prop. 1 S (2022-2023) Helse- og omsorgsdepartementet. Folkehelseavdelingen i HOD og VKMs sekretariat har også helt løselig diskutert om en bør se på hele organiseringen av komitéen som i dag har 130 faste medlemmer, for eksempel om det er aktuelt å redusere antall faste medlemmer og ha flere adhoc-grupper knyttet til aktuelle saker. Det vil også være viktig å vurdere om man kan få mer ut av samarbeidet med og utredningene i EFSA.

Konklusjon: På bakgrunn av beslutningen om at VKM skal evalueres i 2023, anbefaler prosjektet at en vurdering av de organisatoriske rammebetingelsene for sekretariatet blir en del av evalueringen.

11.7 Felles tjenestesenter for helseforvaltningen (konsernmodellen)

Prosjektet viser til at det i sammenheng med organisasjonsendringsprosessen i 2015 ble besluttet å innføre en konsernmodell for administrative tjenester i den sentrale helseforvaltningen. I prosjektfasen i 2015 ble det i en konsulentrapport fra PWC estimert mulige gevinster for IKT-tjenester og anskaffelser tilsvarende 700-1200 mill. kroner over 10 år. NHN fikk i oppdrag å etablere tjenestesenteret i juni 2016, og å være tjenesteleverandør for IKT-tjenester, anskaffelser og dokumentforvaltning (arkiv) for den sentrale helseforvaltningen. Konsernmodellen har vært operativ siden 1. januar 2017. IKT- tjenester, anskaffelser og arkivtjenester (dokumentasjonsforvaltning) skulle i utgangspunktet bli overført til NHN i løpet av første halvår 2017, men det viste seg å være mer komplekst enn forutsatt. Det meste var gjennomført i løpet av 2018, men arkivforvaltningen tok lengre tid og ble for Helseklage, som siste virksomhet, først overført til NHN i 2022.

Modellen har vært evaluert internt i departementet i 2018 og av Riksrevisjonen (anskaffelsesområdet) i 2019. I departementets interne evaluering er det konkludert med at etatene har vært lojale til beslutningen og at etableringsarbeidet nærmest var fullført i

oktober 2018. Vurderingen er at gevinstpotensialet er lavere enn forutsetningene, men at det fortsatt forsvarer merkostnadene ved omleggingen. Videre er vurderingen at forståelsen av konsekvensene for etatene ikke var godt nok kommunisert i forkant og at dette førte til frustrasjon over normale merkostnader i etableringsfasen og usikkerhet om modellen. Riksrevisjonens vurdering er at det er kritikkverdig at departementet ikke har sørget for at omorganiseringen av anskaffelsesområdet har medført mer effektiv ressursbruk eller sørget for at vurderingen av omorganiseringen var realistisk. Riksrevisjonen mener at omorganiseringen av anskaffelsesområdet med opprettelsen av tjenestesenteret samlet sett har medført økt ressursbruk og økte kostnader for virksomhetene. Prosjektet anbefaler at departementet vurderer om det kan være alternative plasseringer av felles tjenestesenter, inkludert vertskap hos største bruker (i kostnad), tilbakeføring av tjenesteansvaret til virksomhetene, eller organisert som felles tjenestesenter for flere departementsområder.

Det skal nå gjennomføres en ekstern evaluering for å legge til rette for eventuelle behov for justeringer i modellen for sikre best mulig måloppnåelse frem mot 10-årsmerket i 2027. Evalueringen skal ta utgangspunkt i målsettingene i oppdraget til NHN i juni 2016: effektivisering og tilrettelegging for større og sterkere kompetansemiljøer, og gjennom dette å få en kvalitets- og kompetanseheving i administrative tjenesteledd. Målsettingene utgjør tre hovedområder (med underpunkter):

1. Effektivisering/gevinstrealisering
2. Styringsmodell av felles tjenestesenter
3. Kvalitet i tjenester og kundetilfredshet

Evalueringen skal gjennomføres i løpet av 2023. Denne kan avdekke mulige behov for justeringer i tjenestesentermodellen.

Konklusjon: Prosjektet viser til at det i 2023 gjennomføres en evaluering av konsernmodellen for administrative tjenester i den sentrale helseforvaltningen og anbefaler at eventuelle endringer i organisering avventer evalueringen.

11.8 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Prosjektet mener at det kan være aktuelt å vurdere om deler av oppgavene som ivaretas av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, bør integreres i et samlet registermiljø og eventuelt også ses i sammenheng med Hdirs ansvar for å beslutte om et kvalitetsregister får nasjonal status. Det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre. Servicemiljøet bidrar til å sikre drift og god utnyttelse av de medisinske kvalitetsregistrene. Servicemiljøet er et operativt kompetansemiljø med hovedsete i SKDE, og med regionale enheter i alle RHFene. De regionale enhetene har særskilt ansvar for kvalitetsregistre tillagt sitt RHF. Servicemiljøet veileder de medisinske kvalitetsregistrene og tilbyr kompetanse innen: opprettelse og drift; jus og personvern; finansiering; IKT; kvalitetsforbedring; statistikk; analyse og rapportering; og kommunikasjon.

Konklusjon: Prosjektet foreslår at det vurderes om deler av oppgavene til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre på sikt bør integreres i et samlet registermiljø i forvaltningen.

11.9 Forum for faglig normering

Det er mange aktører som, i ulik grad, er involvert i utviklingen og bruken av regelverk, faglige normer og veiledende produkter. Blant annet viser Htil til behovet for å se tilsynsfunksjonen i tettere sammenheng med regelverksutvikling og utvikling av faglige normer og standarder. I dag utvikler Hdir de faglige normene og standardene for tjenestene, mens tilsynet operasjonaliserer de samme kravene og etablerer kriterier for forsvarlighet i den konkrete saken/situasjonen. De påpeker at hvilken instans som definerer hva som er forsvarlige tjenester kan fremstå uklart for tjenestene og opinionen. I tillegg etterspør Htil mer effektivt samspill og bruk av den kunnskapen som etableres i de ulike etatene og virksomhetene i forvaltningen. Eksempelvis skal tilsyn være kunnskaps- og risikobasert samtidig som tilsyn også etablerer kunnskap gjennom sine erfaringer og funn.

Prosjektet har vurdert muligheten for å etablere et forum for regelverksutvikling og faglig normering. Vi viser til Petroleumstilsynets Regelverksforum, en trepartsarena for utvikling og vedlikehold av HMS regelverket. I denne modellen møtes representanter for arbeidstakerne, arbeidsgivere og myndighetene (bransje og myndighetene). Dette gir anledning til å følge regelverksarbeidet løpende og gir alle parter muligheten til å uttale seg om viktige forslag underveis. Dette fører til større grad av eierskap til og konsensus om endelige forslag til regelverksutvikling. I tillegg bidrar forumet til å klargjøre forskjeller og likheter mellom ulike virksomheter og deres behov.

En mulig etablering av et forum for faglig normering i helsesektoren vil kunne skape en felles arena og koordineringsplattform for å drøfte behov og gjøre prioriteringer i utviklingen av regelverk, faglige normer og annet veiledende materiale. Partssamarbeidet vil kunne bestå av myndighetsetaten/Hdir, kunnskapsetaten/FHI, Htil, statsforvalterne, RHFene, kommunene og profesjonsorganisasjonene mm. Ved etablering av et slik forum bør det bli ledet av, og forankret i, myndighetsetaten.

Konklusjon: Prosjektet vurderer at etablering av et forum for faglig normering bør utredes videre, enten som del av et gjennomføringsprosjekt eller på lenger sikt. Som del av utredninger bør man vurdere organiseringen av Petroleumstilsynets Regelverksforum og erfaringer som er gjort i dette arbeidet og i tilsvarende arbeid i andre sektorer. Forslaget bør vurderes i lys av en eventuell oppgaveoverføring fra helseforvaltningen til RHFene (jf. kapittel 8).

12 Helhetlige modeller

Prosjektet har i kapitlene ovenfor konkludert med følgende:

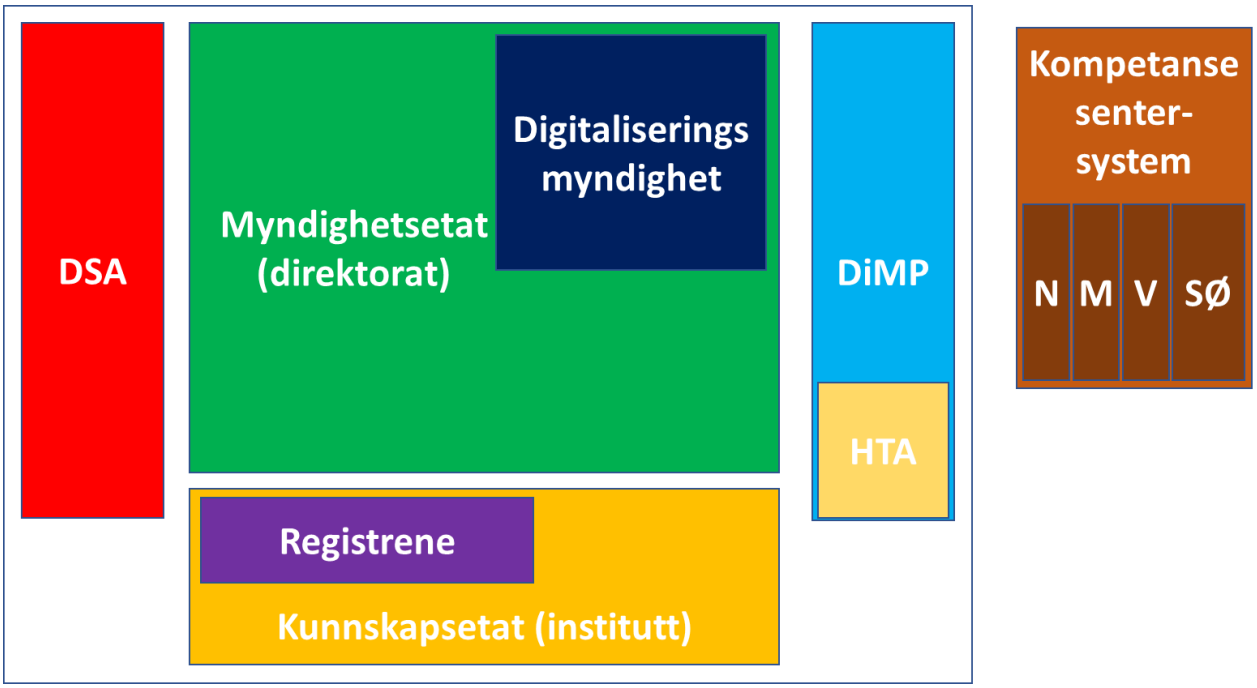
- Etablering av en heldekkende myndighetsetat på helseområdet og en spisset kunnskapsetat med ansvar for kunnskapsoppsummeringer og forskning basert på endring i organisering av Hdir og FHI
- Etablering av et direktorat for medisinske produkter (DiMP), med utgangspunkt i SLV, som får ansvar for legemidler og medisinsk utstyr
- Opprettholdelse av DSA som en egen etat
- Behov for utredning av en mer samlet organisering av kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten med mål om å etablere et mer helhetlig kompetansesentersystem.

Prosjektet viser til anbefalingen om at vurderingen av den organisatoriske forankringen av myndighetsoppgavene innen digitalisering og organisatorisk forankring av et samlet helseregistermiljø bør vurderes som en del av helheten av organisasjonsendringer og skisserer nedenfor tre modeller hvorav den første er primæranbefalingen.

Prosjektet viser til anbefalingen om at et samlet registermiljø bør inkludere registrene som i dag forvaltes av Hdir og FHI, og i tillegg integrere Kreftregisteret i det samme miljøet for å samle alle de nasjonale helseregistrene i en etat. Prosjektet viser til at Kreftregisteret i dag er et helhetlig kreftkunnskapsmiljø som bør holdes samlet når det flyttes inn i forvaltningen. Om man benytter tilsvarende logikk som for vurderingen av oppgavene i FHI – så vil det være mulig å dele miljøet ved Kreftregisteret ved at selve registerforvaltningen samles med de andre nasjonale registrene, mens øvrig miljø legges til kunnskapsetaten/FHI (evt. kunne man også vurdert å legge ansvaret for screening til myndighetsetaten/Hdir). Prosjektet vurderer imidlertid at det vil være fornuftig å holde miljøet på Kreftregisteret samlet ved en flytting inn i forvaltningen. Det får konsekvenser for vurderingen av alternativer for organisatorisk forankring av registrene siden mye tilsier at det samlede Kreftregisteret bør forankres i en etat som har forsknings- og kunnskapsoppgaver. Nærhet til miljøene som er primærbrukere for registrene, dvs. både myndighetsetat og kunnskapsetat, må også tas med i vurderingen av plassering av registerforvaltningen.

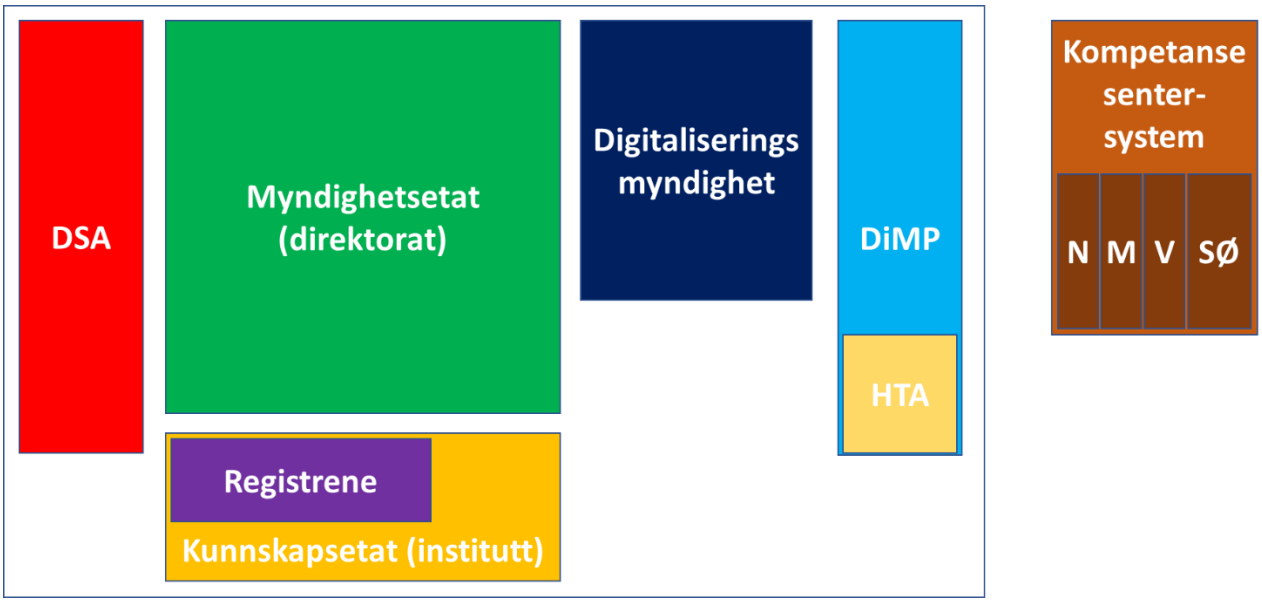
Prosjektets helhetlige vurdering er at et samlet registermiljø som inkluderer Kreftregisteret, bør forankres i kunnskapsetaten. Det innebærer også at det størrelsesmessig blir bedre balanse mellom kunnskapsetaten og myndighetsetaten. Det gjør det dessuten mer hensiktsmessig å samle myndighetsoppgavene innen digitaliseringsområdet i myndighetsetaten. I tillegg kan en egen digitaliseringsmyndighet uten forvaltning av helseregistre og med den avskalling som allerede er gjort mot NHN fra E-helse, bli for svak som et selvstendig myndighetsorgan i en modell med en heldekkende myndighetsetat som dekker de fleste andre myndighetsoppgaver i helseforvaltningen. Denne anbefalte modellen kan illustreres som følger:

Figur 12.1: En samlet myndighetsetat med ansvar for myndighetsoppgaver innen digitaliseringsområdet og en kunnskapsetat med forvaltning av helseregistrene.



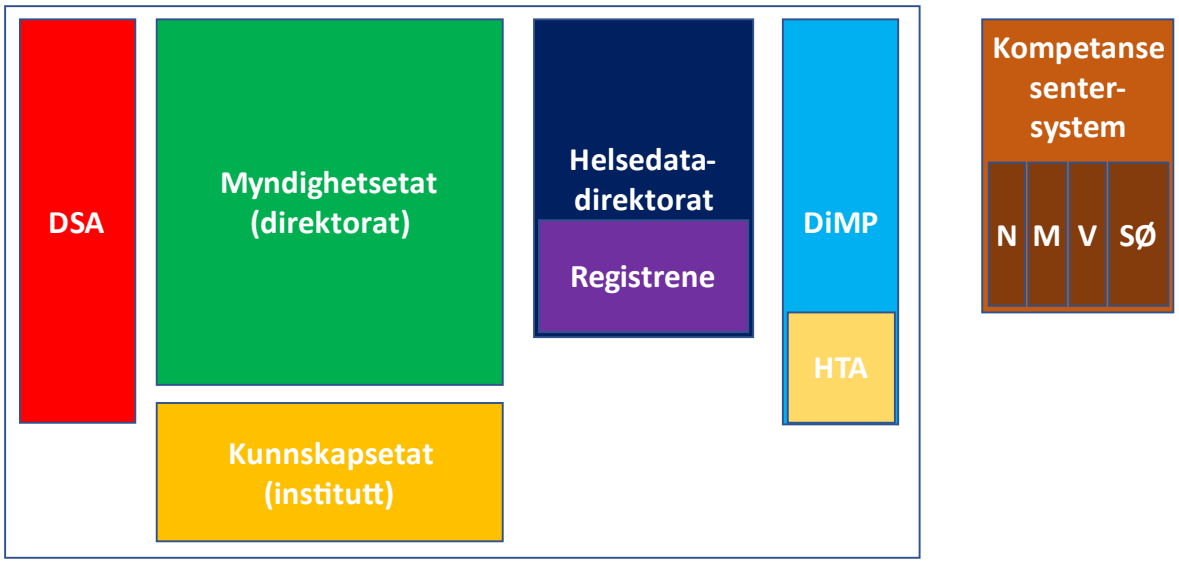
Som et alternativ vurderer prosjektet at det kan være aktuelt å opprettholde en egen myndighetsetat innen digitaliseringsområdet samtidig som registrene samles i en kunnskapsetat. Den viktigste begrunnelsen for ikke å innlemme digitalisering i myndighetsetaten er at kompleksiteten og omfanget av organisasjonsendring og organisasjonsutvikling som vil bli nødvendig for den samlede myndighetsetaten i seg selv vil være krevende, samt at det kan være behov for en egen etat med spissere oppdrag knyttet til digitaliseringsutfordringene framover. Samtidig kan det være riktig at digitalisering nå sees sammen med øvrige myndighetsoppgaver all den tid det uansett blir en omstilling og organisasjonsutvikling av myndighetsetaten. Ved et alternativ som skissert i dette avsnittet, bør ansvarsdelingen mellom digitaliseringsmyndigheten, myndighetsetaten og direktoratet for medisinske produkter vurderes i gjennomføringsprosjektet med mål om å samle ansvar som krever kompetanse om digital transformasjon. Denne alternative modellen kan illustreres som følger:

Figur 12.2: En kunnskapsetat med forvaltning av helseregistrene og en egen etat med ansvar for myndighetsoppgaver innen digitaliseringsområdet.



Dersom Kreftregisteret ikke innlemmes i et samlet registermiljø i denne omgang, vil begge modellene ovenfor fortsatt være aktuelle. Det kan også være aktuelt å legge forsknings- og kunnskapsoppgavene ved Kreftregisteret til kunnskapsetaten/FHI, og registerforvaltningsansvaret sammen med de øvrige nasjonale registrene. I disse tilfellene vil en modell med et eget «helsedatadirektorat» med samlet ansvar for forvaltning av helseregistrene og for myndighetsoppgaver innen digitalisering kunne være aktuell. Arbeidet med å samordne registrene og gjøre helsedata lettere tilgjengelig for sekundær og tertiær bruk vil være omfattende oppgaver som vil kreve høy lederoppmerksomhet. Prosjektet vurderer at det er argumenter for å samle oppgavene med digitalisering og forvaltning av helseregistre i en egen organisasjon. Et slikt «helsedatadirektorat» vil kunne være en «uavhengig» leverandør av helsedata til hele helseforvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og andre brukere av helsedata, inkludert innen forskning og næringsutvikling. Denne alternative modellen kan illustreres som følger:

Figur 12.3: Et «helsedatadirektorat» med ansvar for myndighetsoppgaver innen digitaliseringsområdet og forvaltning av helseregistrene.



I tillegg har prosjektet vurdert et alternativ der digitalisering inngår som en del av en helhetlig myndighetsetat og forvaltning av registrene også legges til den samme myndighetsetaten. Dette er en annen modell som også vil bidra til både å samle registrene i én organisasjon og til å samle myndighetsoppgaver innen digitalisering og forvaltning av registrene. En begrunnelse for å legge registrene til myndighetsetaten er at denne vil ha følge med/overvåkningsansvaret og er tillagt oppgaver innen registeranalyser og statistikk. Samtidig vil dette alternativet gi en stor myndighetsetat med en stor bredde i porteføljen av oppgaver og dermed et stort styrings-/lederspenn. Et slikt alternativ vil være mindre aktuelt om hele Kreftregisteret skal inngå i et samlet registermiljø.

Prosjektet understreker at for alle tre alternative helhetlige modeller som er illustrert over så er anbefalingen at etatene organiseres på nivå 2 og er direkte underordnet departementet.

Samtlige av organisasjonsmodellene krever en særlig vurdering av retningslinjene for lokalisering (se også seksjon 13.6) som stipulerer at dersom det skal etableres *nye virksomheter* eller det skal foretas *vesentlige endringer i ansvarsforhold mellom virksomhetene* skal det vurderes plassering utenfor Oslo og noen av de større byene. I hvilken grad de foreslåtte endringene utløser et slik krav bør vurderes nærmere. Imidlertid viser prosjektet til noen preliminære vurderinger knyttet til de ulike alternativene i tabell 12.1.

Tabell 12.1: Tolkning av retningslinjer for lokalisering i forbindelse med ulike etater.

Etat:	Omfattet:	Begrunnelse:
Helsedatadirektorat	Ja	En vesentlig endring i ansvarsforhold. Samtidig er Hdirs og FHIs registre allerede geografisk plassert i Trondheim og Bergen, og Helsedataservice på Tynset og i Trondheim.
Digitaliseringsmyndighet	Nei	Videreføring av E-helse, med navneendring uten vesentlige endringer i ansvarsforhold.
DiMP	Nei	Videreføring av SLV, med navneendring uten vesentlige endringer i ansvarsforhold
Myndighetsetat	Trolig ikke	Tar utgangspunkt i en eksisterende etat (Hdir), med nye oppgaver overført fra FHI. Hdir har i dag geografisk spredning med kontorer i både Oslo og Trondheim. Gitt myndighetsetatens nære samarbeid med departementet vil plassering utenfor Oslo være krevende, på lik linje med direktoratene i andre sektorer.
Kunnskapsetat	Trolig ikke	Tar utgangspunkt i en eksisterende etat (FHI), men med færre og endrede oppgaver. Samtidig innlemmes Kreftregisteret og registrene i FHI. Etaten får dermed geografisk spredning med kontorer i både Oslo, Bergen, Trondheim og Levanger.
DSA	Nei	Videreføres som i dag

13 Gjennomføring av eventuelle organisasjonsendringer

13.1 Ansvar for videre oppfølging

Prosjektet avsluttes når rapporten legges frem for statsråd. Etter politisk beslutning vil gjennomføring og oppfølging av organisatoriske endringer og tiltak følge ordinær ansvarsfordeling i departementet. Det anbefales å etablere et eget gjennomføringsprosjekt for videre oppfølging.

13.2 Kommunikasjon

Prosjektets kommunikasjonsstrategi har vært bygget på prinsipper om åpenhet, tilgjengelighet, proaktivitet, likebehandling og delegering. Det har vært regelmessig kontakt med ledelsen og tillitsvalgte ved de berørte etatene gjennom orienteringsmøter. Prosjektet erfarer at denne tilnærmingen har vært konstruktiv for prosessen.

Det legges til grunn at eventuelle organisasjonsendringer og tiltak offentliggjøres gjennom revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2023. I forbindelse med dette bør departementet vurdere hvordan ledelsen i etatene skal bli informert. Det bør også utarbeides en kommunikasjonsplan for håndtering av media.

Prosjektets rapport er et internt arbeidsdokument og bør ikke offentliggjøres. Imidlertid bør HOD utarbeide en sluttrapport med beskrivelse og begrunnelse av forslagene som kan brukes som en del av det videre arbeidet, og eventuell offentliggjøring.

13.3 Økonomiske og administrative konsekvenser

Prosjektet har lagt til grunn at økonomiske og administrative kostnader knyttet til gjennomføringen av endringsforslag vil kunne håndteres innenfor gjeldende budsjettramme. På sikt vil implementeringen av prosjektets anbefalinger skape grunnlag for innsparinger. Omfang og plan for gevinstrealisering må utredes nærmere.

Omstillingskontander omfatter bl.a.

- Infrastruktur/samkjøring av IKT-systemer/arkiv
- Rene fysiske flyttekostnader
- Nyansettelser der miljøer og kritisk/riktig kompetanse ikke vil være dekkende i ny organisasjon
- Bruk av personellressurser – særlig innen HR og mtp. budsjettmessige endringer.
- Lokalisering/lokaler
    - eventuelt nye lokaler (se også 13.6 om retningslinjer for lokalisering utenfor Oslo).
    - ombygging av lokaler, tilpasninger
    - leiekontrakter om leie av lokaler som løper, men som man ikke får avviklet.
- Ved flytting av virksomhet fra et regnskapsprinsipp til et annet (f.eks. fra privat/foretak til forvaltning) vil det erfaringsvis oppstå utfordringer f.eks. knyttet underdekning av overheadkostnader, pensjonspremie etc.

Det må opprettes nye budsjettposter og midler fra eksisterende etater må rammeoverføres. Prosjektet foreslår at endringer og tiltak som følger av rapporten gis som skriftlig orientering i RNB for 2023, mens de budsjettmessige endringene håndteres i den ordinære budsjettprosessen for 2024, alternativt i RNB for 2024. Det innebærer at omposteringer og

fordelinger innenfor gjeldende budsjettrammer legges frem i rammefordelingsforslaget for statsbudsjettet for 2024. Stortinget orienteres på den måten både gjennom RNB for 2023 og gjennom statsbudsjettet for 2024.
Etat- og eierstyringen i departementet bør gjennomgås i lys av organisasjonsendringer (se også kapittel 10).

13.4 Endringer i lov- og forskrifter

Overføring av ansvar- og oppgaver mellom eksisterende etater og tildeling av ansvar og oppgaver til nye etater vil kunne kreve endringer i lov og forskrift. Det må gjøres en gjennomgang for å identifisere behov for endringer når endelig valg av modeller er tatt. Forslag til lov- og forskriftsendringer må sendes på høring før fremleggelse av Prop L for Stortinget og fastsettelse av endringsforskrifter.

Høringsnotat bør sendes ut så snart forslaget er behandlet av Stortinget i RNB, med frist senest i begynnelsen av september. Prop. L bør da kunne legges frem for Stortinget i begynnelsen av november. Dersom endringene skal tre i kraft 1. januar 2024, må lovforslaget behandles av Stortinget i år. Det kan foreslås delt ikrafttredelse dersom det er behov for å utsette noen av endringene.

13.5 Særskilt om arbeidsrettslige forhold og vurderinger

Organisasjonsendringer i forvaltningen utløser en rekke bestemmelser i lov og forskrift knyttet til tillitsvalgte og arbeidstakermedvirkning. Etter politisk beslutning og behandling i regjering vil eventuelle endringer være omfattet av hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse, og også i enkelte av tilfellene, arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse (arbeidsmiljølovens kapittel 16). Vi vil her kort redegjøre for de videre prosesser. Det understrekes at orienteringen er på et overordnet plan, slik at alle ulike spørsmål som kan dukke opp i en slik prosess ikke blir berørt.

Det er ikke medbestemmelse på politiske beslutninger, jf. hovedavtalen § 4 nr. 1, mens gjennomføringen av politiske beslutninger er gjenstand for medbestemmelse, jf. hovedavtalen § 4 nr. 3. Medbestemmelse utøves i all hovedsak i den enkelte virksomhet, men i en prosess som denne vil det være et unntak dersom flere virksomheter blir berørt. Dersom flere virksomheter under HOD blir berørt, skal det inngås en omstillingsavtale.

Innledningsvis vises det også til statsansattelovens § 16 nr. 1, som slår fast at alle statsansatte må finne seg i endringer i arbeidsoppgaver – dette gjelder uavhengig av hvor i staten de er ansatt. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

«1) Alle statsansatte og embetsmenn i departementene og ved Statsministerens kontor har plikt til å finne seg i omorganiseringer og endringer i arbeidsoppgaver og ansvar.»

Det er noen begrensninger i hva arbeidstakerne kan settes til. Eventuelle endringer skal i utgangspunktet ikke endre på stillingens grunnpreg, arbeidstakerne skal ha oppgaver på «samme nivå». Samtidig vil det f.eks. ved sammenslåing av virksomheter og avdelinger være slik at særlig ledere vil måtte finne seg i å miste lederoppgaver. Dette vil ofte skje gjennom en frivillig avtale, eller som en endringsoppsigelse.

De politiske beslutningene som fattes i denne saken kan være av ulik art, noe som også vil føre at hovedavtalen, arbeidsmiljøloven. og statsansatteloven vil måtte anvendes noe ulikt. Nedenfor vil det bli redegjort for de ulike typetilfellene:

Alle endringer skjer internt i en virksomhet

Hvis endringene skjer internt i en virksomhet, vil det være virksomheten selv som er ansvarlig for utøvelse av medbestemmelse etter hovedavtalen. Arbeidstakerne vil måtte finne seg i endringer, jf. statsansattelovens § 16, med de begrensninger som eventuelt følger av stillingens grunnpreg.

Virksomheter under HOD slås sammen helt eller delvis

Dersom virksomheter under HOD slås helt eller delvis sammen (f.eks. ved at avdelinger overføres), skal det inngås med omstillingsavtale, jf. hovedavtalen § 5 nr. 1. Avtalen inngås av HOD, men det vil være tillitsvalgte og arbeidsgivere i den enkelte virksomheten som vil være parter.

En omstillingsavtale etter hovedavtalen regulerer hvordan medbestemmelse skal utøves når flere virksomheter er berørt. Avtalen sikrer at tillitsvalgte og arbeidsgivere i de ulike virksomhetene får samtidig informasjon, og får like rettigheter når det gjelder medbestemmelse.

Arbeidstakere vil etter statsansatteloven § 16 nr. 1 måtte finne seg i endringer i arbeidsforholdet. Samtidig vil reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven. kap. 16 også få anvendelse. Dette innebærer at arbeidstakernes arbeidsforhold videreføres med de samme betingelsene som de hadde i sin tidligere stilling. Blant annet innebærer det at lønn og ansiennitet videreføres, med enkelte presiseringer når det gjelder tariffavtalte rettigheter. Arbeidsmiljøloven. §§ 16-5 og 16-6 pålegger mottakende og avgivende arbeidsgiver særlig plikter når det gjelder informasjon og drøftinger med henholdsvis tillitsvalgte og arbeidstakere. Disse reglene kommer i tillegg hovedavtalens regler, men er i stor grad sammenfallende.

Eventuelle ulike rettigheter, eller lønnsforskjeller, mellom ulike virksomheter som blir slått sammen, må løses på ordinær måte gjennom lokale lønnsforhandlinger eller vil bestå som individuelle rettigheter.

Deler av virksomhet blir ført ut av staten

Dersom deler av statlige virksomheter blir ført ut av staten, vil medbestemmelse skje i den virksomhet som blir berørt.

Det skal ikke inngås omstillingsavtale etter hovedavtalen, da virksomheter utenfor staten ikke er omfattet av hovedavtalen i staten.

Reglene om virksomhetsoverdragelse får anvendelse, men i et slikt tilfelle vil arbeidsmiljølovens regler om reservasjonsrett få anvendelse. Reservasjonsretten innebærer at arbeidstakere kan velge å ikke la seg overføre, men da vil samtidig arbeidsforholdet opphøre. I tillegg finnes en ulovfestet rettighet som heter valgrett. Valgrett innebærer at arbeidstaker kan velge å opprettholde sitt tidligere arbeidsforhold.

Arbeidstakere har alltid reservasjonsrett, men kun helt unntaksvis valgrett. Valgrett vil typisk kunne foreligge hvor en overføring vi innebære en svekkelse av ansattes rettigheter. Det typiske er faktisk overføring ut av offentlig sektor, hvor tanken er at ansatte vil kunne få svekkede rettigheter når det gjelder mulighet for omplassering, miste fortrinnsretten og kanskje få svekkede pensjonsrettigheter. For mange vil det også anses å være tryggere å

være ansatt i offentlig sektor, som sjelden nedbemanner, enn i en privat virksomhet som i større grad er avhengig av inntekter, budsjettmidler osv. Utøvelse av valgrett vil innebære at det bestående arbeidsforholdet fortsetter, men det vil kunne foreligge grunnlag for oppsigelse f.eks. hvis arbeidstaker ikke har kvalifikasjoner til å overta arbeidsoppgavene eller hvis den tidligere arbeidsgiveren ikke lenger finnes (eks. når Luftfartsverket ble omdannet til Avinor).

Et annet moment som ofte vi være av stor betydning for arbeidstakerne er mulighetene for å videreføre en offentlig pensjonsordning. En offentlig ytelsesbasert pensjonsordning anses ofte som bedre enn en privat innskuddspensjon. Samtidig vil en god del virksomheter slik som HFene i dag, også ha offentlig ytelsesbasert ordning.

Virksomheter utenfor staten blir slått sammen i ny enhet.

I et slikt tilfelle vil ikke den statlige hovedavtalen gjelde, men det kan være andre hovedavtaler som får anvendelse, jf. f.eks. at det er egen hovedavtale for virksomheter i Spekter.

Reglene om virksomhetsoverdragelse vil gjelde fullt ut, men her vil det sjelden foreligge en valgrett.

Virksomheter legges ned

Ved nedleggelse av en virksomhet, og dersom oppgavene ikke videreføres i annen virksomhet, vil det foreligge grunnlag for oppsigelse. Disse prosesser vil måtte skje i den enkelte virksomhet, og departementet vil være klageorgan.

Arbeidstakere som blir sagt opp vil på visse vilkår ha fortrinnsrett til annen stilling i staten, jf. statsansatteloven § 24.

13.6 Særskilt om lokalisering

Dersom det skal etableres nye virksomheter eller det skal foretas vesentlige endringer i ansvarsforhold mellom virksomhetene, er det i retningslinjene for lokalisering av statlige virksomheter fastsatt at det skal vurderes plassering utenfor Oslo og noen av de større byene. Om såkalte strukturendringer står følgende i veilederen:

«Utgreiingar om strukturendringar skal innehalde ei vurdering av mogleg utflytting frå Oslo, sentrale kommunar i Oslo-området eller andre av dei største byane. Som eit minimum skal det gjerast ei vurdering av om delar av verksemda og løysing av oppgåver som ligg i Oslo, sentrale kommunar i Oslo-området eller andre av dei største byane kan flyttast ut.»

Vedlegg 1. Utredninger og informasjonsgrunnlag

Vurderingsgrunnlag for rapporten

Prosjektet har utarbeidet en rekke notater som danner grunnlag for anbefalingene i rapporten:

1) I første fase av prosjektet ble beslutningsnotat med tre forrapporter utarbeidet. Beslutningsnotatet ble godkjent av statsråden. Forrapportene som ble utarbeidet var som følger:
    - Forrapport om strålevern og atomsikkerhet (Desember 2022)
    - Forrapport om digitalisering (Desember 2022)
    - Forrapport om helsemyndighetene (Desember 2022)
2) I den andre og siste fase av prosjektet ble fem forrapporter utarbeidet som grunnlag for diskusjon i prosjektets styringsgruppe:
    - Delrapport om Helseberedskap og helsekriser (Februar 2023)
    - Delrapport om helsedata (Februar 2023)
    - Delrapport om myndighetsoppgavene på digitalisering (Februar 2023)
    - Delrapport om støtte til kommunene (Februar 2022)
    - Delrapport om kompetansesentrene (Februar 2022)
    - Delrapport om direktorat for medisinske produkter (Februar 2022)
    - Delrapport om organiseringen av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (Februar 2022)
3) Delrapportene og prosjektets endelige rapport er behandlet av styringsgruppen. Konklusjonspunkter er dokumentert i møtereferater:
    - Møtereferat (16.01.23)
    - Møtereferat (20.01.23)
    - Møtereferat (26.01.23)
    - Møtereferat (09.02.23)
    - Møtereferat (16.02.23)
    - Møtereferat (14.02.23)
    - Møtereferat (03.03.23)
    - Møtereferat (08.03.23)

Informasjonsgrunnlag for prosjektets kartlegging

1) Oppdrag til de berørte etatene
    - Oppdrag til Hdir, FHI, SLV, DSA og E-helse (av 22. september 2022). Leveranse: 1) beskrivelse av etatenes ulike roller, ansvar og oppgaver; 2) vurdering av områder hvor det er uklarhet, overlapp eller gråsoner; og 3) vurdering av andre forslag knyttet til organisering, roller og ansvar som kan bidra til å nå regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken. Etatene ble også bedt om å fylle inn en tabell med beskrivelse av oppgaver og deres omfang innen ulike tema og roller/funksjoner.
    - Tilleggsbestilling til Hdir, FHI, SLV, DSA og E-helse (av 4. oktober 2022). Leveranse: Beskrivelse og vurdering av hvordan andre land har organisert helseforvaltningen innen de funksjoner og områder etatene har ansvar for i Norge. Kartlegging bør inkludere Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Nederland, samt Tysland og Frankrike om det er relevant.
    - Bestilling til Hdir og FHI (av 9. desember 2022). Leveranse: Utfyllende informasjon om etatenes arbeid med digitalisering og helseregistre.
    - Tilleggsbestilling til Hdir, FHI, SLV, DSA og E-helse (av 6. januar 2022). Leveranse: Organisasjonskart som inkluderer oversikt over antall årsverk i alle de ulike organisatoriske enhetene. Årsverk inkluderer i denne sammenheng både fast ansatte, midlertidig ansatte og innleid personell. Oversikten bør ta utgangspunkt i virksomhetens «normalsituasjon» og inkludere underliggende virksomheter.

2) Skriftlige innspill *(per invitasjon)*
    - Tilgrensende etater og virksomheter (23. september 2022)
    - Pasientorganisasjoner og fagorganisasjoner (15. oktober 2022).

3) Dialogmøter og informasjonsmøter
    - Felles informasjonsmøte med de berørte etatene og tilgrensende virksomheter (19. september 2022)
    - Felles dialogmøte med de berørte etatene (20. oktober 2022)
    - Tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter (3. november 2022, 25. november 2022, 23. januar 2023).
    - Dialogmøter med andre departementer om forvaltningsgjennomgangen og særlig ifm. strålevern og atomsikkerhet, inkl. Nærings- og fiskeridepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, HOD (11. oktober 2022, 3. november 2022, 23. november 2022)

4) Intervjuer (fysiske møter og digitalt)
    - Ledelsen i de berørte etatene (oktober 2022)
    - Ledelsen i tilgrensende virksomheter (oktober – november 2022)
    - Andre aktører, inkl. pågående prosesser og utredninger (september 2022 – januar 2023) og internasjonale aktører (UKHSA, Sundhedsdatastyrelsen) (januar 2023).

5) Utredninger og gjennomgang av eksisterende saksgrunnlag
    - Koronakommisjonens rapporter, internevaluering av beredskapsarbeid i departementet, skriftlige innspill til det pågående arbeidet med Helseberedskapsmeldingen,
    - Annet relevant materiale, inkl. saksgrunnlag fra tidligere forvaltnings-gjennomganger

6) Innspill gjennom avdelingsforeleggelser
    - Forrapporter og beslutningsnotat (november 2022)
    - Utkast til endelig rapport (mars 2022)

Vedlegg 2. Internasjonal sammenligning

	Norge	Sverige	Finland	Danmark	Storbritannia	Nederland	Frankrike	Tyskland
Myndighet helsetjenester	Helsedirektoratet	Socialstyrelsen	**Departementet** Institutt for helse og velferd (THL)	Sundhedsstyrelsen	**Departmentet** NICE	**Departementet**	**Departementet** HAS	**Departementet**
Finansiering - helsetjenester	Helsedirektoratet Helfo	Socialstyrelsen	Institutt for helse og velferd (THL)	Sundhedsstyrelsen Sundhedsdata-styrelsen	**Departmentet**	Nederlandske Helsemyndighet (Nederlandse Zorgautoritet)		
Myndighet folkehelse	Helsedirektoratet	Folkhälsomyndigheten	**Departementet** Institutt for helse og velferd (THL)	Sundhedsstyrelsen	**Departementet**	**Departementet**	**Departementet** Santé publique France	**Departementet** Federal Centre for Health EducationBZgA
Beredskap	Helsedirektoratet	Socialstyrelsen	**Departementet**	Sundhedsstyrelsen	UK Health Security Agency (UKHSA)	**Departementet**		
Helseregistre	Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet	Socialstyrelsen	Findata KanTa	Sundhedsdata-styrelsen				
Smittevern	Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet	Folkhälsomyndigheten		Sundhedsstyrelsen Statens Seruminstitutt	UK Health Security Agency	Nasjonalt institutt for folkehelse og miljø (RIVM)	Santé publique France	Robert Koch instituttet
E-helse/ digitalisering	Direktoratet for e-helse	e Hälsomyndigheten	Departementet	Sundhedsdatastyrelsen	NHS E&I	Departementet NICTIZ	Digital Health Agency	
Legemidler - godkjenning	Legemiddelverket	Läkemedelsverket	Legemiddelverket - (FIMEA)	Lægemiddelstyrelsen	Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)	Medicines Evaluation Board	ANSM	ZLG
Legemidler - refusjon	Legemiddelverket Nye metoder	Tandvårds och läkemedels-förmånsverket (TLV)	Pharmaceuticals Pricing Board FINCHTA/FIMEA HTA	Lægemiddelstyrelsen Medicinrådet	NICE (National Institute for Health and Care Excellence	Zorginsitut, ZIN	HAS The French National Authority for Health (Haute Autorite de Sante)	IQWIG Institute for Quality and Efficiency in Health Care G-BA The Federal Joint Committee
Metodevurdering / HTA	Legemiddelverket Folkehelseinstituttet	SBU	FINCHTA/FIMEA HTA		NICE	Zorginsitut, ZIN	HAS	IQWIG
Strålevern og atomsikkerhet	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet	Strålsäkerhets-myndigheten (SSM)	Strålsäkerhets-centralen	Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen (SST) Nukleært Beredskap (NUC) i Beredskabs-styrelsen (BRS)	Office for Nuclear Regulation (ONR), Health and Safety Executive (HSE), UK Health Security Agency (UKHSA)	Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbeschermin g (ANVS)	Autorité de sûreté nucléaire (ASN)	BMUV

Vedlegg 3. Sammenligning av den sentrale helseforvaltningen i Danmark og Norge[10,11,12]

Norge	Årsverk	Danmark	Årsverk
Helse- og omsorgsdepartementet	240	Indenrigs- og sunhedsministeriet	270
Statens helsetilsyn	110	Styrelsen for Patientsikkerhed	653
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)	25		
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)	150	Styrelsen for Patientklager	261
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten	151		
Helsedirektoratet	724	Sundhedsstyrelsen	257
Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)	408		
Bioteknologirådet	8	Nationalt Center for Etik	32
Folkehelseinstituttet	1136	Statens Serum Institut	902
		Nationalt Genom Center	64
Statens legemiddelverk	335	Lægemiddelstyrelsen	558
Direktoratet for e-helse	232	Sundhedsdatastyrelsen	258
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet	144		
Totalt:	**3663**	**Totalt:**	**3255**

[10] Tallene er usikre og hentet fra flere kilder og på ulike tidspunkt. Årsverk i Hdir, FHI, E-helse, SLV og DSA ble oppgitt av etatene per oppdrag i januar 2023. Årsverk i NPE og Helseklage er hentet fra årsrapportene i 2021. Årsverk i Htil. og UKOM er mottatt fra etatsstyrende avdeling. Tall fra Danmark er mottatt fra Innenrigs- og Sunhedsministeriet 02.03.23.

[11] Det er ulikheter i sektoransvar i Norge og Danmark, bl.a.:

- Forsyningssikkerhet: blir i Danmark ivaretatt av Styrelsen for forsyningssikkerhet (SFOS) under Justisministeriet for å ivareta forsyningssikkerhet i stort, inkl. lager, innkjøp, produksjon, analyse, strategi, testing osv.
- Atomsikkerhet: I Danmark er strålevern i Sundhedsstyrelsen, mens atomsikring og sikkerhetskontroll i Beredskapsstyrelsen under Forsvarsministeriet. Kjernefysiske anlegg ligger under Utdannelses- og Forskningsministeriet.

[12] Samfunnsoppdraget og kjerneoppgaver i etatene er også ulike. Eksempelvis:

- Folkehelseinstituttet dekker flere fagområderenn Statens Serum Institutt.
- Bioteknologirådet er et rådgivende organ og høringsinstans innen saker som omfatter etiske og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av moderne bioteknologi, i motsetning til National Center for Etik som har et bredere samfunnsoppdrag. Sistnevnte skal være en felles nasjonal forankring for etiske vurderinger på tvers av forskning, data, helse og bioteknologi. Etaten understøtter fire uavhengige organer: Det Etiske Råd, Dataetisk Råd, National Videnskabsetisk Komité og de Videnskapsetiske Medicinske Komiteer.

Vedlegg 4. Tabell med oppgaver i Hdir og FHI (Hdir – svart, FHI – rødt)

	Smittevern og miljømedisin (helsevern)	Folkehelse/ helsefremmende arbeid	Helse- og omsorgstjenester
Myndighet **Normer** **Krav**	- Forvaltning av regelverk, inkl. fortolkning. Utarbeide handlingsplaner, strategier mv. - Utvikling av normerende produkter - Godkjenninger - Sektoransvar krisehåndtering - Godkjenning av skadedyrbekjempere - Veiledere/ retningslinjer forankret i forskrift (smittevernveileder, vaksinasjonsveileder, tuberkuloseveileder)	- Forvaltning av regelverk, inkl. fortolkning. Utarbeide handlingsplaner, strategier mv. - Normerende arbeid - Følge med på kommunenes og fylkeskommunenes folkehelsearbeid - Forvaltning av tilskuddsordninger. - Bevillinger og godkjenninger - Veileder til utredningsinstruksen	- Forvaltning av regelverk, inkl. fortolkning. Forvaltning av tilskuddsordninger, - Forvaltning av finansieringsordninger (tilskudd, DRG og helserefusjoner) - Utvikling av normerende produkter - Spesialistgodkjenning - Autorisasjon helsepersonell - Forskrift og veileder ledelse og kvalitetsforbedring. - Utarbeide handlingsplaner, strategier mv. - Pakkeforløp/pasientforløp
Gjennomfører **Følge med/overvåke** **Rådgivning**	- Utredningsarbeid og råd til forvaltningen - Oppfølging av programmer, strategier mv, - Myndighetssamarbeid og nettverk - Løpende rådgivning til helsepersonell - Utredninger og råd til forvaltning - Faglig innspill til strategier, handlingsplaner - Epidemietteretning, varslingspunkt og vaktordninger - Utbruddsoppklaring - Informasjon og kampanjer vaksinasjon - Løpende rådgivning til helsepersonell - Myndighetssamarbeid og nettverk - (Laboratorietjenester – må vurderes)	- Utredningsarbeid - Oppfølging av programmer, strategier mv, (inkl. Folkehelseprogrammet) - Iverksette faglige råd og anbefalinger - Råd (kosthold, ernæring, diabetes mv) - Myndighetssamarbeid og nettverk - Informasjon og kampanjer - Folkehelseprogrammet - Faglig innspill til strategier, handlingsplaner - Befolkningsundersøkelser - Folkehelsepolitisk rapport - Myndighetssamarbeid og nettverk	- Utredningsarbeid - Oppfølging av programmer, strategier, meldinger mv, - Implementering av nasjonale produkter - Tjenesterettet rådgivning, - Legemiddelberedskap - Myndighetssamarbeid og nettverk - Spesialistutdanning - Samordne arbeid med pasientsikkerhet - Rådgivning ved kriser og katastrofer - Helsebiblioteket - Internasjonalt samarbeid og global helse
Registeranalyser **Statistikk**	- Overvåking og deskriptiv statistikk - Rapportering (ECDC og WHO) - Kvalitetssikring av registre	- Folkehelserapporten, folkehelseprofiler, kommunehelseprofiler - Folkehelseundersøkelsene i fylkene - Statistikkpublisering og -presentasjon - NCD-indikatorer - Sykdomsbyrdeanalyser - Kvalitetssikring av registre	- Framskrivninger - Helseøkonomiske analyser - Kvalitetssikring av registre - Styringsdata til helsetjenestene - Utarbeidelse av kvalitetsindikatorer/statistikk - Analyser av helsesystem og -tjenesten

Kunnskapsoppsummering **Forskning**	- HTA for vaksiner - Kunnskapsoppsummering - Effektevaluering av smitteverntiltak - Forskning - Forskningsformidling	- Forskning - Forskningsformidling - Effektevaluering av tiltak - Kunnskapsoppsummeringer - Metodestøtte til kommuner (kunnskapsløft) - Biobank og biobanktjenester	- HTA og metodevurderinger - Kunnskapsoppsummeringer - Indikatorer for bærekraftsmålene (SDG) - Forskning - Metodestøtte til kommuner (kunnskapsløft) - Forskningsformidling